

?Снижается ли мышечный тонус при поражении периферического двигательного нейрона.

!+да

!нет

?Повышается ли мышечный тонус при поражении центрального двигательного нейрона

!+да

!нет

?Появляются ли патологические рефлексы при поражении пирамидного пути

!+да

!нет

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения внутренней капсулы:

!+гемиплегия

!монопарез

!анестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения внутренней капсулы:

!+гемигипестезия

!монопарез

!гипестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения внутренней капсулы:

!+гемипарез

!моноплегия

!гиперестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!спастический тонус

!+гипотония мышц

!гипестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+снижение сухожильных рефлексов

!патологические знаки

!анестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+гипотрофия мышц

!наличие патологических рефлексов

!гипертонус мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+«биоэлектрическое молчание» на ЭМГ

!рефлексы орального автоматизма

!при исследовании электровозбудимости отсутствует реакция перерождения мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+при исследовании электровозбудимости имеется реакция перерождения мышц

!гипертрофия мышц

!снижение поверхностных рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+атония мышц

!повышение глубоких рефлексов

!«ритм частокола» на ЭМГ

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического двигательного нейрона:

!+отсутствие глубоких рефлексов

!отсутствие поверхностных рефлексов

!гиперестезия

?Укажите, какие патологические пирамидные рефлексы могут появляться на верхней конечности

!рефлекс Бабинского

!рефлекс Оппенгейма

!+рефлекс Россолимо

?Укажите, какие патологические пирамидные рефлексы могут появляться на верхней конечности

!+рефлекс Якобсона-Ласка

!рефлекс Шеффера

!рефлекс Маринеску-Радовичи

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения коры головного мозга: а) монопарез, б) гемипарез, в) парапарез, г) парез мышц зоны иннервации периферического нерва

!+а

!б

!в

!г

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения внутренней капсулы: а) монопарез, б) гемипарез, в) парапарез, г) парез мышц зоны иннервации периферического нерва

!а

!+б

!в

!г

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения спинного мозга: а) монопарез, б) гемипарез, в) парапарез, г) парез мышц зоны иннервации периферического нерва

!а

!б

!+в

!г

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения периферического нерва: а) монопарез, б) гемипарез, в) парапарез, г) парез мышц зоны иннервации периферического нерва

!а

!б

!в

!+г

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении центрального двигательного нейрона: а) спастический тонус, б) гиперрефлексия, в) атония мышц, г) патологические рефлексы, д) гипотрофия мышц, е) клonusы стоп и коленных чашечек

!а, в, г, е

!а, в, д, е

!+а, б, г, е

!а, б, д, е

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении периферического двигательного нейрона: а) спастический тонус, б) гиперрефлексия, в) атония мышц, г) патологические рефлексы, д) гипотрофия мышц, е) клonusы стоп и коленных чашечек

!+в, д

!в, г

!б, д

!б, г

?Укажите, какие из перечисленных патологических рефлексов могут появляться на верхней конечности: а) рефлекс Бабинского, б) рефлекс Россолимо, в) рефлекс Оппенгейма, г) рефлекс Жуковского, д) рефлекс Якобсона-Ласка

!б, в, д, е

!+б, г, д, е

!а, б, в, г

!а, б, в, г

?Укажите, какие из перечисленных патологических рефлексов могут появляться на нижней конечности: а) рефлекс Бабинского, б) рефлекс Россолимо, в) рефлекс Оппенгейма, г) рефлекс Жуковского, д) рефлекс Якобсона-Ласка

!б, в, д, е

!б, г, д, е

!а, б, в, г

!+а, б, в, г

?Появляются ли гипотрофии мышц при поражении центрального двигательного нейрона

!да
!+нет

?Появляются ли патологические рефлексы при поражении периферического двигательного нейрона

!да
!+нет

?Появляются ли синкинезии при поражении центрального двигательного нейрона

!+да
!нет

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического нерва:

!+гипотрофия мышц
!патологические рефлексы
!арефлексия поверхностных рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения периферического нерва:

!защитные рефлексы
!+арефлексия глубоких рефлексов
!арефлексия поверхностных рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+гемипарез
!прозопарез
!понижение мышечного тонуса в паретичных мышцах

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+альтернирующие синдромы
!"биоэлектрическое молчание" на ЭМГ
!гипотрофия мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+повышение мышечного тонуса в паретичных мышцах
!понижение мышечного тонуса в паретичных мышцах
!гиперестезия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+повышение сухожильных рефлексов
!понижение мышечного тонуса
!повышение кожных рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+понижение кожных рефлексов
!понижение периостальных рефлексов
!гипертрофия мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения пирамидного пути:

!+защитные рефлексы
!гипотрофия мышц

!при исследовании электровозбудимости имеется реакция перерождения мышц

?Какие из перечисленных рефлексов вызываются на верхних конечностях

!+рефлекс с двуглавой мышцы

!рефлекс с четырёхглавой мышцы

!креMASTERный рефлекс

?Какие из перечисленных рефлексов вызываются на верхних конечностях

!+рефлекс с трехглавой мышцы

!ахиллов рефлекс

!конъюнктивальный рефлекс

?Какие из перечисленных рефлексов вызываются на верхних конечностях

!коленный рефлекс

!+карпорадиальный рефлекс

!мандибулярный рефлекс

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для двустороннего поражения пирамидных путей в грудном отделе: а) спастический тонус, б) клонусы стоп, в) гипотония мышц, г) отсутствие коленных и ахилловых рефлексов, д) парез нижних конечностей:

!в, г, д

!+а, б, д

!а, в, д

!а, г, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения периферических нервов нижних конечностей: а) спастический тонус, б) клонусы стоп, в) гипотония мышц, г) отсутствие коленных и ахилловых рефлексов, д) парез нижних конечностей:

!+в, г, д

!в, б, д

!а, б, д

!а, г, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения внутренней капсулы: а) гемиплегия, б) поза Вернике-Манна, в) периферический парез руки, г) фибриллярные подергивания

!+а, б

!а, в

!в, г

!в, б

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения С4-С8 сегментов спинного мозга: а) гемиплегия, б) поза Вернике-Манна, в) периферический парез руки, г) фибриллярные подергивания

!а, б

!+в, г

!а, в

!в, б

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для двустороннего поражения пирамидных путей в верхнем шейном отделе: а) тетрапарез, б) гипотрофия, в) патологические пирамидные рефлексы, г) спастический тонус, д) периферический парез руки, е) отсутствие сухожильных рефлексов, ж) отсутствие кожных рефлексов, з) парез

!+а, в, г, з

!б, д, е, з

!а, б, г, з

!б, г, е, з

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения плечевого сплетения: а) тетрапарез, б) спастический тонус, в) патологические пирамидные рефлексы, г) гипотрофия, д) периферический парез руки, е) отсутствие сухожильных рефлексов, ж) отсутствие кожных рефлексов, з) парез

!+б, д, е, з

!а, в, г, з

!а, б, г, з

!б, г, е, з

?Повышается ли мышечный тонус при поражении периферического двигательного нейрона

!да

!+нет

?Повышаются ли сухожильные рефлексы при поражении периферического двигательного нейрона

!да

!+нет

?Появляются ли гипотрофии мышц при поражении периферического двигательного нейрона

!+да

!нет

?Появляются ли фибриллярные подергивания при поражении периферического двигательного нейрона

!+да

!нет

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!пониженный тонус

!+повышенный тонус

!гипорефлексия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+гиперрефлексия

!гипотония мышц

!атония мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+патологические рефлексy

!физиологические рефлексy

!гипорефлексия

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+защитные рефлексy

!безусловные рефлексy

!низкий мышечный тонус

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+синкинезии

!гиперкинезы

!«ритм частокола» на ЭМГ

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+клонусы

!гипертрофия мышц

!гипотония мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+отсутствие кожных рефлексов

!отсутствие сухожильных рефлексов

!отсутствие патологических рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения центрального двигательного нейрона:

!+отсутствие суставных рефлексов

!отсутствие сухожильных рефлексов

!отсутствие периостальных рефлексов

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+гипотония мышц

!гипертонус мышц

!гипертрофия мышц

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+фибриллярные подергивания

!клонусы

!условные рефлексy

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+отсутствие сухожильных рефлексов

!клонические подергивания

!«биоэлектрическое молчание» на ЭМГ

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+гипотрофия мышц

!гипертрофия мышц

!«биоэлектрическое молчание» на ЭМГ

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+«ритм частокола» на ЭМГ

!патологические рефлексы

!периостальные рефлексы

?Выберите из перечисленных симптомов признаки поражения передних рогов спинного мозга:

!+отсутствие кожных рефлексов

!отсутствие фибриллярных подергиваний

!«биоэлектрическое молчание» на ЭМГ

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения внутренней капсулы: а) гипотония мышц, б) патологические рефлексы, в) отсутствие брюшных рефлексов, г) гипотрофия мышц, д) изменение сухожильных рефлексов?

!+б, в, д

!а, в, д

!а, г, д

!б, г, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения переднего корешка спинного мозга: а) гипотония мышц, б) патологические рефлексы, в) отсутствие брюшных рефлексов, г) гипотрофия мышц, д) изменение сухожильных рефлексов?

!+а, г, д

!б, в, д

!а, в, д

!б, г, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении пирамидных путей в шейном отделе: а) тетрапарез, б) повышение мышечного тонуса, в) парез разгибателей стопы, г) отсутствие ахиллова рефлекса, д) высокие сухожильные рефлексы, е) клонус стоп?

!+а, б, д, е

!в, г

!в, г, е

!б, в, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении переднего корешка L₅-S₁ сегмента спинного мозга: а) тетрапарез, б) повышение мышечного тонуса, в) парез разгибателей стопы, г) отсутствие ахиллова рефлекса, д) высокие сухожильные рефлексы, е) клонус стоп?

!+в, г

!а, б, д, е

!в, г, е

!б, в, д

?У больной с нижним парапарезом определяются: в ногах спастический тонус, повышение сухожильных рефлексов, рефлекс Бабинского, защитные рефлексы; отсутствуют брюшные рефлексы. Какой характер парапареза

!+центральный

!периферический

?У больной с нижним парапарезом определяются: в ногах спастический тонус, повышение сухожильных рефлексов, рефлекс Бабинского, защитные рефлексы; отсутствуют брюшные рефлексы Где локализуется поражение

!+двустороннее поражение кортико-спинального пути на уровне грудного отдела спинного мозга

!двустороннее поражение кортико-бульбарного пути на уровне грудного отдела спинного мозга

!левостороннее поражение кортико-спинального пути на уровне грудного отдела спинного мозга

!левостороннее поражение кортико-бульбарного пути на уровне грудного отдела спинного мозга

?У больного в неврологическом статусе определяется тетрапарез: на руках - гипотрофия, гипотония мышц, отсутствие рефлексов; на ногах - спастичность мышц, высокие сухожильные рефлексы, рефлекс Бабинского. Какой характер пареза

!+периферический парез рук и центральный парез ног

!периферический парез ног и центральный парез рук

!центральный парез рук и периферический парез ног

!периферический парез рук и периферический парез ног

!центральный парез рук и центральный парез ног

?У больного в неврологическом статусе определяется тетрапарез: на руках - гипотрофия, гипотония мышц, отсутствие рефлексов; на ногах - спастичность мышц, высокие сухожильные рефлексы, рефлекс Бабинского. Где локализуется поражение

!C₁-C₄

!+C₅-D₁

!D₁-D₄

!D₅-L₁

!L₅-S₁

?У больного - плегия правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. Какой характер пареза

!центральный

!+периферический

?У больного - плегия правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. Где локализуется поражение

!центральный мотонейрон

!+периферический мотонейрон

?У больного - плегия правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. Где локализуется поражение

!клетки задних рогов спинного мозга

!+клетки передних рогов спинного мозга

!клетки боковых рогов спинного мозга

?У больного - плегия правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. Где локализуется поражение

!C₁-C₄

!+C₅-D₁

!D₁-D₄

!D₅-L₁

!L₅-S₁

?У больного - плегия правой руки со снижением мышечного тонуса и сухожильных рефлексов, фибриллярными подергиваниями, гипотрофией мышц. Где локализуется поражение

!C₅-D₁ слева

!+C₅-D₁ справа

?Развивается ли бульбарный паралич при поражении IX, X, XII пар черепных нервов?

!+да

!нет

?Имеет ли ядро XII пары черепных нервов одностороннюю корковую иннервацию?

!+да

!нет

?Развивается ли лагофthalm при центральном поражении VII пары черепных нервов?

!да

!+нет

?В какой области ствола мозга располагаются ядра глазодвигательного нерва

!варолиев мост

!+ножка мозга

!продолговатый мозг

?В какой области ствола мозга располагается ядро отводящего нерва

!+варолиев мост

!ножка мозга

!продолговатый мозг

?Укажите, при поражении какой пары черепных нервов наблюдается птоз

!VI

!V

!+III

?Укажите, при поражении какой пары черепных нервов наблюдается косоглазие

!+III

!XII

!VII

?Укажите, при поражении какой пары черепных нервов наблюдается косоглазие

!+VI

!V

!VIII

?Укажите, при поражении какой пары черепных нервов наблюдается косоглазие

!IX

!+IV

!XI

?Укажите, при поражении каких пар черепных нервов возникает дисфагия

!V-VI

!+IX-X

!VII-VIII

!XI-XII

?Укажите, при поражении какой пары черепных нервов возникает дизартрия

!V

!XI

!+XII

!IX

?Укажите, какой парой черепных нервов иннервируются мимические мышцы

!V

!VI

!+VII

!VIII

?Укажите, какой нерв осуществляет иннервацию сфинктера зрачка

!+III

!IV

!V

!VI

!II

?Укажите, при поражении каких черепных нервов возникает диплопия

!II

+ !III

!I

?Укажите, при поражении каких черепных нервов возникает диплопия

!+VI

!VII

!VIII

?Укажите, при поражении каких черепных нервов возникает диплопия

!+IV

!V

!IX

?Какие из перечисленных симптомов характерны для бульбарного паралича: а) дисфагия; б) симптомы орального автоматизма) в) дисфония; г) атрофия и фибриллярные подергивания языка; д) отсутствие глоточного рефлекса; е) насильственный смех и плач; ж) дизартрия

!+а, в, г, д, ж

!а, б, в, е, ж

!а, б, в, д, ж

!а, б, г, д, ж

?Какие из перечисленных симптомов характерны для псевдобульбарного паралича: а) дисфагия; б) дизартрия; в) дисфония; г) атрофия и фибриллярные подергивания языка; д) отсутствие глоточного рефлекса; е) насильственный смех и плач; ж) симптомы орального автоматизма

!а, в, г, д, ж

!+а, б, в, е, ж

!а, б, в, д, ж

!а, б, г, д, ж

?Возникает ли расходящееся косоглазие при поражении глазодвигательного нерва

!+да

!нет

?Может ли возникнуть диплопия в горизонтальной плоскости при поражении глазодвигательного и отводящего нервов?

!+да

!нет

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:

!дисфагия

!+сглаженность лобных складок

!дислексия

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:

!+сглаженность носогубных складок

!дисфония

!девиация языка в здоровую сторону

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:

!+лагофтальм

!синдром Броун-Секара

!экзофтальм

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:

!+симптом Белла

!затруднение высывания языка

!симптом Бехтерева

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:

!+симптом «паруса»
!девиация языка в сторону поражения
!симптом «треножника»

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:
!+невозможность свиста
!невозможность речи
!мидриаз

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:
!+гиперакузия
!дизартрия
!страбизм

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:
!+снижение надбровного рефлекса
!снижение подбородочного рефлекса
!снижение глоточного рефлекса

?Выберите признаки, характерные для поражения лицевого нерва:
!+симптом Ревийо
!синдром Рейно
!птоз

?Укажите, при поражении каких ядер глазодвигательного нерва возникает мидриаз:
!крупноклеточное ядро
!+мелкоклеточное ядро
!ядро Перлеа

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва:
!сходящееся косоглазие
!+мидриаз
!симптом Ревийо
!ограничение движения глазного яблока кнаружи

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва: !+ограничение движения глазного яблока вверх
!ограничение движения глазного яблока кнаружи
!сходящееся косоглазие

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва:
!+расходящееся косоглазие
!миоз
!гиперакузия

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва:
!+птоз
!миоз
!глиоз

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва:
!+диплопия

!аллодиния

!сходящееся косоглазие

?Выберите признаки, характерные для поражения глазодвигательного нерва:

!+ограничение движения глазного яблока внутрь

!симптом «паруса»

!симптом «треножника»

?Выберите симптомы, характерные для альтернирующего синдрома Вебера: а) Мидриаз, б) Сходящееся косоглазие, в) Расходящееся косоглазие, г) Ограничение движения глазного яблока кнаружи, д) Ограничение движения глазного яблока внутрь, е) Диплопия, ж) Птоз, з) Лагофthalm, и) Симптом Ревийо, к) Невозможность свиста, л) Симптом Белла, м) Гемиплегия:

!+а, в, д, е, ж, м

!а, в, д, е, з, м

!б, г, е, з, и, к, л, м

!б, г, д, е, з, к, л, м

!а, б, в, г, д, л, м

?Выберите симптомы, характерные для альтернирующего синдрома Фовилля: а) Мидриаз, б) Сходящееся косоглазие, в) Расходящееся косоглазие, г) Ограничение движения глазного яблока кнаружи, д) Ограничение движения глазного яблока внутрь, е) Диплопия, ж) Птоз, з) Лагофthalm, и) Симптом Ревийо, к) Невозможность свиста, л) Симптом Белла, м) Гемиплегия:

!а, в, д, е, ж, м

!а, в, д, е, з, м

!+б, г, е, з, и, к, л, м

!б, г, д, е, з, к, л, м

!а, б, в, г, д, л, м

?Наступает ли птоз при поражении отводящего нерва

!да

!+нет

?Наступает ли дисфагия при поражении IX-X пар черепных нервов?

!+да

!нет

?Иннервируются ли жевательные мышцы тройничным нервом

!+да

!нет

?При поражении каких мышц возникает расстройство глотания:

!+мягкого неба

!жевательных

!мимических

?При поражении каких мышц возникает расстройство глотания:

!твердого неба

!+надгортанника

!языка

?При поражении каких нервов возникает дисфония

!XII

!+X

!XI

?При поражении какого нерва наблюдается расходящееся косоглазие

!VI

!V

!+III

?Каким нервом иннервируются мимические мышцы

!+VII

!XII

!V

?При поражении какого нерва наблюдается симптом Белла

!III

!IV

!V

!VI

!+VII

?При поражении каких нервов возникает диплопия

!VII

!V

!+VI

?При поражении каких нервов возникает диплопия

!+III

!II

!V

?При поражении каких нервов возникает диплопия

!+IV

!VII

!IX

?Какие признаки, помимо гемиплегии, характерны для синдрома Вебера

!парез XII пары черепных нервов

!парез IX-X пар черепных нервов

!парез VII пары черепных нервов

!+парез III пары черепных нервов

?Какие симптомы характерны для бульбарного паралича

!глоточный рефлекс вызывается

!+периферический парез подъязычного нерва

!надбровный рефлекс отсутствует

?Какие симптомы характерны для бульбарного паралича

!+глоточный рефлекс отсутствует

!симптомы орального автоматизма

!корнеальный рефлекс отсутствует

?Какие симптомы характерны для бульбарного паралича

!+дисфагия

!дисбазия

!глоточный рефлекс вызывается

?Какие симптомы характерны для бульбарного паралича

!+дизартрия

!дизестезия

!парез III пары черепных нервов

?Какие симптомы характерны для бульбарного паралича

!+афония

!афазия

!апраксия

?При поражении каких черепных нервов возникает сходящееся косоглазие

!III

!V

!+VI

?При поражении какого нерва наблюдается уклонение нижней челюсти в сторону?

!VII

!III

!XI

!+V

?Укажите, на каком уровне ствола мозга расположены ядра III пары черепных нервов:

!+ножки мозга

!варолиев мост

!продолговатый мозг

?Укажите, на каком уровне ствола мозга расположены ядра IV пары черепных нервов:

!+ножки мозга

!варолиев мост

!продолговатый мозг

?Укажите, на каком уровне ствола мозга расположены ядра VII пары черепных нервов:

!ножки мозга

!+варолиев мост

!продолговатый мозг

?Укажите, на каком уровне ствола мозга расположены ядра X пары черепных нервов:

!ножки мозга

!варолиев мост

!+продолговатый мозг

?Укажите, на каком уровне ствола мозга расположены ядра XII пары черепных нервов:

!ножки мозга

!варолиев мост

!+продолговатый мозг

?Дисфагия характерна для поражения следующего нерва:

!+IX-X

!VII

!III

?Расходящееся косоглазие характерно для поражения следующего нерва:

!IX-X

!VII

!+III

?Лагофthalm характерен для поражения следующего нерва:

!IX-X

!+VII

!III

?Птоз характерен для поражения следующего нерва:

!IX-X

!VII

!+III

?У больного определяются лагофthalm, симптомы Белла, Ревийо, опущен угол рта справа; повышение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса, симптом Бабинского слева. Как называется этот синдром

!синдром Вебера

!+синдром Мийяра-Гублера

!синдром Бриссо-Секара

!синдром Фовилля

!синдром Шмидта

?У больного определяются лагофthalm, симптомы Белла, Ревийо, опущен угол рта справа; повышение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса, симптом Бабинского слева. Где локализуется очаг поражения

!ножка мозга справа

!+варолиев мост справа

!продолговатый мозг справа

!Варолиев мост слева

!продолговатый мозг слева

?У больного определяются лагофthalm, симптомы Белла, Ревийо, опущен угол рта справа; повышение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса, симптом Бабинского слева. Где локализуется очаг поражения

!ножки мозга

!+варолиев мост

!продолговатый мозг

?У больного развились птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие справа и левосторонний гемипарез. Как называется синдром

!+синдром Вебера

!синдром Мийяра-Гублера

!синдром Бриссо-Секара

!синдром Фовилля

!синдром Шмидта

?У больного развились птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие справа и левосторонний гемипарез. Где локализуется очаг?

!+ножка мозга справа

!варолиев мост справа

!продолговатый мозг справа

!варолиев мост слева

!ножка мозга слева

?У больного развились птоз, мидриаз, расходящееся косоглазие справа и левосторонний гемипарез. Где локализуется очаг?

!+ножки мозга

!варолиев мост

!продолговатый мозг

?У больного: слева сходящееся косоглазие, лагофthalm, отсутствует надбровный рефлекс, опущен угол рта; справа - спастический гемипарез. Как называется этот синдром

!синдром Вебера

!синдром Мийяра-Гублера

!синдром Бриссо-Секара

!+синдром Фовилля

!синдром Шмидта

?У больного: слева сходящееся косоглазие, лагофthalm, отсутствует надбровный рефлекс, опущен угол рта; справа - спастический гемипарез. Где локализуется процесс?

!ножки мозга

!+варолиев мост

!продолговатый мозг

?У больного: слева сходящееся косоглазие, лагофthalm, отсутствует надбровный рефлекс, опущен угол рта; справа - спастический гемипарез. Где локализуется процесс?

!ножка мозга справа

!варолиев мост справа

!продолговатый мозг справа

!+варолиев мост слева

!ножка мозга слева

?Зависит ли статика от нормальной деятельности мозжечка

!+да

!нет

?Сопровождается ли поражение мозжечка нарушением координации

!+да

!нет

?Может ли больной с поражением мозжечка правильно соразмерять свои движения

!да

!+нет

?Изменяется ли мышечный тонус при поражении мозжечка

!+да

!нет

?Замедляется ли темп активных движений при поражении паллидонигральной системы

!+да

!нет

?Наблюдаются ли гиперкинезы при поражении экстрапирамидной системы

!+да

!нет

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения мозжечка

!дизартрия

!+скандированная речь

!гипомимия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения мозжечка

!брадикинезия

!+дисметрия

!дизартрия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения мозжечка

!+атония

!атрофия

!арефлексия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения мозжечка

!+атаксия

!апраксия

!афазия

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!мышечная гипертония

!+мышечная гипотония

!мышечная атрофия

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+интенционный тремор
!постуральный тремор
!тремор покоя
!кинетический тремор

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+скандированная речь
!миоклония
!гипертонус

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении паллидонигральной системы

!+мышечная гипертония
!гиперкинезы
!апраксия

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении паллидонигральной системы

!+гипомимия
!интенционный тремор
!скандированная речь

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении паллидонигральной системы

!+ахейрокинез
!дизартрия
!мышечная гипотония

?Соотнесите метод исследования «пальценосовая проба» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!+б, в, ж
!б, г, ж
!б, г, е
!б, в, е
!б, в, г

?Соотнесите метод исследования «поза Ромберга» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!а
!а, г
!+г
!в
!в, е

?Соотнесите метод исследования «проба на диадохокинез» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение

координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!а

!а, г

!г

!+в

!в, е

?Соотнесите метод исследования «проба Бабинского» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!а

!+а, е

!г, е

!в

!в, е

?Соотнесите метод исследования «проба Шильдера» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!а

!+д

!д, е

!в

!в, г

?Соотнесите метод исследования «указательная проба» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!ж

!б, ж, е

!д, ж

!+б, ж

!б, г

?Соотнесите метод исследования «пяточно-коленная проба» к определению соответствующего симптома: а) асинергия; б) мимопопадание; в) нарушение координации движений в верхних конечностях; г) нарушение статики; д) гиперметрия, дисметрия; е) нарушение координации движений в нижних конечностях; ж) интенционный тремор:

!ж

!+б, ж, е

!д, ж

!б, ж

!б, г, е

?Характерны ли гиперкинезы при поражении экстрапирамидной системы

!+да

!нет

?Возникает ли нистагм при поражении мозжечка

!+да

!нет

?Может ли измениться почерк при поражении мозжечка

!+да

!нет

?Входит ли красное ядро в состав экстрапирамидной системы

!+да

!нет

?Может ли наблюдаться мышечная гипертония при поражении мозжечка

!да

!+нет

?Является ли спастическая гипертония мышц характерным симптомом поражения экстрапирамидной системы

!да

!+нет

?Может ли изменяться почерк у больных с поражением экстрапирамидной системы

!+да

!нет

?Могут ли наблюдаться пропульсии при поражении экстрапирамидной системы

!+да

!нет

Наблюдается ли скандированная речь при поражении паллидонигральной системы

!да

!+нет

?По каким путям поступают импульсы от проприорецепторов в мозжечок

!спиноталамический путь

!+путь Флексига

!путь Монакова

?По каким путям поступают импульсы от проприорецепторов в мозжечок

!+путь Говерса

!вестибулоспинальный путь

!путь Голля

?Через какие ножки мозжечка проводятся импульсы от коры больших полушарий

!верхние

!+средние

!нижние

?Какие расстройства речи возникают при поражении мозжечка

!+скандированная речь

!афония

!монотонная речь

?Какие расстройства мышечного тонуса возникают при поражении паллидонигральной системы

!гипотония

!+пластическая гипертония

!спастическая гипертония

?Какой вид нарушения координации движений возникает при поражении червя мозжечка

!+статическая атаксия

!динамическая атаксия

?Как нарушается походка при поражении паллидонигральной системы

!спастическая

!спастико-атактическая

!гемипаретическая

!+шаркающая

?Какое расстройство речи возникает при поражении экстрапирамидной системы

!дизартрия

!+тихая

!эксплозивная

?Какое расстройство речи возникает при поражении экстрапирамидной системы

!+монотонная

!громкая

!спутанная

?Какое расстройство речи возникает при поражении экстрапирамидной системы

!звонкая

!скандированная

!+афония

?Какие подкорковые ядра поражаются при стриарном синдроме

!бледный шар

!+хвостатое ядро

!черная субстанция

?Какие подкорковые ядра поражаются при стриарном синдроме

!таламус

!+скорлупа

!ядро Льюиса

?Как изменяется мышечный тонус при паллидонигральном синдроме

!гипотония мышц

!+гипертония мышц

!тонус мышц не изменяется

?Укажите, какие из перечисленных проводящих путей проходят через верхние ножки мозжечка: а) оливо-мозжечковый путь; б) дентато-рубро-спинальный путь; в) путь от ядер задних столбов; г) спинно-мозжечковый путь Говерса; д) ретикуло-мозжечковый путь; е) лобно-мосто-мозжечковый, ж) вестибуло-мозжечковый; з) спинно-мозжечковый путь Флексига; и) затылочно-височно-мосто-мозжечковый путь:

!б, в

!б, в, г

!е, и

!+б, г

!а, в, г, д, е

?Укажите, какие из перечисленных проводящих путей проходят через средние ножки мозжечка: а) оливо-мозжечковый путь; б) дентато-рубро-спинальный путь; в) путь от ядер задних столбов; г) спинно-мозжечковый путь Говерса; д) ретикуло-мозжечковый путь; е) лобно-мосто-мозжечковый, ж) вестибуло-мозжечковый; з) спинно-мозжечковый путь Флексига; и) затылочно-височно-мосто-мозжечковый путь:

!б, г

!е, ж, з

!+е, и

!е, з

!а, в, г, д, е

?Укажите, какие из перечисленных проводящих путей проходят через нижние ножки мозжечка: а) оливо-мозжечковый путь; б) дентато-рубро-спинальный путь; в) путь от ядер задних столбов; г) спинно-мозжечковый путь Говерса; д) ретикуло-мозжечковый путь; е) лобно-мосто-мозжечковый, ж) вестибуло-мозжечковый; з) спинно-мозжечковый путь Флексига; и) затылочно-височно-мосто-мозжечковый путь:

!б, г

!б, в, г

!е, и

!+а, в, д, ж, з

!а, в, г, д, е

?Зависит ли состояние мышечного тонуса от функции экстрапирамидной системы

!+да

!нет

?Сопровождается ли поражение стриарной системы понижением мышечного тонуса

!+да

!нет

?Возникает ли мышечная гипертония при поражении паллидонигральной системы

!+да

!нет

?Наблюдаются ли гиперкинезы при поражении хвостатого ядра

!+да

!нет

?Проходят ли через красное ядро нервные импульсы к мозжечку?

!да

!+нет

?Возникают ли гиперкинезы при поражении красного ядра

!+да

!нет

?Характерна ли для поражения паллидонигральной системы гиперрефлексия

!да

!+нет

?Наблюдается ли гипомимия при поражении хвостатого ядра

!да

!+нет

?Характерна ли гипомимия для поражения паллидонигральной системы

!+да

!нет

?Характерен ли интенционный тремор для поражения паллидонигральной системы

!да

!+нет

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении хвостатого ядра

!мышечная гипертония

!+мышечная гипотония

!брадикинезия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов наблюдаются при поражении хвостатого ядра

!+гиперкинезы

!гипомимия

!аграфия

?Укажите, какие симптомы возникают при поражении паллидонигральной системы

!+амимия

!мышечная гипотония

!мышечные атрофии

?Укажите, какие симптомы возникают при поражении паллидонигральной системы

!+пластическая ригидность

!спастическая ригидность

!мышечная гипотония

?Укажите, какие симптомы возникают при поражении паллидонигральной системы

!+брадикинезии

!апраксия

!гиперакузия

?Укажите, какие симптомы возникают при поражении паллидонигральной системы

!+пропульсии

!гипотрофия

!мышечная гипотония

?Укажите, какие симптомы возникают при поражении паллидонигральной системы

!+тремор покоя

!интенционный тремор

!гиперкинезы

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+мышечная гипотония

!миоклонии

!мышечная гипертония

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+интенционный тремор

!тремор покоя

!гиперкинезы

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+скандированная речь

!пластическая ригидность

!шаркающая походка

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+неустойчивость в пробе Ромберга

!гиперкинезы

!брадикинезия

?Укажите, какие симптомы наблюдаются при поражении мозжечка

!+асинергия Бабинского

!патологический знак Бабинского

!симптом Бехтерева-Менделя

?Какие из перечисленных проводящих путей относятся к афферентным связям мозжечка: а) дентато-рубро-спинальный, б) путь Флексига, в) лобно-мостомозжечковый, г) затылочно-височно-мозжечковый, д) путь от ядер задних столбов, е) вестибуло-мозжечковый путь, ж) оливо-мозжечковый путь, з) путь Говерса:

!+б, в, г, д, е, ж, з

!б, е, ж, з

!б, а, в, г, д, е, ж, з

!б, в, г, д, ж, з

!б, г, д, е, ж

?Какие из перечисленных проводящих путей относятся к эфферентным связям мозжечка: а) дентато-рубро-спинальный, б) путь Флексига, в) лобно-мостомозжечковый, г) затылочно-височно-мозжечковый, д) путь от ядер

задних столбов, е) вестибуло-мозжечковый путь, ж) оливо-мозжечковый путь, з) путь Говерса:

!б, в

!г

!+а

!б

!а, в

?У 10-летнего ребенка появились непроизвольные сокращения мышц конечностей, лица и туловища. Насильственные движения возникают в различных частях тела, как в покое, так и при произвольных движениях. Мышечный тонус снижен. Как называется синдром

!+хорея

!атетоз

!тик

!баллизм

!паркинсонизм

?У 10-летнего ребенка появились непроизвольные сокращения мышц конечностей, лица и туловища. Насильственные движения возникают в различных частях тела, как в покое, так и при произвольных движениях. Мышечный тонус снижен. Где локализуется поражение

!+стриарная система

!паллидонигральная система

!мозжечок

!пирамидная система

?Больного беспокоят затруднения при ходьбе. Объективно: гипомимия, замедление темпа произвольных движений, флексорная поза, повышение мышечного тонуса конечностей по пластическому типу, походка мелкими шаркающими шагами, пропульсии при ходьбе. На ЭМГ "залповая активность". Как называется синдром

!хорея

!атетоз

!тик

!баллизм

!+паркинсонизм

?Больного беспокоят затруднения при ходьбе. Объективно: гипомимия, замедление темпа произвольных движений, флексорная поза, повышение мышечного тонуса конечностей по пластическому типу, походка мелкими шаркающими шагами, пропульсии при ходьбе. На ЭМГ "залповая активность". Где локализуется поражение

!стриарная система

!+паллидонигральная система

!мозжечок

!пирамидная система

?У больного отмечаются интенционное дрожание при выполнении пальценосовой пробы справа, гипотония мышц правых конечностей, неустойчивость в пробе Ромберга с отклонением вправо. Где локализуется очаг?

!стриарная система

!паллидонигральная система

!+мозжечок
!пирамидная система

?У больного отмечаются интенционное дрожание при выполнении пальценосовой пробы справа, гипотония мышц правых конечностей, неустойчивость в пробе Ромберга с отклонением вправо. В какой части мозжечка локализуется очаг?

!левая гемисфера
!червь
!ключок
!+правая гемисфера
!узелок

?У больного отмечаются интенционное дрожание при выполнении пальценосовой пробы справа, гипотония мышц правых конечностей, неустойчивость в пробе Ромберга с отклонением вправо. В какой части мозжечка локализуется очаг?

!+полушарие
!червь
!ключок
!узелок

?Возникает ли анестезия всех видов чувствительности при поражении задних столбов?

!да
!+нет

?Нарушается ли глубокая чувствительность при поражении заднего рога

!да
!+нет

?Возникают ли боли при поражении задних корешков?

!+да
!нет

?Нарушается ли глубокая чувствительность при поражении задних корешков?

!+да
!нет

?Нарушается ли поверхностная чувствительность при поражении зрительного бугра

!+да
!нет

?Нарушается ли глубокая чувствительность на лице при поражении ядра спинального тракта тройничного нерва

!да
!+нет

?Возникают ли боли при поражении зрительного бугра

!+да
!нет

?Могут ли быть обонятельные галлюцинации при поражении медиальной поверхности височной доли

!+да

!нет

?Может ли наблюдаться битемпоральная гемианопсия при поражении перекреста зрительных путей

!+да

!нет

?Может ли наблюдаться гомонимная гемианопсия при поражении внутренней капсулы

!+да

!нет

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для "полиневритического" типа расстройства чувствительности

!расстройства чувствительности в соответствующих дерматомах

!+боли в конечностях

!анестезия в проксимальных отделах конечностей

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для "полиневритического" типа расстройства чувствительности

!+анестезия в дистальных отделах конечностей

!гемианестезия

!моноаналгезия

?Укажите, где перекрещиваются проводники поверхностной чувствительности

!+передняя серая спайка спинного мозга

!межолливный слой продолговатого мозга

!задняя серая спайка спинного мозга

?Укажите, где перекрещиваются проводники глубокой чувствительности

!передняя серая спайка спинного мозга

!+межолливный слой продолговатого мозга

!задняя серая спайка спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает астереогноз

!задние рога спинного мозга

!+задние столбы спинного мозга

!верхняя лобная извилина

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает астереогноз

!боковые столбы спинного мозга

!+внутренняя капсула

!задний отдел верхней височной извилины

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает астереогноз

!+задняя центральная извилина

!передние рога спинного мозга

!задние рога спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает астереогноз

!+теменная доля

!височная доля

!передняя центральная извилина

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает сегментарный тип расстройства чувствительности

!+задние рога спинного мозга

!задние столбы спинного мозга

!задняя серая спайка спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает сегментарный тип расстройства чувствительности

!+передняя белая спайка спинного мозга

!передний корешок спинного мозга

!передние канатики спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга возникает сегментарный тип расстройства чувствительности

!+ядро спинального тракта тройничного нерва

!задний отдел заднего бедра внутренней капсулы

!передние рога спинного мозга

?Укажите, при поражении какого участка зрительного пути возникает гетеронимная гемианопсия

!+середина хиазмы

!наружные коленчатые тела

!зрительный нерв

?Укажите, при поражении какого участка зрительного пути возникает гетеронимная гемианопсия

!+наружный угол перекреста

!зрительный тракт

!середина шпорной борозды

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения зрительного бугра:
а) гемиальгии, б) гемиатаксия, в) гиперпатия, г) гемианестезия, д) гемианопсия:

!а, б, в

!а, б, в, д

!+а, б, в, г, д

!а, г, д

!а, б, г, д

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения чувствительных путей во внутренней капсуле: а) гемиальгии, б) гемиатаксия, в) гиперпатия, г) гемианестезия, д) гемианопсия:

!б, в, д

!б, в, г, д

!+б, г, д

!б, в, г

!б, г

?Возникает ли нарушение поверхностной чувствительности при половинном поражении спинного мозга

!+да

!нет

?Наблюдаются ли проводниковые расстройства чувствительности при поперечном поражении грудного отдела спинного мозга

!+да

!нет

?Наблюдаются ли чувствительные расстройства при поражении половины продолговатого мозга

!+да

!нет

?Возникают ли чувствительные расстройства при поражении внутренней капсулы

!+да

!нет

?Наблюдаются ли нарушения глубокой чувствительности при поражении задних столбов спинного мозга

!+да

!нет

?Может ли быть гемиатаксия при поражении зрительного бугра

!+да

!нет

?Возникают ли обонятельные галлюцинации при поражении теменной доли

!да

!+нет

?Может ли быть полная потеря слуха при одностороннем поражении верхней височной извилины

!да

!+нет

?Могут ли быть галлюцинации при раздражении корковой слуховой области

!+да

!нет

?Возможна ли гемианопсия при поражении затылочной доли

!+да

!нет

?Отметьте, какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для поражения задних корешков?

!+боли

!диссоциированное расстройство чувствительности

!гемианестезия

?Отметьте, какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для поражения задних корешков?

!+парестезии

!нарушение глубокой чувствительности при сохранении поверхностной чувствительности

!нарушение поверхностной чувствительности при сохранении глубокой чувствительности

?Отметьте, какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для поражения задних корешков?

!+нарушение глубокой чувствительности

!нарушение всех видов чувствительности по гемитипу

!нарушение глубокой чувствительности в дистальных отделах конечностей

?Отметьте, какие из перечисленных симптомов наиболее характерны для поражения задних корешков?

!+нарушение поверхностной чувствительности

!нарушение поверхностной чувствительности при сохранении глубокой чувствительности

!диссоциированное расстройство чувствительности

?Укажите, где перекрещиваются проводящие пути глубокой чувствительности

!передняя серая спайка

!+продолговатый мозг

!варолиев мост

?Отметьте, какие симптомы характерны для поражения заднего отдела заднего бедра внутренней капсулы

!боль в конечностях, противоположных очагу

!+гемианопсия

!гемиапраксия

?Отметьте, какие симптомы характерны для поражения заднего отдела заднего бедра внутренней капсулы

!гемибаллизм

!гемипарез

!+гемианестезия

?Отметьте, какие симптомы характерны для поражения заднего отдела заднего бедра внутренней капсулы

!+гемиатаксия

!гемиатрофия

!боль в конечностях на стороне очага

?Укажите, при поражении каких отделов центральной нервной системы может наблюдаться афферентный парез

!поражение задних рогов спинного мозга

!+поражение задних столбов спинного мозга

!поражение передней центральной извилины

?Укажите, при поражении каких отделов центральной нервной системы может наблюдаться афферентный парез

!поражение боковых столбов спинного мозга
!+поражение задней центральной извилины
!поражение передних канатиков спинного мозга

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения задней центральной извилины: а) моноанестезия, б) гемианестезия, в) парестезии в противоположной очагу половине тела, г) гемиатаксия, д) гемианопсия, е) гемиалгии, ж) гиперпатия:

!а, в, г

!а, б

!+а, в

!а, б, в

!а, г, д

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения зрительного бугра: а) моноанестезия, б) гемианестезия, в) парестезии в противоположной очагу половине тела, г) гемиатаксия, д) гемианопсия, е) гемиалгии, ж) гиперпатия:

!б, в, д, е, ж

!+б, г, д, е, ж

!б, в, г, д, ж

!б, в, г, е, ж

!б, в, г, д, е, ж

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения заднего корешка спинного мозга: а) понижение всех видов чувствительности сегментарного характера, б) боли, в) диссоциированные расстройства чувствительности:

!а

!+а, б

!а, б, в

!б

!в

?Какие из перечисленных симптомов характерны для поражения заднего рога спинного мозга: а) понижение всех видов чувствительности сегментарного характера, б) боли, в) диссоциированные расстройства чувствительности:

!а

!а, б

!а, б, в

!б

!+в

?Возникают ли нарушения глубокой чувствительности при поражении зрительного бугра

!+да

!нет

?Возникают ли боли при поражении внутренней капсулы

!да

!+нет

?Наблюдаются ли нарушения чувствительности при поражении периферических нервов?

!+да

!нет

?Могут ли возникнуть парестезии при раздражении задней центральной извилины

!+да

!нет

?Наблюдаются ли чувствительные расстройства на лице при поражении Гассерова узла

!+да

!нет

?Может ли нарушаться вкус при поражении лицевого нерва

!+да

!нет

?Наблюдается ли выпадение обоняния при поражении обонятельной луковицы

!+да

!нет

?Возникает ли снижение остроты зрения при поражении глазодвигательного нерва

!да

!+нет

?Возникает ли биназальная гемианопсия при поражении наружных углов хиазмы

!+да

!нет

?Возникают ли зрительные галлюцинации при раздражении лобной доли головного мозга

!да

!+нет

?Возникают ли нарушения глубокой чувствительности при поражении боковых столбов спинного мозга

!да

!+нет

?Укажите, при поражении каких образований мозга может быть нарушение чувствительности по проводниковому типу?

!задние корешки

!поражение серого вещества спинного мозга

!+поражение боковых столбов спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга может быть нарушение чувствительности по проводниковому типу?

!передние корешки

!+поражение половины поперечника спинного мозга

!поражение задних рогов спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга может быть нарушение чувствительности по проводниковому типу?

!поражение задних рогов спинного мозга
!поражение серого вещества спинного мозга
!+поражение всего поперечника спинного мозга

?Укажите, при поражении каких образований мозга может возникать гемианопсия в сочетании с гемианестезией

!+внутренняя капсула
!передняя центральная извилина
!лобная доля

?Укажите, при поражении каких образований мозга может возникать гемианопсия в сочетании с гемианестезией

!+зрительный бугор
!задняя центральная извилина
!затылочная доля

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конского хвоста

!+боли
!гипестезия в верхних конечностях
!функция тазовых органов сохранена

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конского хвоста

!+анестезия на нижних конечностях и в промежности
!спастическая параплегия нижних конечностей
!нижняя вялая параплегия

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конского хвоста

!+функция тазовых органов нарушена
!нижняя спастическая параплегия
!верхняя спастическая параплегия

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конского хвоста

!+утрата всех видов чувствительности в нижней половине тела
!парезы ног по периферическому типу
!функция тазовых органов не нарушена

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конуса

!+нарушение функции тазовых органов
!нарушение поверхностной чувствительности по проводниковому типу
!нижняя вялая параплегия

?Отметьте, какие симптомы наиболее характерны для поражения конуса

!+анестезия в области промежности
!нарушение чувствительности по проводниковому типу
!парезы ног по периферическому типу

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения ветви тройничного нерва: а) гипестезия в области лба и передней волосистой части головы, б) гипестезия половины лица, в) боли, г) герпетические высыпания на лице, д) гипалгезия в окружности носа и рта, е) диссоциированные расстройства чувствительности на лице, ж) гипалгезия в латеральной окружности лица:

!+а, в
!б, в, ж
!д, е, ж
!а, б, в
!а, б

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения Гассерова узла: а) гипестезия в области лба и передней волосистой части головы, б) гипестезия половины лица, в) боли, г) герпетические высыпания на лице, д) гипалгезия в окружности носа и рта, е) диссоциированные расстройства чувствительности на лице, ж) гипалгезия в латеральной окружности лица:

!б, в, д
!+б, в, ж
!д, е, ж
!а, б, ж
!а, е, ж

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения нисходящего ядра тройничного нерва: а) гипестезия в области лба и передней волосистой части головы, б) гипестезия половины лица, в) боли, г) герпетические высыпания на лице, д) гипалгезия в окружности носа и рта, е) диссоциированные расстройства чувствительности на лице, ж) гипалгезия в латеральной окружности лица:

!б, в, ж
!б, е, ж
!+д, е, ж
!а, б, в
!а, б, е

?Больной, 46 лет, в течение нескольких лет страдает хроническим алкоголизмом. Месяц назад появились постепенно нарастающие ощущения ползания мурашек в кистях и стопах и боль в икроножных мышцах. Позднее присоединилось пошатывание при ходьбе, особенно в темноте, стал ронять предметы из рук. Объективно: функция черепных нервов не нарушена. Проба Ромберга положительная при закрытых глазах. Походка атактическая, при ходьбе смотрит на ноги. Объем активных движений рук и ног не ограничен. Мышечная сила снижена в дистальных отделах рук и ног. Мышечный тонус понижен. Аналгезия на кистях и стопах по типу "перчаток" и "чулок". Нарушена вибрационная чувствительность и расстроено мышечно-суставное чувство в пальцах ног. Отмечается болезненность при пальпации по ходу седалищного нерва. Ослаблены карпорадиальные рефлексy. Коленные рефлексy вызываются, снижены, ахилловы отсутствуют. Стопы и кисти отечны, потные, несколько цианотичные, холодные. Где локализуется патологический процесс?

!+периферический нерв
!задний корешок
!задний рог спинного мозга
!передний корешок
!передний рог спинного мозга

?Больной, 46 лет, в течение нескольких лет страдает хроническим алкоголизмом. Месяц назад появились постепенно нарастающие ощущения ползания мурашек в кистях и стопах и боль в икроножных мышцах. Позднее присоединилось пошатывание при ходьбе, особенно в темноте, стал ронять предметы из рук.

Объективно: функция черепных нервов не нарушена. Проба Ромберга положительная при закрытых глазах. Походка атактическая, при ходьбе смотрит на ноги. Объем активных движений рук и ног не ограничен. Мышечная сила снижена в дистальных отделах рук и ног. Мышечный тонус понижен. Аналгезия на кистях и стопах по типу "перчаток" и "чулок". Нарушена вибрационная чувствительность и расстроено мышечно-суставное чувство в пальцах ног. Отмечается болезненность при пальпации по ходу седалищного нерва. Ослаблены карпорадиальные рефлексы. Коленные рефлексы вызываются, снижены, ахилловы отсутствуют. Стопы и кисти отечны, потные, несколько цианотичные, холодные. Какой тип расстройства чувствительности наблюдается в данном случае

!+полиневритический

!невритический

!проводниковый

!капсулярный

!заднероговый

?Больной, 46 лет, в течение нескольких лет страдает хроническим алкоголизмом. Месяц назад появились постепенно нарастающие ощущения ползания мурашек в кистях и стопах и боль в икроножных мышцах. Позднее присоединилось пошатывание при ходьбе, особенно в темноте, стал ронять предметы из рук. Объективно: функция черепных нервов не нарушена. Проба Ромберга положительная при закрытых глазах. Походка атактическая, при ходьбе смотрит на ноги. Объем активных движений рук и ног не ограничен. Мышечная сила снижена в дистальных отделах рук и ног. Мышечный тонус понижен. Аналгезия на кистях и стопах по типу "перчаток" и "чулок". Нарушена вибрационная чувствительность и расстроено мышечно-суставное чувство в пальцах ног. Отмечается болезненность при пальпации по ходу седалищного нерва. Ослаблены карпорадиальные рефлексы. Коленные рефлексы вызываются, снижены, ахилловы отсутствуют. Стопы и кисти отечны, потные, несколько цианотичные, холодные. В связи с чем возникла атаксия

!+нарушение глубоких видов чувствительности

!нарушение поверхностных видов чувствительности

!поражение ядер вестибулярного анализатора

!нарушение кортико-церебеллярных путей

!атрофия коры мозжечка вследствие злоупотребления алкоголем

?Больной, 46 лет, в течение нескольких лет страдает хроническим алкоголизмом. Месяц назад появились постепенно нарастающие ощущения ползания мурашек в кистях и стопах и боль в икроножных мышцах. Позднее присоединилось пошатывание при ходьбе, особенно в темноте, стал ронять предметы из рук. Объективно: функция черепных нервов не нарушена. Проба Ромберга положительная при закрытых глазах. Походка атактическая, при ходьбе смотрит на ноги. Объем активных движений рук и ног не ограничен. Мышечная сила снижена в дистальных отделах рук и ног. Мышечный тонус понижен. Аналгезия на кистях и стопах по типу "перчаток" и "чулок". Нарушена вибрационная чувствительность и расстроено мышечно-суставное чувство в пальцах ног. Отмечается болезненность при пальпации по ходу седалищного нерва. Ослаблены карпорадиальные рефлексы. Коленные рефлексы вызываются, снижены, ахилловы отсутствуют. Стопы и кисти отечны, потные, несколько цианотичные, холодные. Каков характер атаксии

!+сенситивная

!вестибулярная

!мозжечковая

!корковая

?Больной, 36 лет, получил осколочное ранение в область шейных позвонков, после чего развился тетрапарез, появились тазовые расстройства. Болевая и температурная чувствительность снижена на руках. С уровня подмышечной впадины те же виды чувствительности понижены по проводниковому типу. Нарушено мышечно-суставное чувство в пальцах ног и вибрационная чувствительность до голеностопных суставов. Периостальные рефлексы на руках отсутствуют. Коленные и ахилловы рефлексы высокие. Клонус стоп и коленных чашек. Рефлексы Бабинского, Россолимо, Жуковского с обеих сторон. Где локализуется патологический процесс?

!+спинной мозг

!ствол мозга

!периферический нерв

!задний корешок

!передний корешок

?Больной, 36 лет, получил осколочное ранение в область шейных позвонков, после чего развился тетрапарез, появились тазовые расстройства. Болевая и температурная чувствительность снижена на руках. С уровня подмышечной впадины те же виды чувствительности понижены по проводниковому типу. Нарушено мышечно-суставное чувство в пальцах ног и вибрационная чувствительность до голеностопных суставов. Периостальные рефлексы на руках отсутствуют. Коленные и ахилловы рефлексы высокие. Клонус стоп и коленных чашек. Рефлексы Бабинского, Россолимо, Жуковского с обеих сторон. Укажите протяжённость патологического процесса

!+сегменты спинного мозга C₅-D₁

!сегменты спинного мозга C₁-C₄

!сегменты спинного мозга D₂-D₄

!сегменты спинного мозга D₅-L₁

!сегменты спинного мозга L₅-S₁

?Больной, 36 лет, получил осколочное ранение в область шейных позвонков, после чего развился тетрапарез, появились тазовые расстройства. Болевая и температурная чувствительность снижена на руках. С уровня подмышечной впадины те же виды чувствительности понижены по проводниковому типу. Нарушено мышечно-суставное чувство в пальцах ног и вибрационная чувствительность до голеностопных суставов. Периостальные рефлексы на руках отсутствуют. Коленные и ахилловы рефлексы высокие. Клонус стоп и коленных чашек. Рефлексы Бабинского, Россолимо, Жуковского с обеих сторон. Чувствительные нарушения какого типа выявляются у данного пациента

!+сегментарные и проводниковые нарушения

!плексалгические и проводниковые нарушения

!сегментарные и полиневритические нарушения

!невритические и плексалгические нарушения

?Больной, 36 лет, получил осколочное ранение в область шейных позвонков, после чего развился тетрапарез, появились тазовые расстройства. Болевая и температурная чувствительность снижена на руках. С уровня подмышечной впадины те же виды чувствительности понижены по проводниковому типу. Нарушено мышечно-суставное чувство в пальцах ног и вибрационная

чувствительность до голеностопных суставов. Периостальные рефлексы на руках отсутствуют. Коленные и ахилловы рефлексы высокие. Клонус стоп и коленных чашек. Рефлексы Бабинского, Россолимо, Жуковского с обеих сторон. Каковы масштабы поражения спинного мозга

!половина поперечника спинного мозга

!+поперечное поражение спинного мозга

!поражение продолговатого мозга с двух сторон

!поражение левой ножки мозга

?Больной, 44 года, упал, самостоятельно подняться не смог из-за слабости в ногах. Во время обследования установлено, что движения в голеностопных суставах и в стопах отсутствуют. Стопы свисают. Мышечный тонус ног равномерно понижен. Отсутствует поверхностная чувствительность на тыльной поверхности стоп, передней поверхности голеней, задней поверхности ног и в промежности. Коленные рефлексы сохранены, ахилловы рефлексы не вызываются. Расстройства тазовых функций. Через несколько дней появились пролежни в области крестца и больших вертелов. Где локализуется патологический процесс?

!белое вещество спинного мозга

!+серое вещество спинного мозга

!периферический нерв

!задний корешок

!передний корешок

?Больной, 44 года, упал, самостоятельно подняться не смог из-за слабости в ногах. Во время обследования установлено, что движения в голеностопных суставах и в стопах отсутствуют. Стопы свисают. Мышечный тонус ног равномерно понижен. Отсутствует поверхностная чувствительность на тыльной поверхности стоп, передней поверхности голеней, задней поверхности ног и в промежности. Коленные рефлексы сохранены, ахилловы рефлексы не вызываются. Расстройства тазовых функций. Через несколько дней появились пролежни в области крестца и больших вертелов. Где локализуется патологический процесс?

!+спинной мозг

!ствол мозга

!периферический нерв

!задний корешок

!передний корешок

?Больной, 44 года, упал, самостоятельно подняться не смог из-за слабости в ногах. Во время обследования установлено, что движения в голеностопных суставах и в стопах отсутствуют. Стопы свисают. Мышечный тонус ног равномерно понижен. Отсутствует поверхностная чувствительность на тыльной поверхности стоп, передней поверхности голеней, задней поверхности ног и в промежности. Коленные рефлексы сохранены, ахилловы рефлексы не вызываются. Расстройства тазовых функций. Через несколько дней появились пролежни в области крестца и больших вертелов. Где локализуется патологический процесс?

!сегменты спинного мозга C₅-D₁

!сегменты спинного мозга C₁-C₄

!сегменты спинного мозга D₂-D₄

!сегменты спинного мозга D₅-L₁

!+сегменты спинного мозга L₅-S₅

?Возникают ли корковые речевые расстройства при поражении правого полушария головного мозга

!да

!+нет

?Возникает ли поражение артикуляционного аппарата у больных с моторной афазией

!да

!+нет

?Сохранен ли слух у больных с сенсорной афазией

!+да

!нет

?Может ли больной с сенсорной афазией правильно говорить

!да

!+нет

?Может ли больной с амнестической афазией описать свойства и назначения предмета

!+да

!нет

?Имеются ли парезы у больного с апраксией

!да

!+нет

?Понимает ли больной с сенсорной афазией обращенную к нему речь

!да

!+нет

?Может ли больной с алексией пересказать прочитанный текст

!да

!+нет

?Возможна ли правильная последовательность действий у больного с идеаторной апраксией

!да

!+нет

?Возможна ли жаргонафазия при моторной афазии

!да

!+нет

?Какой вид афазии возникает при поражении левой лобной доли

!+моторная афазия

!сенсорная афазия

!амнестическая афазия

?Какой вид речевых расстройств возникает при поражении корковых речевых центров?

!афония
!анартрия
!+афазия

?Для какого варианта нарушения речи характерны парафазии

!+моторная афазия
!афония
!анартрия

?Для какого варианта нарушения речи характерны парафазии

!+сенсорная афазия
!амнестическая афазия
!дизартрия

?Что возникает при поражении левой угловой извилины

!аграфия
!+алексия
!афазия

?Что возникает при поражении левой угловой извилины

!+акалькулия
!апраксия
!аутоагнозия

?Что возникает при поражении левой надкраевой извилины

!+апраксия
!аграфия
!афазия

?Какой вид корковых нарушений возникает при поражении правой теменной доли

!афазия
!апраксия
!+аутоагнозия

?При каком виде афазии речь приобретает "телеграфный стиль"?

!+моторная афазия
!сенсорная афазия
!амнестическая афазия
!семантическая афазия

?Какие из перечисленных исследований используются для характеристики моторной афазии: а) самостоятельная речь; б) диалоговая речь; в) повторная речь; г) автоматизированная речь; д) название предметов по картинкам; е) построение произвольной фразы из заданных трех слов; ж) фонематический слух; з) понимание простых инструкций; и) понимание сложных инструкций; к) понимание сложных логико-грамматических конструкций; л) название предметов:

!+а, б, в, г, д, е
!а, б, в, г, д, е, ж
!ж, з, и, к
!а, б, г, д, е
!з, и, к

?Какие из перечисленных исследований используются для характеристики сенсорной афазии: а) самостоятельная речь; б) диалоговая речь; в) повторная речь; г) автоматизированная речь; д) название предметов по картинкам; е) построение произвольной фразы из заданных трех слов; ж) фонематический слух; з) понимание простых инструкций; и) понимание сложных инструкций; к) понимание сложных логико-грамматических конструкций; л) название предметов:

!а, б, в, г, д, е

!б, ж, и, к

!+ж, з, и, к

!а, б, г, д, е

!з, и, к, л

?Какие из перечисленных исследований используются для характеристики амнестической афазии: а) самостоятельная речь; б) диалоговая речь; в) повторная речь; г) автоматизированная речь; д) название предметов по картинкам; е) построение произвольной фразы из заданных трех слов; ж) фонематический слух; з) понимание простых инструкций; и) понимание сложных инструкций; к) понимание сложных логико-грамматических конструкций; л) название предметов:

!д, е, л

!+д, л

!ж, з, л

!л

!з, и, к, л

?Какие из перечисленных исследований используются для характеристики семантической афазии: а) самостоятельная речь; б) диалоговая речь; в) повторная речь; г) автоматизированная речь; д) название предметов по картинкам; е) построение произвольной фразы из заданных трех слов; ж) фонематический слух; з) понимание простых инструкций; и) понимание сложных инструкций; к) понимание сложных логико-грамматических конструкций; л) название предметов:

!+к

!е

!и

!ж

!з

?Возникает ли при моторной афазии расстройство автоматизированной речи

!+да

!нет

?Нарушается ли при сенсорной афазии понимание простых и сложных инструкций

!+да

!нет

?Возникают ли расстройства схемы тела при поражении правого полушария мозга

!+да

!нет

?Понимает ли больной с алексией прочитанный текст

!да

!+нет

?Нарушено ли у больного с апраксией воспроизведение действий с воображаемыми и реальными предметами

!+да

!нет

?Возникают ли расстройства узнавания предметных изображений у больных с агнозией

!+да

!нет

?Может ли больной с амнестической афазией назвать показываемый предмет

!да

!+нет

?Какой вид афазии возникает при поражении левой височной доли у правшей

!моторная афазия

!+сенсорная афазия

!семантическая афазия

?Какой вид афазии возникает при поражении левой височной доли у правшей

!+амнестическая афазия

!моторная афазия

!семантическая афазия

?Что возникает при поражении теменной коры субдоминантного полушария мозга

!+анозогнозия

!моторная афазия

!амнестическая афазия

?Что возникает при поражении теменной коры субдоминантного полушария мозга

!+псевдомелия

!апраксия

!сенсорная афазия

?Что возникает при поражении теменной коры субдоминантного полушария мозга

!алексия

!+аутоагнозия

!моторная афазия

?Что возникает при поражении теменной коры доминантного полушария

!моторная афазия

!+акалькулия

!псевдомелия

?Что возникает при поражении теменной коры доминантного полушария

!+апраксия

!сенсорная афазия

!анозогнозия

?Что возникает при поражении теменной коры доминантного полушария

!+алексия

!амнестическая афазия

!аутоагнозия

?Что возникает при поражении теменной коры доминантного полушария

!+агнозия

!расстройство схемы тела

!глобальная афазия

?Какой вид высших корковых функций нарушается при поражении левой лобной доли у правшей

!+письмо

!чтение

!счёт

?Какой вид высших корковых функций нарушается при поражении левой лобной доли у правшей

!+экспрессивная речь

!импрессивная речь

!чтение

?Какие из перечисленных симптомов характерны для моторной афазии: а) парафазии; б) персеверация; в) словесный эмбол; г) "телеграфный стиль"; д) "словесный салат"; е) нарушение повторения слов, предложений; ж) нарушение автоматизированной речи; з) нарушение понимания простых и сложных инструкций; и) неправильное название предметов; к) нарушение фонематического слуха:

!+а, б, в, г, е, ж

!а, в, г, д, е, ж

!а, б, д, е, з, к

!а, б, г, е, з, к

!а, б, в, е, з, к

?Какие из перечисленных симптомов характерны для сенсорной афазии: а) парафазии; б) персеверация; в) словесный эмбол; г) "телеграфный стиль"; д) "словесный салат"; е) нарушение повторения слов, предложений; ж) нарушение автоматизированной речи; з) нарушение понимания простых и сложных инструкций; и) неправильное название предметов; к) нарушение фонематического слуха:

!а, б, в, г, е, ж

!а, в, г, д, е, ж

!+а, б, д, е, з, к

!а, б, г, е, з, к

!а, б, в, е, з, к

?Какие из перечисленных симптомов характерны для амнестической афазии: а) парафазии; б) персеверация; в) словесный эмбол; г) "телеграфный стиль"; д) "словесный салат"; е) нарушение повторения слов, предложений; ж) нарушение автоматизированной речи; з) нарушение понимания простых и сложных инструкций; и) неправильное название предметов; к) нарушение фонематического слуха:

!б

!е

!+и

!е, и

!к

?Может ли расстраиваться автоматизированная речь больного с моторной афазией

!+да

!нет

?Понимает ли больной с сенсорной афазией сложные логико-грамматические конструкции

!да

!+нет

?Имеется ли нарушение фонематического слуха у больных с сенсорной афазией

!+да

!нет

?Расстраивается ли понимание прочитанного у больных с алексией

!+да

!нет

?Может ли больной с конструктивной апраксией составить из набора палочек геометрическую фигуру?

!да

!+нет

?Сохранена ли острота зрения у больных с зрительной агнозией

!+да

!нет

?Сохранен ли слух у больных со слуховой агнозией

!+да

!нет

?Возникают ли нарушения высших корковых функций при поражении правого полушария

!+да

!нет

?Различаются ли моторная афазия и дизартрия

!+да

!нет

?Может ли нарушаться письмо у больных с моторной афазией

!+да

!нет

?Что возникает при поражении левой надкраевой извилины у правшей

!+идеаторная апраксия

!моторная апраксия

!сенсорная афазия

?Что возникает при поражении левой надкраевой извилины у правшей

!+конструктивная апраксия

!моторная афазия

!моторная апраксия

?Что возникает при поражении левой угловой извилины у правшей

!+акалькулия

!моторная афазия

!анозогнозия

?Что возникает при поражении левой угловой извилины у правшей

!+алексия

!аграфия

!аутотопагнозия

?Что возникает при поражении левой угловой извилины у правшей

!анозогнозия

!+конструктивная апраксия

!аграфия

?Что возникает при поражении левой височной доли у правшей

!моторная афазия

!+сенсорная афазия

!аутотопагнозия

?Что возникает при поражении левой височной доли у правшей

!+амнестическая афазия

!анозогнозия

!аграфия

?Что возникает при поражении правого полушария у правшей

!+аутотопагнозия

!моторная афазия

!алексия

?Что возникает при поражении правого полушария у правшей

!+анозогнозия

!сенсорная афазия

!акалькулия

?Что возникает при поражении правого полушария у правшей

!+псевдомелия

!сенсо-моторная афазия

!сенсорная афазия

?Какие из перечисленных симптомов характерны для алексии: а) нарушение чтения вслух; б) нарушение копирования написанного; в) нарушение автоматизированного письма; г) непонимание прочитанного; д) нарушение автоматизированного счета; е) нарушение спонтанного письма; ж) нарушение записи и прочтения однозначных и многозначных чисел; з) невозможен рассказ прочитанного; и) нарушение сложного счета; к) нарушение письма под диктовку:

!+а, г, з

!а, б, з

!а, в, з

!а, и, к

!а, ж, з

?Какие из перечисленных симптомов характерны для аграфии: а) нарушение чтения вслух; б) нарушение копирования написанного; в) нарушение автоматизированного письма; г) непонимание прочитанного; д) нарушение автоматизированного счета; е) нарушение спонтанного письма; ж) нарушение записи и прочтения однозначных и многозначных чисел; з) невозможен рассказ прочитанного; и) нарушение сложного счета; к) нарушение письма под диктовку:

!+б, в, е, к

!б, в, г, е, к

!б, д, е, к

!б, в, г, д, е

!б, е, и, к

?Какие из перечисленных симптомов характерны для акалькулии: а) нарушение чтения вслух; б) нарушение копирования написанного; в) нарушение автоматизированного письма; г) непонимание прочитанного; д) нарушение автоматизированного счета; е) нарушение спонтанного письма; ж) нарушение записи и прочтения однозначных и многозначных чисел; з) невозможен рассказ прочитанного; и) нарушение сложного счета; к) нарушение письма под диктовку:

!+д, ж, и

!е, ж, и

!б, ж, и

!ж, и, к

!б, д, ж, и

?Больная, 69 лет, правша, страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом. Утром без потери сознания развились правосторонняя гемиплегия и речевые нарушения - речь больной состояла из непонятного набора нечленораздельных звуков, с трудом можно было разобрать лишь некоторые речевые звуки ("а" и "о"); отмечалось также выраженное нарушение понимания речи, включая выполнение элементарных заданий и части жестов. Выявлялись значительные расстройства письма, чтения и счета. Какие речевые расстройства выявляются при обследовании

!моторная афазия

!сенсорная афазия

!сенсо-моторная афазия

!амнестическая афазия

!сенсорная и амнестическая афазия

?Больная, 69 лет, страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом. Утром без потери сознания развились правосторонняя гемиплегия и речевые нарушения - речь больной состояла из непонятного набора нечленораздельных звуков, с трудом можно было разобрать лишь некоторые речевые звуки ("а" и "о"); отмечалось также выраженное нарушение понимания речи, включая выполнение элементарных заданий и части жестов. Выявлялись значительные расстройства письма, чтения и счета. Определите локализацию патологического процесса.

!субдоминантное полушарие

!+доминантное полушарие

?Больная, 69 лет, правша, страдает гипертонической болезнью и атеросклерозом. Утром без потери сознания развились правосторонняя гемиплегия и речевые

нарушения - речь больной состояла из непонятного набора нечленораздельных звуков, с трудом можно было разобрать лишь некоторые речевые звуки ("а" и "о"); отмечалось также выраженное нарушение понимания речи, включая выполнение элементарных заданий и части жестов. Выявлялись значительные расстройства письма, чтения и счета. Определите локализацию патологического процесса.

!+кора левого полушария головного мозга

!таламус левого полушария головного мозга

!внутренняя капсула левого полушария головного мозга

!левая половина продолговатого мозга

!левая ножка мозга

?Больной жалуется на неловкость в левой руке. Стал часто ронять из нее предметы, особенно если не было контроля зрения. Появилось ощущение, что у него "две левые руки", иногда "терял" левую руку; не знал, в каком положении она находится. Объективно: объем движений, сила и тонус мышц не нарушены. Слева - атаксия при пальценосовой и неуверенность при пяточно-коленной пробах. В пробе Ромберга – слегка пошатывается назад и влево. Нарушено мышечно-суставное чувство во всех суставах левой руки. Понижение тактильной чувствительности и чувства локализации на левой стороне тела. Утратил представление о положении своей левой руки в пространстве, не различает правую и левую сторону. Сухожильные и периостальные рефлексы выше слева. Брюшные рефлексы слегка ослаблены, справа не изменены. Патологических рефлексов нет. Укажите локализацию патологического процесса.

!доминантное полушарие

!+субдоминантное полушарие

?Больной жалуется на неловкость в левой руке. Стал часто ронять из нее предметы, особенно если не было контроля зрения. Появилось ощущение, что у него "две левые руки", иногда "терял" левую руку; не знал, в каком положении она находится. Объективно: объем движений, сила и тонус мышц не нарушены. Слева - атаксия при пальценосовой и неуверенность при пяточно-коленной пробах. В пробе Ромберга – слегка пошатывается назад и влево. Нарушено мышечно-суставное чувство во всех суставах левой руки. Понижение тактильной чувствительности и чувства локализации на левой стороне тела. Утратил представление о положении своей левой руки в пространстве, не различает правую и левую сторону. Сухожильные и периостальные рефлексы выше слева. Брюшные рефлексы слегка ослаблены, справа не изменены. Патологических рефлексов нет. Укажите локализацию патологического процесса.

!+теменная доля правого полушария

!теменная доля левого полушария

!височная доля правого полушария

!височная доля левого полушария

!лобная доля правого полушария

?Больной жалуется на неловкость в левой руке. Стал часто ронять из нее предметы, особенно если не было контроля зрения. Появилось ощущение, что у него "две левые руки", иногда "терял" левую руку; не знал, в каком положении она находится. Объективно: объем движений, сила и тонус мышц не нарушены. Слева - атаксия при пальценосовой и неуверенность при пяточно-коленной пробах. В пробе Ромберга – слегка пошатывается назад и влево. Нарушено мышечно-суставное чувство во всех суставах левой руки. Понижение тактильной чувствительности и чувства локализации на левой стороне тела. Утратил представление о положении своей левой руки в пространстве, не различает правую и левую сторону. Сухожильные и периостальные рефлексы выше слева. Брюшные рефлексы слегка ослаблены, справа не изменены.

Патологических рефлексов нет. Какие симптомы подтверждают поражение субдоминантного полушария у пациента

!нарушение мышечно-суставной, тактильной и локализационной чувствительности в левой руке

!сенситивная атаксия

!+расстройство схемы тела

?Родственники заметили, что, выйдя из комнаты в коридор, больная не знает, как возвратиться обратно; разучилась надевать платье, обувь, пользоваться чашкой, ложкой. Больную приходится кормить. Объективно: опущен правый угол рта. Парезов нет, больная не может произвести предлагаемых действий, нарисовать план своей комнаты. Гемигипалгезия справа. Утрата чувства локализации на правой половине тела. Сухожильные и периостальные рефлексy несколько выше справа. Как называются расстройства движений, указанные в анамнезе болезни и выявленные при обследовании

!+моторная и конструктивная апраксии

!моторная и идеаторная апраксии

!идеаторная и конструктивная апраксии

?Родственники заметили, что, выйдя из комнаты в коридор, больная не знает, как возвратиться обратно; разучилась надевать платье, обувь, пользоваться чашкой, ложкой. Больную приходится кормить. Объективно: опущен правый угол рта. Парезов нет, больная не может произвести предлагаемых действий, нарисовать план своей комнаты. Гемигипалгезия справа. Утрата чувства локализации на правой половине тела. Сухожильные и периостальные рефлексy несколько выше справа. Определите локализацию патологического очага.

!надкраевая извилина левого полушария

!+надкраевая и угловая извилины левого полушария

!надкраевая и угловая извилины правого полушария

!угловая извилина правого полушария

?Может ли возникнуть гипертермия при поражении гипоталамической области

!+да

!нет

?Возникают ли вазомоторные нарушения при поражении симпатического ствола

!+да

!нет

?Возникают ли нарушения сна при поражении гипоталамической области

!+да

!нет

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области

!+вегетососудистые пароксизмы

!сахарный диабет

!парез отводящего нерва

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области

!+нарушения потоотделения
!нарушение чувствительности по гемитипу
!дерматиты

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области
!+несахарный диабет
!парез лицевого нерва
!гипалгезия по проводниковому типу

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области
!+нарушения в эмоциональной сфере
!спастические геми- и тетрапарезы
!гиперкинезы

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области
!+бессонница
!патологические стопные знаки
!гемианестезии

?Какие из перечисленных клинических проявлений характерны для поражения гипоталамической области
!+нейродермиты
!мононейропатии
!двусторонний парез подъязычного нерва

?Какие из перечисленных признаков характерны для солитарного синдрома
!+спастический колит
!нарушение ритма сердечной деятельности
!отеки в области половины лица, шеи и верхней конечности

?Какие из перечисленных признаков характерны для солитарного синдрома
!+боли в области пупка
!патологические пирамидные симптомы
!трофические нарушения кожи верхних конечностей и половины лица

?Какие из перечисленных признаков характерны для солитарного синдрома
!+метеоризм
!нарушение ритма сердечной деятельности
!парезы рук

?Какие из перечисленных признаков характерны для солитарного синдрома
!+дискинезия желчных путей
!вазомоторные нарушения в области половины лица
!гемипарез

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+нарушение ритма сердечной деятельности
!спастический колит
!проводниковые расстройства чувствительности

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+жгучие боли в области половины лица, шеи и верхней конечности
!вялые парезы рук
!боли в области пупка

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+нарушение адаптации к боли
!патологические пирамидные знаки
!нарушение моторики кишечника

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+отеки в области половины лица, шеи и верхней конечности
!метеоризм
!рефлексы орального автоматизма

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+трофические нарушения кожи верхних конечностей и половины лица
!спастический колит
!полиурия

?Какие из перечисленных признаков характерны для поражения звездчатого узла
!+вазомоторные нарушения в области половины лица
!дискинезия желчных путей
!парез верхних конечностей и половины лица

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для симпатико-адреналового криза: а) повышение артериального давления; б) тахикардия; в) брадикардия; г) побледнение; д) диарея; е) полиурия:
!+а, б, г
!а, б, д
!а, б, е
!в, г, д
!в, д, е

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для вагоинсулярного криза: а) повышение артериального давления; б) тахикардия; в) побледнение; в) брадикардия; д) диарея; е) полиурия:
!+в, д, е
!а, б, г
!а, б, д
!а, б, е
!в, г, д

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения парасимпатических клеток глазодвигательного нерва:
!+мидриаз
!миоз
!энофтальм

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения парасимпатических клеток глазодвигательного нерва:

!+экзофтальм
!анизокория
!энофтальм

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения солнечного сплетения:

!+дискинезия желчных путей
!вазомоторные явления в одной половине тела
!нижний вялый парапарез

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения солнечного сплетения:

!+опоясывающие боли в животе, особенно в области пупка
!нарушение ритма сердечной деятельности
!полиурия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения солнечного сплетения:

!+метеоризм
!полидипсия
!несахарный диабет

?Может ли возникнуть повышение артериального давления при поражении гипоталамической области

!+да
!нет

?Возникают ли вегетативно-трофические нарушения при поражении симпатического узла

!+да
!нет

?Появляются ли вегетативно-сосудистые пароксизмы при поражении гипоталамической области

!+да
!нет

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками височной эпилепсии

!+ощущение "уже виденного"
!патологические стопные знаки
!зрительные галлюцинации

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками височной эпилепсии

!+обонятельные галлюцинации
!рефлексы орального автоматизма
!экзофтальм

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками височной эпилепсии

!+висцеральные кризы
!расстройства чувствительности по сегментарному типу
!отсутствие брюшных рефлексов

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нарушения терморегуляции !гемипарезы !изменение глубоких рефлексов	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нарушения жирового обмена !гемианестезии !патологические пирамидные рефлексы	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нарушения сна и бодрствования !рефлексы орального автоматизма !нижний спастический парапарез	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нейродермиты !гиперкинезы !нарушение чувствительности по проводниковому типу	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нейроэндокринные расстройства !ощущение "уже виденного" !галлюцинации	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+повышение АД !нейропатии !рефлексы орального автоматизма	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+нарушение сердечного ритма !диплопия !парафазии	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения гипоталамической области !+гипергидроз !дерматозы !обонятельные галлюцинации	симптомов	являются	признаками	поражения
?Какие из перечисленных признаков характерны для синдрома Горнера !экзофтальм !+энофтальм !мидриаз				

?Какие из перечисленных признаков характерны для синдрома Горнера

!+птоз

!диплопия

!симптом Ревийо

?Какие из перечисленных признаков характерны для синдрома Горнера

!+миоз

!экзофтальм

!страбизм

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения гипоталамической области: а) висцеральные кризы; б) жгучие боли в руке; в) пастозность, трофические нарушения кожи и ногтей руки; г) нарушение терморегуляции:

!а, б

!а, в

!б, в

!+а, г

!а

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения симпатического ганглия: а) висцеральные кризы; б) нарушение терморегуляции; в) пастозность, трофические нарушения кожи и ногтей руки; г) жгучие боли в руке:

!а, б

!а, в

!+б, в

!а, г

!а

?Какие из перечисленных симптомов свидетельствуют о поражении солнечного сплетения: а) спастический колит, метеоризм; б) приступы опоясывающих болей в животе, особенно в области пупка; в) приступы нарушения ритма сердечной деятельности; г) жгучие боли в области лица, шеи и верхней конечности:

!+а, б

!а, б, в

!б

!б, в

!в, г

?Какие из перечисленных симптомов свидетельствуют о поражении звездчатого узла: а) спастический колит, метеоризм; б) приступы опоясывающих болей в животе, особенно в области пупка; в) приступы нарушения ритма сердечной деятельности; г) жгучие боли в области лица, шеи и верхней конечности:

!а, б

!а, б, в

!б

!б, в

!+в, г

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением симпатических клеток цилиоспинального центра: а) экзофтальм; б) миоз; в) энофтальм; г) мидриаз; д) синдром Аргайлла-Робертсона:

!+б, в

!а, б

!в, г

!а, б, д

!а, г, д

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением парасимпатических клеток глазодвигательного нерва: а) экзофтальм; б) миоз; в) энофтальм; г) мидриаз; д) синдром Аргайлла-Робертсона:

!б, в

!а, б

!в, г

!а, б, д

!+а, г, д

?Могут ли возникнуть вегетативно-трофические нарушения при поражении гипоталамической области

!+да

!нет

?Возникают ли нейроэндокринные расстройства при поражении гипоталамуса

!+да

!нет

?Может ли повышаться артериальное давление при поражении гипоталамической области

!+да

!нет

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения симпатического ганглия

!+жгучие боли

!вялые парезы

!фасцикуляции

?Какие из перечисленных симптомов являются признаками поражения симпатического ганглия

!+трофические нарушения кожи, ногтей

!парезы

!повышение мышечного тонуса по спастическому типу

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением вегетативных образований левой теменной доли

!правосторонний гемипарез

!патологические симптомы в левых конечностях

!+гипотрофия мышц правых конечностей

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением вегетативных образований правой теменной доли

!+гиперкератоз, трофические нарушения ногтей правой кисти
!рефлексы орального автоматизма
!расстройство схемы тела у левшей

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением вегетативных образований левой теменной доли
!+пастозность правых конечностей
!пастозность левых конечностей
!периферические парезы конечностей

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением вегетативных образований левой лобной доли
!правосторонняя гемипарестезия
!цианоз, мраморность кожных покровов правых конечностей
!спастический гемипарез
!снижение мышечного тонуса в правых конечностях

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением парасимпатических ядер глазодвигательного нерва
!+мидриаз
!миоз
!симптом Ревейо

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением парасимпатических ядер глазодвигательного нерва
!+синдром Аргайла Робертсона
!Синдром Бриссо-Секара
!Синдром Мийара-Гублера

?Какие из перечисленных симптомов обусловлены поражением парасимпатических ядер глазодвигательного нерва
!+экзофтальм
!диплопия
!энофтальм

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения симпатических клеток C₈-D₁ сегментов спинного мозга:
!+птоз
!экзофтальм
!страбизм

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения симпатических клеток C₈-D₁ сегментов спинного мозга:
!мидриаз
!+миоз
!диплопия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения симпатических клеток C₈-D₁ сегментов спинного мозга:
!+энофтальм
!страбизм
!мидриаз

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения тазового нерва:

!+нарушение мочеиспускания

!нарушение потоотделения

!нарушение схемы тела

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для поражения тазового нерва:

!+нарушение дефекации

!нарушение перистальтики кишечника

!нарушение сердечного ритма

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для симпатикотонии: а) тахикардия, б) брадикардия, в) ослабление перистальтики кишечника, г) усиление перистальтики кишечника, д) побледнение кожных покровов, е) покраснение кожных покровов, ж) повышение артериального давления, з) понижение артериального давления:

!+а, в, д, ж

!б, г, е, з

!а, в, д, ж

!а, г, е, ж

!б, в, д, з

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для ваготонии: а) тахикардия, б) брадикардия, в) ослабление перистальтики кишечника, г) усиление перистальтики кишечника, д) побледнение кожных покровов, е) покраснение кожных покровов, ж) повышение артериального давления, з) понижение артериального давления:

!а, в, д, ж

!+б, г, е, з

!а, в, д, ж

!а, г, е, ж

!б, в, д, з

?Укажите, какие из перечисленных заболеваний являются проявлениями ваготонии: а) бронхиальная астма; б) отек Квинке; в) мигрень; г) спастические формы облитерирующего эндоартериита; д) крапивница:

!+а, б, д

!г, д

!г, в

!а, б, в

!а, б

?Укажите, какие из перечисленных заболеваний являются проявлениями симпатикотонии: а) бронхиальная астма; б) отек Квинке; в) крапивница; г) спастические формы облитерирующего эндоартериита; д) мигрень:

!+г, д

!+а, б, д

!г, в

!а, б, в

!а, б

?Больную беспокоят жгучие мучительные боли в левой половине лица и шеи, сопровождающиеся ощущением "распирания", обильным потоотделением и пастозностью в этой области. Объективно: синдром Горнера слева, нарушение болевой адаптации в области левой половины лица и шеи, асимметрия кожной температуры с повышением слева на 2°C. Укажите локализацию патологического процесса.

!+звёздчатый узел

!лобная доля

!теменная доля

!солнечное сплетение

!диэнцефальная область

?У больной наблюдаются приступы резкого побледнения кожных покровов, сопровождающиеся тахикардией, подъемом артериального давления, ознобоподобным тремором, гипергидрозом. Как называется приступ?

!вагоинсулярный криз

!гипервентиляционный криз

!+симпатико-адреналовый криз

!солярный синдром

?У больной наблюдаются приступы резкого побледнения кожных покровов, сопровождающиеся тахикардией, подъемом артериального давления, ознобоподобным тремором, гипергидрозом. Где локализуется поражение

!звёздчатый узел

!лобная доля

!теменная доля

!солнечное сплетение

!+диэнцефальная область

?Больной страдает спастическим колитом, приступами болей в области пупка, метеоризмом, дискинезией желчных путей. Как называется приступ?

!!вагоинсулярный криз

!гипервентиляционный криз

!симпатико-адреналовый криз

!+солярный синдром

?Больной страдает спастическим колитом, приступами болей в области пупка, метеоризмом, дискинезией желчных путей. Где локализуется поражение

!звёздчатый узел

!лобная доля

!теменная доля

!+солнечное сплетение

!диэнцефальная область

?Возникают ли вегетативные расстройства при геморрагическом инсульте

!+да

!нет

?Может ли быть "мерцание симптомов" при ишемическом инсульте

!+да

!нет

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!+монопарез

!расстройства памяти

!диплопия

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!адиамаия

!+гемипарез

!системное головокружение

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!+анизорефлексия

!астения

!зрительные расстройства

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!+парестезии в одноименных конечностях

!дизартрия

!нистагм

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!анартрия

!дисфагия

!+афатические расстройства

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!слуховые расстройства

!+джексоновская эпилепсия

!синдром височной эпилепсии

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!+перекрестный оптико-пирамидный синдром

!атаксия

!альтернирующий синдром

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в каротидном бассейне:

!+гемиплегия

!синкопальные состояния

!дезориентировка в пространстве и времени

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!монопарез

!+парестезии в одноименных конечностях
!системное головокружение

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!синдром Броун-Секара
!+адинамия и астения
!афатические расстройства

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!нарушение схемы тела
!+зрительные расстройства
!перекрестный оптико-пирамидный синдром

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+дизартрия и анартрия
!астереогноз
!апраксия

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+дисфагия
!«лобная психика»
!джексоновская эпилепсия

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+синдром височной эпилепсии
!моторная афазия
!экзофтальм

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+расстройства памяти
!анозогнозия
!галлюцинации

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+диплопия
!аграфия
!сенестопатии

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+нистагм
!акалькулия
!расстройство чувствительности по полиневритическому типу

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+атаксия

!апраксия

!сегментарные нарушения поверхностной чувствительности

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+альтернирующий синдром

!аутоагнозия

!наильственный смех

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!+слуховые расстройства

!сенсорная афазия

!наильственный плач

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!«телеграфный стиль» речи

!+синкопальные состояния

!гиперкинезы

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нарушения мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне:

!апродия

!+дезориентировка в пространстве и времени

!тотальная афазия

?Наблюдаются ли у больного с субарахноидальным кровоизлиянием менингеальные симптомы

!+да

!нет

?Может ли развиваться ишемический инсульт без закупорки мозговых сосудов?

!+да

!нет

?Может ли развиваться горметонический синдром при геморрагическом инсульте

!+да

!нет

?Возможно ли определение гемиплегии в коматозном состоянии

!+да

!нет

?Могут ли наблюдаться эпилептические припадки при эмболии мозговых сосудов?

!+да

!нет

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!+гемиплегия или гемипарез

!моноплегия или монопарез ноги

!недержание мочи

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!альтернирующий синдром

!+моторная афазия

!тремор покоя

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!астазия

!расстройства психики

!+астереогноз

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!+апраксия

!абазия

!бульбарный паралич

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!периферический паралич лицевого нерва

!хватательный рефлекс

!+расстройства схемы тела

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!анизокория

!Синдром Бриссо-Секара

!+расстройства чувствительности

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне средней мозговой артерии:

!+моноплегия или монопарез руки

!"лобная психика"

!нистагм

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния:

!+внезапное начало

!постепенное развитие симптомов

!наличие предвестников

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния:

!происходит в утренние часы, вскоре после пробуждения

!+происходит днем, после физического или психического напряжения

!происходит ночью, во сне

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния:

!+быстрое развитие очаговых симптомов

!все симптомы нарастают постепенно, в течение нескольких часов или дней

!медленное развитие очаговых симптомов

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния:

!+кома тозное состояние

!кратковременное расстройство сознания

!онейроидное нарушение сознания

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!+лицо багровое, цианотичное

!кровоизлияния в сетчатку

!иктеричность склер

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!артериальное давление нормальное или пониженное

!кратковременное расстройство сознания

!+гипертермия

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!развитие ночью или утром после пробуждения

!менингеальные симптомы не характерны

!+повышенное артериальное давление

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!преобладание очаговой симптоматики

!+менингеальные симптомы

!ликвор всегда прозрачный

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!наличие предвестников

!+кровянистая или ксантохромная цереброспинальная жидкость

!общемозговая симптоматика не характерна

!кровоизлияния в сетчатку

?Какие из признаков характерны для острого периода кровоизлияния в мозг:

!наличие предшествующей ауры

!бледность кожных покровов

!+лейкоцитоз, нейтрофилез

?Какие из признаков характерны для острого периода атеротромботического ишемического инсульта:

!+внезапное начало

!постепенное развитие симптомов

!наличие предвестников

?Какие из признаков характерны для острого периода кардиоэмболического ишемического инсульта:

!+внезапное начало

!постепенное развитие симптомов

!наличие предвестников

?Какие из признаков характерны для острого периода кардиоэмболического ишемического инсульта:

!+быстрое развитие очаговых симптомов

!очаговые симптомы нарастают постепенно, в течение нескольких часов или дней

!медленное развитие очаговых симптомов

?Какие из признаков характерны для острого периода кардиоэмболического ишемического инсульта:

!коматозное состояние

!+кратковременное расстройство сознания

!онейроидное нарушение сознания

?Может ли наблюдаться вторичный стволовой синдром при обширном инфаркте головного мозга полушарной локализации

!+да

!нет

?Возникает ли геморрагический инсульт вследствие разрыва мозгового сосуда

!+да

!нет

?Может ли развиваться геморрагический инсульт вследствие диапедезного кровоизлияния

!+да

!нет

?Возможно ли применение гипербарической оксигенации при лечении ишемического инсульта

!+да

!нет

?Могут ли наблюдаться эпилептические припадки при нарушениях мозгового кровообращения

!+да

!нет

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии

!+моноплегия или монопарез ноги

!гемипарез или гемиплегия

!тотальная афазия

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии

!сенсорная афазия

!+акинез

!аутоагнозия

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии

!гемипарез

!зрительная агнозия
!+хватательный рефлекс

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии
!нарушение счета
!+повышение суставных рефлексов
!расстройство схемы тела

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии
!альтернирующий синдром
!+астазия-абазия
!амнестическая афазия

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии
!бальбарный синдром
!+расстройства психики
!гомимная гемианопсия
!анозогнозия

?Укажите, какие признаки характерны для нарушения кровообращения в бассейне передней мозговой артерии
!нистагм
!+недержание мочи
!астереогноз

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения
!+предупреждение и лечение нарушений дыхания
!антикоагулянтная терапия
!кровоостанавливающие препараты

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения
!+терапия, направленная на поддержание гомеостаза
!тромболитическая терапия
!ноотропные препараты

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения
!+лечение нарушений общей гемодинамики
!назначение ингибиторов протеолиза (контрикал, трасилол)
!селективный тромболизис

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения
!+борьба с отеком мозга и внутричерепной гипертензией
!гемостатические препараты
!терапия антиагрегантами

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения

!+устранение гипертермии и других вегетативных нарушений

!средства, повышающие свертываемость крови и уменьшающие сосудистую проницаемость

!системная тромболитическая терапия

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения

!+предупреждение осложнений инсульта

!применение препаратов рекомбинантного активатора плазминогена

!применение средств, улучшающих реологию крови

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения

!+предупреждение мышечных контрактур

!назначение антиагрегантов

!назначение ацетилсалициловой кислоты в малых дозах

?Укажите, какие виды недифференцированного лечения применяются при острых нарушениях мозгового кровообращения

!+лечение некоторых проявлений нарушения мозгового кровообращения (повторная рвота, икота, психомоторное возбуждение, эпилептический статус)

!назначение ингибиторов протеолиза (контрикал, трасилол)

!лечение инъекционными (гепарин, фраксипарин, клексан) и новыми оральными антикоагулянтами (дабигатран, ривараксабан, апиксабан)

?Какие из данных дополнительных методов исследования характерны для геморрагического инсульта: а) кровянистая или ксантохромная цереброспинальная жидкость, б) смещение М-эхо более 3 мм при эхоэнцефалоскопическом исследовании, в) лейкоцитоз свыше 10.000 со сдвигом влево, г) признаки локального понижения или повышения тонуса мозговых сосудов с одновременным уменьшением кровенаполнения на реоэнцефалограмме, д) выраженные и диффузные нарушения биоэлектрической активности мозга, е) незаполнение сосудистой сети в бассейне сосуда без смещения или сдавления окружающих участков мозга при церебральной ангиографии, ж) очаги пониженной плотности в головном мозге по данным компьютерной томографии, з) очаги повышенной плотности в головном мозге по данным компьютерной томографии, и) локальные нарушения электрической активности мозга:

!+а, б, в, д, з

!а, б, в, г, з

!г, е, ж, и

!г, д, ж, и

!а, г, д, з, и

?Какие из данных дополнительных методов исследования характерны для ишемического инсульта: а) кровянистая или ксантохромная цереброспинальная жидкость, б) смещение М-эхо более 3 мм при эхоэнцефалоскопическом исследовании, в) лейкоцитоз свыше 10.000 со сдвигом влево, г) признаки локального понижения или повышения тонуса мозговых сосудов с одновременным уменьшением кровенаполнения на реоэнцефалограмме, д) выраженные и диффузные нарушения биоэлектрической активности мозга, е) незаполнение сосудистой сети в бассейне

сосуда без смещения или сдавления окружающих участков мозга при церебральной ангиографии, ж) очаги пониженной плотности в головном мозге по данным компьютерной томографии, з) очаги повышенной плотности в головном мозге по данным компьютерной томографии, и) локальные нарушения электрической активности мозга:

!а, б, в, д, з

!а, б, в, г, з

!+г, е, ж, и

!г, д, ж, и

!а, г, д, з, и

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты - 9.350, СОЭ -3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Где локализуется очаг?

!+левое полушарие головного мозга

!правое полушарие головного мозга

!ствол головного мозга

!левое полушарие мозжечка

!правое полушарие мозжечка

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны

ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты – 9.350, СОЭ -3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Где локализуется очаг?

!височная доля

!теменно-височная область

!лобно-теменно-височная область

!теменная доля

!+теменно-височно-затылочная область

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты – 9.350, СОЭ -3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Установите диагноз.

!+кровоизлияние в мозг

!инфаркт головного мозга

!субарахноидальное кровоизлияние

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при

высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты – 9.350, СОЭ -3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Какая тактика лечения является наиболее целесообразной

!назначение гемостатических препаратов

!+ хирургическое лечение

!селективный тромболизис

!системная тромболитическая терапия

!выжидательная тактика

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты – 9.350, СОЭ -3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Какое медикаментозное лечение возможно провести пациенту?

!препараты, повышающие проницаемость сосудистой стенки

!+профилактика и лечение отека мозга

!тромболитическая терапия

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При

поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты - 9.350, СОЭ - 3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Какое медикаментозное лечение возможно провести пациенту?

!+контроль АД

!антиагрегантная терапия

!назначение антиконвульсантов

?Больной Ф., 45 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головную боль в левой половине головы, слабость и онемение в правых конечностях, особенно в руке. В течение последних 4 лет страдает гипертонической болезнью, лечился амбулаторно, цифры артериального давления не помнит. Утром проснулся от сильной головной боли. Во время умывания внезапно ослабели правые конечности, и почти утратилась речь. С трудом выговаривал слова и плохо понимал речь окружающих, сознание не терял. Через день скорой помощью был доставлен в клинику. При поступлении: общее состояние больного тяжелое, пульс 66 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 170/90 мм рт.ст. Ригидность затылочных мышц, слева положительный симптом Кернига. Язык при высовывании отклоняется вправо. Правосторонний гемипарез с преобладанием в руке, в плечевом суставе активные движения отсутствуют. В остальных суставах возможны ограниченные сгибание и разгибание. В тазобедренном и коленном суставах объем движений почти полный, в голеностопном и пальцах стопы - резко ограничен. Правосторонняя гемигипестезия. Сухожильные рефлексы выше справа, рефлекс Бабинского - с обеих сторон. Моторная и сенсорная афазия при сохранности спонтанной речи. Анализ крови: Нв - 7,5 г %, лейкоциты - 9.350, СОЭ - 3 мм в час. Время кровотечения - 48 секунд, свертываемость - 11 минут. Спинномозговая жидкость: давление 270 мм водного столба, ксантохромная, белок 0,99 ‰, цитоз 34/3, реакция Панди ++, Нонне-Апельта +. При исследовании полей зрения - правосторонняя гемианопсия. ЭхоЭГ: смещение М-эха слева направо на 4 мм. КТ: очаг повышенной плотности. Какое медикаментозное лечение возможно провести пациенту?

!антидепрессанты седативного действия

!+препараты, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки

!антикоагулянтная терапия

?Больная С., 58 лет, поступила в клинику нервных болезней с жалобами на слабость в правой руке и ноге, затруднение речи. В течение 2 последних лет (раз в 2-3 месяца) у больной развивалась слабость правой руки, которая проходила без лечения. Во время работы отметила слабость в правой руке, затем присоединилась слабость правой ноги, отмечалось ухудшение зрения на левый глаз. При поступлении общее состояние -

удовлетворительное. Пульс - 82 удара в минуту, ритмичный. Артериальное давление -160/90-140/85 мм рт.ст. Тоны сердца чистые, акцент второго тона на аорте. Ослаблена пульсация левой общей сонной артерии. Неврологический статус: легкий парез лицевого нерва справа по центральному типу, незначительная девиация языка вправо. В пробе Барре несколько быстрее опускаются правые конечности. Сухожильные и периостальные рефлексы справа выше, чем слева. Брюшные рефлексы справа ниже, подошвенный рефлекс справа не вызывается. Правосторонняя гемипарестезия. Анализ крови: Нв -106,2 ед, эритроциты – 4.975.000, лейкоциты – 9.000, СОЭ - 6 мм/час. Спинномозговая жидкость: давление 140 мм водного столба, белок 0,33%, реакция Панди ++, цитоз 1/3, реакция Вассермана отрицательная, реакция Ланге - 01121000. Анализ мочи без особенностей. На ЭКГ - ритм синусовый, признаки перегрузки правого предсердия. Рентгеноскопия органов грудной клетки - сердце расширено влево, аорта уплотнена. Глазное дно - резко сужены артерии. РЭГ - снижение кровенаполнения в левом полушарии головного мозга. Ангиография - стеноз левой внутренней сонной артерии на шее. КТ - очаг пониженной плотности. Установите диагноз.

!ишемический инсульт

!геморрагический инсульт по типу пропитывания

!субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние

!транзиторная ишемическая атака

!субдуральная гематома

?Больная С., 58 лет, поступила в клинику нервных болезней с жалобами на слабость в правой руке и ноге, затруднение речи. В течение 2 последних лет (раз в 2-3 месяца) у больной развивалась слабость правой руки, которая проходила без лечения. Во время работы отметила слабость в правой руке, затем присоединилась слабость правой ноги, отмечалось ухудшение зрения на левый глаз. При поступлении общее состояние - удовлетворительное. Пульс - 82 удара в минуту, ритмичный. Артериальное давление -160/90-140/85 мм рт.ст. Тоны сердца чистые, акцент второго тона на аорте. Ослаблена пульсация левой общей сонной артерии. Неврологический статус: легкий парез лицевого нерва справа по центральному типу, незначительная девиация языка вправо. В пробе Барре несколько быстрее опускаются правые конечности. Сухожильные и периостальные рефлексы справа выше, чем слева. Брюшные рефлексы справа ниже, подошвенный рефлекс справа не вызывается. Правосторонняя гемипарестезия. Анализ крови: Нв -106,2 ед, эритроциты – 4.975.000, лейкоциты – 9.000, СОЭ - 6 мм/час. Спинномозговая жидкость: давление 140 мм водного столба, белок 0,33%, реакция Панди ++, цитоз 1/3, реакция Вассермана отрицательная, реакция Ланге - 01121000. Анализ мочи без особенностей. На ЭКГ - ритм синусовый, признаки перегрузки правого предсердия. Рентгеноскопия органов грудной клетки - сердце расширено влево, аорта уплотнена. Глазное дно - резко сужены артерии. РЭГ - снижение кровенаполнения в левом полушарии головного мозга. Ангиография - стеноз левой внутренней сонной артерии на шее. КТ - очаг пониженной плотности. Установите сосуд, в бассейне васкуляризации которого произошло нарушение мозгового кровообращения.

!левая средняя мозговая артерия

!+левая внутренняя сонная артерия

!левая наружная сонная артерия

!левая задняя нижняя мозжечковая артерия

!левая передняя мозговая артерия

?Больная С., 58 лет, поступила в клинику нервных болезней с жалобами на слабость в правой руке и ноге, затруднение речи. В течение 2 последних лет (раз в 2-3 месяца) у

больной развивалась слабость правой руки, которая проходила без лечения. Во время работы отметила слабость в правой руке, затем присоединилась слабость правой ноги, отмечалось ухудшение зрения на левый глаз. При поступлении общее состояние - удовлетворительное. Пульс - 82 удара в минуту, ритмичный. Артериальное давление - 160/90-140/85 мм рт.ст. Тоны сердца чистые, акцент второго тона на аорте. Ослаблена пульсация левой общей сонной артерии. Неврологический статус: легкий парез лицевого нерва справа по центральному типу, незначительная девиация языка вправо. В пробе Барре несколько быстрее опускаются правые конечности. Сухожильные и периостальные рефлексy справа выше, чем слева. Брюшные рефлексy справа ниже, подошвенный рефлекс справа не вызывается. Правосторонняя гемипарестезия. Анализ крови: Нв - 106,2 ед, эритроциты - 4.975.000, лейкоциты - 9.000, СОЭ - 6 мм/час. Спинномозговая жидкость: давление 140 мм водного столба, белок 0,33‰, реакция Панди ++, цитоз 1/3, реакция Вассермана отрицательная, реакция Ланге - 01121000. Анализ мочи без особенностей. На ЭКГ - ритм синусовый, признаки перегрузки правого предсердия. Рентгеноскопия органов грудной клетки - сердце расширено влево, аорта уплотнена. Глазное дно - резко сужены артерии. РЭГ - снижение кровенаполнения в левом полушарии головного мозга. Ангиография - стеноз левой внутренней сонной артерии на шее. КТ - очаг пониженной плотности. Препараты какой группы необходимо назначить

!гемостатики

!+антиагреганты

!антиконвульсанты

!антиаритмики

?Больной И., 35 лет, поступил в клинику нервных болезней в тяжелом состоянии с жалобами на резкую головную боль. Больной периодически страдал головной болью. Днем внезапно появилась сильная головная боль, рвота, больной утратил сознание. В течение 4 дней находился в сопорозном состоянии. Выражены менингеальные симптомы. Спинномозговая жидкость кровянистая. На 5-й день заболевания развились расстройства психики, проявлявшиеся психомоторным возбуждением, агрессивностью, неадекватным поведением, нарушениями памяти и критики. Из локальных симптомов отмечены центральный парез правого лицевого нерва, положительная проба Барре справа, легкий парез правой стопы, повышение сухожильных рефлексов справа. Установите диагноз.

!ишемический инсульт

!геморрагический инсульт по типу пропитывания

!+субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние

!транзиторная ишемическая атака

!субдуральная гематома

?Больной И., 35 лет, поступил в клинику нервных болезней в тяжелом состоянии с жалобами на резкую головную боль. Больной периодически страдал головной болью. Днем внезапно появилась сильная головная боль, рвота, больной утратил сознание. В течение 4 дней находился в сопорозном состоянии. Выражены менингеальные симптомы. Спинномозговая жидкость кровянистая. На 5-й день заболевания развились расстройства психики, проявлявшиеся психомоторным возбуждением, агрессивностью, неадекватным поведением, нарушениями памяти и критики. Из локальных симптомов отмечены центральный парез правого лицевого нерва, положительная проба Барре справа, легкий парез правой стопы, повышение сухожильных рефлексов справа. Тактика лечения

!+антифибринолитики

!антикоагулянты

!антиагреганты
!антидепрессанты
!антиконвульсанты

?Возможно ли рецидивирующее течение менингококкового менингита

!+да

!нет

?Располагаются ли туберкулезные бугорки на основании мозга

!+да

!нет

?Понижается ли уровень сахара в ликворе при первичном серозном менингите

!да

!+нет

?Характерна ли фибринозная пленка в ликворе при сифилитическом менингите

!да

!+нет

?Характерно ли молниеносное развитие туберкулезного менингита

!да

!+нет

?Возможно ли поражение черепных нервов при менингитах

!да

!+нет

?Характерно ли для туберкулезного менингита снижение хлоридов в ликворе

!+да

!нет

?Укажите, при каком менингите наблюдается понижение сахара в ликворе

!менингококковый

!+туберкулезный

!первичный серозный

?Какие из перечисленных симптомов относятся к миелиту:

!+проводниковое расстройство чувствительности

!вялая нижняя параплегия

!псевдобульбарный паралич

?Какие из перечисленных симптомов относятся к миелиту:

!+спастическая параплегия

!вялая моноплегия

!корешковый тип расстройства чувствительности

?Какие из перечисленных симптомов относятся к миелиту:

!+нарушение функции тазовых органов

!периферический паралич лицевого нерва

!бульбарный паралич

?Какие из перечисленных показателей исследования цереброспинальной жидкости характерны для туберкулезного менингита: а) повышение давления, б) опалесцирующая, в) молочная, г) образование пленки, д) образование сгустков, е) лимфоциты, ж) большинство полинуклеарные клетки, з) умеренное повышение белка, и) значительное увеличение белка, к) умеренное снижение глюкозы:

!а, б, в, г, е, з, к

!+а, б, г, е, з, к

!а, в, д, и, к

!а, б, в, д, и, к

!а, в, г, е, з, к

?Какие из перечисленных показателей исследования цереброспинальной жидкости характерны для менингококкового менингита: а) повышение давления, б) опалесцирующая, в) молочная, г) образование пленки, д) образование сгустков, е) лимфоциты, ж) большинство полинуклеарные клетки, з) умеренное повышение белка, и) значительное увеличение белка, к) умеренное снижение глюкозы:

!а, б, в, г, е, з, к

!а, б, г, е, з, к

!+а, в, д, и, к

!а, б, в, д, и, к

!а, в, г, е, з, к

?Наблюдается ли лимфоцитарный плеоцитоз при менингококковом менингите

!да

!+нет

?Возможна ли атаксия при арахноидите задней черепной ямки

!+да

!нет

?Характерны ли сегментарные нарушения для миелитов?

!да

!+нет

Характерны ли для менингитов общемозговые симптомы

!+да

!нет

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+головная боль

!гемиплегия

!симптом Бабинского

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+рвота

!параплегия

!синдром Бернара-Горнера

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+ригидность затылочных мышц

!синдром Фуа

!парез лицевого нерва

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+симптом Кернига

!синдром Клода

!гемигипестезия

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+симптом Брудзинского

!симптом Бабинского

!синдром Бриссо-Секара

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+общая гиперестезия кожи

!синдром Броун-Секара

!симптом Бехтерева-Менделя

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+фотофобия

!парез подъязычного нерва

!вестибулярная атаксия

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!симптом Гордона

!симптом Якобсона-Ласка

!+симптом Бехтерева

?Укажите, какие симптомы возникают при менингите

!+фонофобия

!синдром Валенберга-Захарченко

!нижняя вялая параплегия

?Укажите, какие признаки характерны для миелитов?

!гемиплегия

!+расстройства функций тазовых органов

!синдром Иценко-Кушинга

?Укажите, какие признаки характерны для миелитов?

!+проводниковое нарушение чувствительности

!вялая пара- или тетраплегия

!нарушение чувствительности по полиневритическому типу

?Укажите, какие признаки характерны для миелитов?

!+спастическая пара- или тетраплегия

!альтернирующий синдром

!мозжечковая атаксия

?Какие из перечисленных симптомов относятся к миелиту грудного отдела спинного мозга: а) синдром Клода-Бернара-Горнера, б) проводниковое нарушение чувствительности от уровня Th₁₀, в) расстройства функций тазовых органов, г) проводниковое нарушение чувствительности с уровня C₅, д) нижняя спастическая параплегия, е) вялый паралич верхних и спастический паралич нижних конечностей:

!+б, в, д

!б, в, е
!а, в, г, е
!а, в, д
!в, г, е

?Какие из перечисленных симптомов относятся к миелиту области шейного утолщения спинного мозга: а) синдром Клода-Бернара-Горнера, б) проводниковое нарушение чувствительности от уровня Th₁₀, в) расстройства функций тазовых органов, г) проводниковое нарушение чувствительности с уровня C₅, д) нижняя спастическая параплегия, е) вялый паралич верхних и спастический паралич нижних конечностей:

!б, в, д
!б, в, е
!+а, в, г, е
!а, в, д
!в, г, е

?Возникает ли гнойный менингит при воспалении придаточных пазух носа

!+да
!нет

?Наблюдаются ли приступы джексоновской эпилепсии при менингитах

!+да
!нет

?Укажите, какие симптомы возникают при молниеносной форме менингококкового менингита

!+бурное начало
!развивается в течение часов и дней
!нарушение сознания не характерно

?Укажите, какие симптомы возникают при молниеносной форме менингококкового менингита

!+расстройство сознания
!преходящий оболочечный синдром
!очаговый симптомокомплекс

?Укажите, какие симптомы возникают при молниеносной форме менингококкового менингита

!+резкое повышение температуры
!гемипарез
!температура, как правило, в пределах нормы

?Укажите, какие симптомы возникают при молниеносной форме менингококкового менингита

!+расстройство дыхания и сердечной деятельности
!выраженные изменения ликвора
!оболочечный синдром отсутствует

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+длительный продромальный период
!острое развитие

!фульминантное течение

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+резкое повышение температуры к концу продромального периода

!ярко выраженный менингеальный синдром

!мутная цереброспинальная жидкость

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+незначительные менингеальные симптомы

!нейтрофильный плеоцитоз

!понижение уровня белка в ликворе

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+опалесцирующая цереброспинальная жидкость

!преобладание очаговых симптомов

!высокая лихорадка с первых дней заболевания

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+положительные белковые реакции

!небольшой нейтрофильный лейкоцитоз в крови

!цереброспинальная жидкость полностью прозрачна

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+лимфоцитарный плеоцитоз

!нейтрофильный плеоцитоз

!отсутствие признаков воспаления в периферической крови

?Какие из перечисленных признаков характерны для туберкулезного менингита:

!+пленка фибрина

!небольшой лимфоцитарный лейкоцитоз в крови

!всегда развивается первично

?Какие из перечисленных признаков характерны для острого серозного лимфоцитарного менингита:

!длительный продромальный период

!+острое развитие

!резкое повышение температуры к концу продромального периода

?Какие из перечисленных признаков характерны для острого серозного лимфоцитарного менингита:

!незначительные менингеальные симптомы

!опалесцирующая цереброспинальная жидкость

!+небольшой лимфоцитарный лейкоцитоз в крови

?Какие из перечисленных признаков характерны для острого серозного лимфоцитарного менингита:

!положительные белковые реакции

!+лимфоцитарный плеоцитоз

!пленка фибрина

?Какие из симптомов характерны для миелита поясничного отдела спинного мозга:

!+вялый паралич ног

!спастическая тетраплегия
!расстройства дыхания

?Какие из симптомов характерны для миелита поясничного отдела спинного мозга:

!+нарушение чувствительности с уровня Th₁₂
!нарушение чувствительности с уровня C₁
!возможна бульбарная симптоматика

?Какие из симптомов характерны для миелита верхних шейных сегментов спинного мозга:

!вялый паралич ног
!+спастическая тетраплегия
!спастическая нижняя параплегия

?Какие из симптомов характерны для миелита верхних шейных сегментов спинного мозга:

!+расстройства дыхания
!нарушение функции пищеварительной системы
!развитие псевдобульбарного синдрома

?Какие из симптомов характерны для миелита верхних шейных сегментов спинного мозга:

!нарушение чувствительности с уровня Th₁₂
!+нарушение чувствительности с уровня C₁
!нарушение чувствительности с уровня C₅

?Какие из симптомов характерны для миелита верхних шейных сегментов спинного мозга:

!альтернирующий синдром
!+возможна бульбарная симптоматика
!нарушение поверхностной чувствительности по плексалгическому типу

?Больной, 21 года, поступил с жалобами на сильные головные боли, рвоту, двоение в глазах. Из анамнеза известно, что заболел 10 дней назад, когда почувствовал недомогание, общую слабость, небольшую головную боль. Отмечалась субфебрильная температура. Головная боль на протяжении недели выросла до нестерпимой и появилось двоение в глазах, рвота. Объективно: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского, анизокория, шире левый зрачок, птоз слева, расходящееся косоглазие (отсутствует движение левого глазного яблока кнутри). В ликворе - лимфоцитарный плеоцитоз, понижено содержание сахара, при отстаивании ликвора образовалась пленка. Установите диагноз.

!миелит
!+менингит
!энцефалит
!полиомиелит
!рассеянный склероз

?Больной, 21 года, поступил с жалобами на сильные головные боли, рвоту, двоение в глазах. Из анамнеза известно, что заболел 10 дней назад, когда почувствовал недомогание, общую слабость, небольшую головную боль. Отмечалась субфебрильная температура. Головная боль на протяжении недели выросла до нестерпимой и появилось двоение в глазах, рвота. Объективно: ригидность затылочных мышц,

симптомы Кернига и Брудзинского, анизокория, шире левый зрачок, птоз слева, расходящееся косоглазие (отсутствует движение левого глазного яблока кнутри). В ликворе - лимфоцитарный плеоцитоз, понижено содержание сахара, при отстаивании ликвора образовалась пленка. Установите диагноз.

!+туберкулезный менингит

!герпетический менингоэнцефалит

!сифилитический менингит

!менингококковый менингит

!криптококковый менингит

?Больной, 21 года, поступил с жалобами на сильные головные боли, рвоту, двоение в глазах. Из анамнеза известно, что заболел 10 дней назад, когда почувствовал недомогание, общую слабость, небольшую головную боль. Отмечалась субфебрильная температура. Головная боль на протяжении недели выросла до нестерпимой и появилось двоение в глазах, рвота. Объективно: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского, анизокория, шире левый зрачок, птоз слева, расходящееся косоглазие (отсутствует движение левого глазного яблока кнутри). В ликворе - лимфоцитарный плеоцитоз, понижено содержание сахара, при отстаивании ликвора образовалась пленка. Препараты каких групп показаны пациенту?

!+кортикостероиды

!противовирусные препараты

!антиконвульсанты

!введение сыворотки реконвалесцентов

?Больной, 21 года, поступил с жалобами на сильные головные боли, рвоту, двоение в глазах. Из анамнеза известно, что заболел 10 дней назад, когда почувствовал недомогание, общую слабость, небольшую головную боль. Отмечалась субфебрильная температура. Головная боль на протяжении недели выросла до нестерпимой и появилось двоение в глазах, рвота. Объективно: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского, анизокория, шире левый зрачок, птоз слева, расходящееся косоглазие (отсутствует движение левого глазного яблока кнутри). В ликворе - лимфоцитарный плеоцитоз, понижено содержание сахара, при отстаивании ликвора образовалась пленка. Препараты каких групп показаны пациенту?

!+антибактериальные препараты

!антикоагулянты

!ПИТРС

!кровоостанавливающие препараты

?Больной, 26 лет, поступил в клинику с жалобами на опоясывающие боли в области грудной клетки. Болен в течение недели, когда повысилась температура на до 37,6° С, имелись катаральные явления. Последние 2 дня - корешковые боли, затем, в день поступления в больницу, стало трудно ходить из-за слабости в ногах, затруднение при мочеиспускании. Объективно: нижний спастический парапарез. Проводниковое нарушение всех видов чувствительности от уровня Th₃ с обеих сторон. Нарушение функции тазовых органов. Ликвор: лимфоцитарный плеоцитоз 20-30 клеток, белок - 0,6%. Установите диагноз.

!+миелит

!менингит

!энцефалит

!полиомиелит

!рассеянный склероз

?Больной, 26 лет, поступил в клинику с жалобами на опоясывающие боли в области грудной клетки. Болен в течение недели, когда повысилась температура на до 37,6° С, имелись катаральные явления. Последние 2 дня - корешковые боли, затем, в день поступления в больницу, стало трудно ходить из-за слабости в ногах, затруднение при мочеиспускании. Объективно: нижний спастический парапарез. Проводниковое нарушение всех видов чувствительности от уровня Th₃ с обеих сторон. Нарушение функции тазовых органов. Ликвор: лимфоцитарный плеоцитоз 20-30 клеток, белок - 0,6%. Поражение какого отдела спинного мозга имеет место,

!шейный

!+грудной

!поясничный

!крестцовый

!копчиковый

?Является ли характерным для клещевого энцефалита острое развитие болезни

!+да

!нет

?Возможно ли развитие кожевниковской эпилепсии при клещевом энцефалите

!+да

!нет

?Эффективна ли серотерапия (введение сыворотки реконвалесцентов) в позднем периоде клещевого энцефалита

!да

!+нет

?Является ли окулолетаргический синдром типичным для летаргического энцефалита

!+да

!нет

?Какие симптомы являются характерными для хронической стадии эпидемического энцефалита

!параличи конечностей

!нарушения чувствительности

!+паркинсонизм

?Какие симптомы являются характерными для клещевого энцефалита

!+бульбарные расстройства

!нарушение глубокой чувствительности

!псевдобульбарные расстройства

?Какие симптомы являются характерными для клещевого энцефалита

!+вялые параличи

!центральные параличи

!нарушение поверхностной чувствительности

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при полиомиелитической форме клещевого энцефалита:

!ядра ствола мозга

!+передние рога спинного мозга

!кора головного мозга и подкорковое белое вещество

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при менингеальной форме клещевого энцефалита:

!передние рога спинного мозга

+ !оболочки мозга

!кора головного мозга и подкорковое белое вещество

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при полиоэнцефаломиелитической форме клещевого энцефалита:

!+ядра ствола мозга

!оболочки мозга

!кора головного мозга и подкорковое белое вещество

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при полиоэнцефаломиелитической форме клещевого энцефалита:

!+передние рога спинного мозга

!оболочки мозга

!кора головного мозга и подкорковое белое вещество

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при менингоэнцефалитической форме клещевого энцефалита:

!ядра ствола мозга

!передние рога спинного мозга

+!оболочки мозга

?Укажите преимущественную локализацию патоморфологических изменений при менингоэнцефалитической форме клещевого энцефалита:

!ядра ствола мозга

!передние рога спинного мозга

+!кора головного мозга и подкорковое белое вещество

?Какие основные синдромы характерны для менингеальной формы клещевого энцефалита:

!спинальные сегментарные параличи

!сочетанное поражение черепных нервов и сегментарного аппарата спинного мозга

!менингеальные, общемозговые и очаговые синдромы

+!синдром серозного менингита

?Какие основные синдромы характерны для менингоэнцефалитической формы клещевого энцефалита:

!спинальные сегментарные параличи

!сочетанное поражение черепных нервов и сегментарного аппарата спинного мозга

+!менингеальные, общемозговые и очаговые синдромы

!синдром серозного менингита

?Какие основные синдромы характерны для полиоэнцефаломиелитической формы клещевого энцефалита:

!спинальные сегментарные параличи

+!сочетанное поражение черепных нервов и сегментарного аппарата спинного мозга

!менингеальные, общемозговые и очаговые синдромы

!синдром серозного менингита

?Какие основные синдромы характерны для полиомиелитической формы клещевого энцефалита:

!+спинальные сегментарные параличи

!сочетанное поражение черепных нервов и сегментарного аппарата спинного мозга

!менингеальные, общемозговые и очаговые синдромы

!синдром серозного менингита

?Какие признаки имеют диагностическую ценность при клещевом энцефалите: а) сезонность заболевания (весна-лето), б) острое начало заболевания, в) гиперкинезы, г) сонливость, д) глазодвигательные расстройства, е) акинез, ж) пластический тонус мышц, з) свисающая голова, и) верхний вялый парализ, к) икота, л) вестибулярные расстройства, м) бульбарные расстройства, н) гиперсаливация:

!+а, б, з, и, м

!в, г, д, е, ж, к, л, н

!а, в, з, и, м

!б, г, д, е, ж, к, л, н

!а, б, в, г, д, ж, м

?Какие признаки имеют диагностическую ценность при эпидемическом энцефалите: а) сезонность заболевания (весна-лето), б) острое начало заболевания, в) гиперкинезы, г) сонливость, д) глазодвигательные расстройства, е) акинез, ж) пластический тонус мышц, з) свисающая голова, и) верхний вялый парализ, к) икота, л) вестибулярные расстройства, м) бульбарные расстройства, н) гиперсаливация:

!+в, г, д, е, ж, к, л, н

!а, б, з, и, м

!а, в, з, и, м

!б, г, д, е, ж, к, л, н

!а, б, в, г, д, ж, м

?Возможно ли возникновение энцефалитов на фоне инфекционных заболеваний

!+да

!нет

?Является ли характерным для эпидемического энцефалита поражение белого вещества головного мозга

!да

!+нет

?Существуют ли специфические средства для лечения острого периода эпидемического энцефалита

!да

!+нет

?Проявляется ли хроническая стадия эпидемического энцефалита синдромом паркинсонизма

!+да

!нет

?Необходимо ли введение сыворотки реконвалесцентов или гамма-глобулина лицам, подвергшимся укусам клещей в тайге

!+да

!нет

?Является ли кожевниковская эпилепсия характерным признаком клещевого энцефалита

!+да

!нет

?Является ли кожевниковская эпилепсия характерным признаком эпидемического энцефалита

!да

!+нет

?Проявляется ли хроническая стадия клещевого энцефалита синдромом паркинсонизма

!да

!+нет

?Укажите, какие клинические формы характерны для клещевого энцефалита: а) полиомиелитическая, б) летаргическая, в) менингеальная, г) окулоцефалическая, д) менингоэнцефалитическая, е) полиоэнцефаломиелитическая, ж) полирадикулоневритическая:

!+а, в, д, е, ж

!а, б, в, е, ж

!а, в, г, е, ж

!а, б, в, г, е, ж

!б, в, д, е, ж

?Укажите, какие стадии течения характерны для эпидемического энцефалита

!+острая

!подострая

!восстановительная

?Укажите, какие стадии течения характерны для эпидемического энцефалита

!+хроническая

!ремиттирующая

!острейшая

?Укажите, какие клетки могут поражаться в острую стадию клещевого энцефалита:

!+мотонейроны верхних шейных сегментов спинного мозга

!нейроны таламуса

!мотонейроны ядра VIII пары черепных нервов

?Укажите, какие клетки могут поражаться в острую стадию клещевого энцефалита:

!+мотонейроны ядра XI пары черепных нервов

!мотонейроны коры головного мозга

!нейроны постцентральной извилины

?Укажите, какие клетки могут поражаться в острую стадию клещевого энцефалита:

!мотонейроны ядра XII пары черепных нервов

!мотонейроны верхних грудных сегментов спинного мозга

!нейроны ядер Голля и Бурдаха

?Какие из признаков характерны для острого периода эпидемического энцефалита: а) острое начало, б) сонливость, в) глазодвигательные расстройства, г) вялые параличи, д) бульбарные нарушения, е) умеренная лихорадка:

!+б, в, е

!а, г, д

!а, б, в

!г, д, е

!а, в, е

?Какие из признаков характерны для острого периода клещевого энцефалита: а) острое начало, б) сонливость, в) глазодвигательные расстройства, г) вялые параличи, д) бульбарные нарушения, е) умеренная лихорадка:

!б, в, е

!+а, г, д

!а, б, в

!г, д, е

!а, в, е

?Какие из перечисленных признаков характерны для постэнцефалитического паркинсонизма:

+ !глазодвигательные расстройства

!парез VII пары черепных нервов

!нарушение чувствительности по проводниковому типу

?Какие из перечисленных признаков характерны для постэнцефалитического паркинсонизма:

!хореоформный гиперкинез

!+вегетативные нарушения

!гемипарез

?Какие из перечисленных симптомов характерны для ревматического энцефалита:

!+хореоформный гиперкинез

!вегетативные нарушения

!гемипарез

?Возможен ли алиментарный путь заражения при клещевом энцефалите

!+да

!нет

?Может ли быть паркинсонизм проявлением хронической стадии эпидемического энцефалита

!+да

!нет

?Может ли быть паркинсонизм проявлением хронической стадии клещевого энцефалита

!да

!+нет

?Выделен ли возбудитель эпидемического энцефалита

!да

!+нет

?Является ли кожевниковская эпилепсия признаком хронического течения клещевого энцефалита

!+да

!нет

?Является ли кожевниковская эпилепсия признаком хронического течения эпидемического энцефалита

!да

!+нет

?Могут ли наблюдаться вестибулярные нарушения при эпидемическом энцефалите

!+да

!нет

?Возникают ли вялые параличи при полиомиелитической форме клещевого энцефалита

!+да

!нет

?Укажите, какие из симптомов характерны для эпидемического энцефалита: а) расстройства сна, б) глазодвигательные расстройства, в) императивные позывы на мочеиспускание, г) гиперсаливация, д) исчезновение брюшных рефлексов, е) пластическая гипертония мышц, ж) гипомимия, з)вестибулярные расстройства, и) ретробульбарный неврит:

!а, в, д, е, ж, з

!а, б, в, д, е, ж, з

!а, г, д, е, ж, з

!+а, б, г, е, ж, з

!а, в, г, д, е, ж

?При каких клинических формах клещевого энцефалита прогноз бывает более тяжелым

!+полиоэнцефаломиелитическая

!полирадикулоневритическая

!менингеальная

?При каких клинических формах клещевого энцефалита прогноз бывает более тяжелым

!+менингоэнцефалитическая

!полирадикулоневритическая

!менингеальная

?Укажите, с какими заболеваниями в остром периоде дифференцируют клещевой энцефалит: а) боковой амиотрофический склероз, б) полиомиелит, в) малая хорья, г) цереброспинальный эпидемический менингит, д) японский энцефалит, е) эпидемический энцефалит:

!+б, г, д, е

!а, г, д, е

!в, г, д, е

!а, б, в, д

!а, б, г, д, е

?Укажите, какие из способов лечения острого периода клещевого энцефалита являются наиболее важными

!антибиотики

!витамины

!сыворотка реконвалесцентов

?Укажите, какие из способов лечения острого периода клещевого энцефалита являются наиболее важными

!+гамма-глобулин

!противовирусные препараты

!кортикостероиды

?Какие из перечисленных симптомов характерны для менингоэнцефалитической формы клещевого энцефалита: а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига; б) расстройства сознания; в) эпилептические судороги; г) центральные парезы или параличи; д) кожевниковская эпилепсия; е) вялый паралич мышц; ж) бульбарные расстройства:

!+а, б, в, г, д

!а, в, г, е, ж

!а, б, в, е, ж

!а, в, д, е, ж

!а, е, ж

?Какие из перечисленных симптомов характерны для полиоэнцефаломиелитической формы клещевого энцефалита: а) ригидность мышц затылка, симптом Кернига; б) расстройства сознания; в) эпилептические судороги; г) центральные парезы или параличи; д) кожевниковская эпилепсия; е) вялый паралич мышц; ж) бульбарные расстройства:

!+а, е, ж

!а, г, ж

!а, в, д

!а, в, е, ж

!а, б, в

?Какие из перечисленных симптомов характерны для менингоэнцефалитической формы клещевого энцефалита:

!+ригидность мышц затылка, симптом Кернига

!расстройства сознания

!эпилептические припадки

!вялый паралич мышц

!бульбарные расстройства

?Какие из перечисленных симптомов характерны для менингоэнцефалитической формы клещевого энцефалита:

!ригидность мышц затылка, симптом Кернига

!расстройства сознания

!эпилептические припадки

!+вялый паралич мышц

!бульбарные расстройства

?У больного, 30 лет, субфебрилитет, диплопия, птоз слева, гипергидроз, гиперсаливация, сонливость, повышение тонуса мышц по пластическому типу. В ликворе лимфоцитарный плеоцитоз; в крови - лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Установите диагноз.

!миелит

!менингит

!+энцефалит

!полиомиелит

!рассеянный склероз

?У больного, 30 лет, субфебрилитет, диплопия, птоз слева, гипергидроз, гиперсаливация, сонливость, повышение тонуса мышц по пластическому типу. В ликворе лимфоцитарный плеоцитоз; в крови - лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Установите диагноз.

!ревматический энцефалит

!клещевой энцефалит

!+эпидемический энцефалит

!коревого энцефалит

!герпетический энцефалит

?У больного, 30 лет, субфебрилитет, диплопия, птоз слева, гипергидроз, гиперсаливация, сонливость, повышение тонуса мышц по пластическому типу. В ликворе лимфоцитарный плеоцитоз; в крови - лейкоцитоз, ускорение СОЭ. Назначение препаратов каких групп показано пациенту?

!+противовоспалительные средства

!противоэпилептические препараты

!антиагреганты

!ПИТРС

!антиаритмики

?У больной, 12 лет, после ангины возникла головная боль, появились жестикуляции и гримасы, причудливые движения пальцами. Подергивания усиливаются при волнении и исчезают во сне. Симптом Гордона положительный. Мышечная гипотония. В крови: лейкоцитоз и лимфоцитоз. На ЭМГ - залповая активность. Установите вариант гиперкинезов.

!тики

!+хорея

!атетоз

!баллизм

!дистония

?У больной, 12 лет, после ангины возникла головная боль, появились жестикуляции и гримасы, причудливые движения пальцами. Подергивания усиливаются при волнении и исчезают во сне. Симптом Гордона положительный. Мышечная гипотония. В крови: лейкоцитоз и лимфоцитоз. На ЭМГ - залповая активность. Осложнением какого заболевания является описанная симптоматика

!+ревматический энцефалит

!клещевой энцефалит

!эпидемический энцефалит

!коревого энцефалит

!герпетический энцефалит

?У больной, 12 лет, после ангины возникла головная боль, появились жестикуляции и гримасы, причудливые движения пальцами. Подергивания усиливаются при волнении и исчезают во сне. Симптом Гордона положительный. Мышечная гипотония. В крови: лейкоцитоз и лимфоцитоз. На ЭМГ - залповая активность. Какой план лечения необходим пациентке: а) лечение основного заболевания, б) противовирусные препараты, в) симптоматическая терапия, г) общеукрепляющее лечение:

!а, б, г

!+а, в, г

!а, б

!б, в

!а

?Мальчик 14 лет стал невнимательным на уроках, снизилась работоспособность, быстро устает. Затем появились непроизвольные подергивания в левой руке, стал гримасничать, повысилась раздражительность. Несколько дней отмечается подъем температуры тела до субфебрильной, однократно беспокоили боли в суставах. При обследовании выявлен хореический гиперкинез, диффузная гипотония. Какое обследование необходимо провести пациенту?

!+анализ крови на ревмопробы

!люмбальная пункция

!электроэнцефалография

!рентгенография суставов

?Мальчик 14 лет стал невнимательным на уроках, снизилась работоспособность, быстро устает. Затем появились непроизвольные подергивания в левой руке, стал гримасничать, повысилась раздражительность. Несколько дней отмечается подъем температуры тела до субфебрильной, однократно беспокоили боли в суставах. При обследовании выявлен хореический гиперкинез, диффузная гипотония, положительные ревмопробы. Какой план лечения необходим пациенту: а) лечение основного заболевания, б) симптоматическая терапия, в) противовирусные препараты, г) общеукрепляющее лечение:

!+а, б, г

!а, в, г

!а, б

!б, в

!а

?Является ли характерным для рассеянного склероза поражение серого вещества головного мозга

!да

!+нет

?Возможно ли развитие деменции на ранних стадиях развития рассеянного склероза

!да

!+нет

?Можно ли поставить диагноз рассеянного склероза сразу после первых проявлений заболевания

!да

!+нет

?Возможно ли развитие полинейропатии при СПИДе

!+да

!нет

?Какие симптомы являются характерными для обострения рассеянного склероза: а) Параличи конечностей, б) Нарушения чувствительности, в) Акинетико-ригидный синдром, г) Ретробульбарный неврит, д) Сопор, е) Вертикальный нистагм, ж) Парез лицевого нерва:

!+а, б, г, е, ж

!а, б, в, г, е, ж

!а, в, г, е, ж

!а, б, в, е, ж

!а, в, е, ж

?Какие симптомы являются характерными для двигательного-познавательного комплекса при СПИДе (СПИД-деменции): а) Замедление скорости двигательных реакций, б) Снижение памяти, в) Афазия, г) Вялые параличи верхних конечностей, д) Патологические стопные пирамидные знаки:

!+а, б, д

!а, б, в, д

!а, б, в

!б, в, г, д

!б, в, д

?Для нарушений тазовых функций при рассеянном склерозе характерны: а) Императивные позывы, б) Истинное недержание мочи (каплями), в) Ложное недержание мочи (порциями), г) Импотенция, д) Задержки мочи:

!+а, в, г, д

!а, б, в, г

!а, в, г, д

!а, б, г, д

!а, в, д

?Укажите характерные патоморфологические черты острого очага (бляшки) рассеянного склероза: а) разрушение миелина, б) вторичная аксональная дегенерация, в) астроглиоз, г) уменьшение числа олигодендроцитов, д) отек, е) массивная инфильтрация клетками крови ткани мозга:

!+а, д, е

!а, б, в, г

!а, б, в, д, е

!а, в, е

!а, б, г, е

?Укажите характерные патоморфологические черты хронического очага (бляшки) рассеянного склероза: а) разрушение миелина, б) вторичная аксональная дегенерация, в) астроглиоз, г) уменьшение числа олигодендроцитов, д) отек, е) массивная инфильтрация клетками крови ткани мозга:

!а, д, е

!+а, б, в, г

!а, б, в, д, е

!а, в, е

!а, б, г, е

?Какие средства используются для лечения обострения рассеянного склероза при ремиттирующем течении: а) кортикостероиды внутривенно, б) бета-интерфероны, в) плазмаферез, г) ангиопротекторы и антиагреганты, д) копаксон:

!+а, в, г

!б, д

!а, в, д

!б, г

!в, д

?Какие средства используются для длительного иммунокорректирующего патогенетического лечения ремиттирующего течения рассеянного склероза: а) кортикостероиды внутривенно, б) бета-интерфероны, в) плазмаферез, г) ангиопротекторы и антиагреганты, д) копаксон:

!а, в, г

!+б, д

!а, в, д

!б, г

!в, д

?В большинстве популяций рассеянный склероз чаще встречается у женщин, чем у мужчин:

!+да

!нет

?Причиной рассеянного склероза является ретровирус:

!да

!+нет

?Характеризуется ли острый рассеянный энцефаломиелит волнообразным течением

!да

!+нет

?Можно ли лечить обострение рассеянного склероза антибактериальной терапией

!да

!+нет

?Укажите, какие симптомы возникают при рассеянном склерозе

!+поблдение височных половин сосков зрительных нервов

!олигокинезия

!фасцикуляции

?Укажите, какие симптомы возникают при рассеянном склерозе

!диспросодия

!+интенционное дрожание

!нарушение чувствительности по полиневритическому типу

?Укажите, какие симптомы возникают при рассеянном склерозе

!симптом Кернига

!+адиадохокинез

!исчезновение сухожильных рефлексов

?Укажите, какие симптомы возникают при рассеянном склерозе

!тремор покоя

!+исчезновение брюшных рефлексов

!фибриляции

?Основные методы лечения обострения рассеянного склероза:

!кортикостероиды внутрь с 80 мг постепенно снижая дозу

!+кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах

!нестероидные противовоспалительные препараты

?Основные методы лечения обострения рассеянного склероза:

!+препараты АКТГ

!анальгетики

!строгий постельный режим

?Олигоклональные иммуноглобулины в ликворе являются:

!маркером болезни Вильсона-Коновалова

!+характерным проявлением иммунопатологического процесса при рассеянном склерозе

!характерным проявлением иммунопатологического процесса при болезни Паркинсона

?Олигоклональные иммуноглобулины в ликворе являются:

!+характерным проявлением иммунопатологического процесса при нейроСПИДе

!характерным проявлением иммунопатологического процесса при Альцгеймера

!маркером генетической неполноценности миелина

?Какие из перечисленных симптомов характерны для рассеянного склероза: а) нижний спастический парализ, б) нистагм, в) атаксия, г) хореоформный гиперкинез, д) задержка мочеиспускания, е) субфебрильная лихорадка:

!+а, б, в, д

!а, б, г, д

!г, е

!в, е

!в, г, е

?Какие из перечисленных симптомов характерны для ревматического энцефалита: а) нижний спастический парализ, б) нистагм, в) атаксия, г) хореоформный гиперкинез, д) задержка мочеиспускания, е) субфебрильная лихорадка:

!а, б, в, д

!а, б, г, д

!+г, е

!в, е

!в, г, е

?Укажите наиболее частые неврологические проявления СПИДа, связанные с первичным поражением головного и спинного мозга ретровирусом: а) познавательно-двигательный комплекс (СПИД-деменция); б) криптококковые менингиты; в) дистальная сенсорная полинейропатия; г) вакуольная миелопатия; д) первичная лимфома ЦНС; е) острый серозный менингит; ж) миопатия; з) токсоплазмоз с поражением ЦНС; и) энцефалит, вызванный пневмококком:

!+а, в, г, е, ж

!б, д, з, и

!а, б, в, е, ж

!г, д, з, и

!а, г, е, и

?Укажите наиболее частые неврологические проявления СПИДа, связанные с вторичными (оппортунистическими) заболеваниями: а) познавательно-двигательный комплекс (СПИД-деменция); б) криптококковые менингиты; в) дистальная сенсорная полинейропатия; г) вакуольная миелопатия; д) первичная лимфома ЦНС; е) острый серозный менингит; ж) миопатия; з) токсоплазмоз с поражением ЦНС; и) энцефалит, вызванный пневмококком:

!а, в, г, е, ж

!+б, д, з, и

!а, б, в, е, ж

!г, д, з, и

!а, г, е, и

?Характерно ли для нейроСПИДа развитие хореического гиперкинеза

!да

!+нет

?Возможно ли развитие межъядерной офтальмоплегии у больных рассеянным склерозом

!+да

!нет

?Характерны ли для рассеянного склероза психо-эмоциональные расстройства

!+да

!нет

?Возможны ли ремиссии при первично прогрессирующем течении рассеянного склероза

!да

!+нет

?Укажите, какие структуры головного и спинного мозга поражаются при рассеянном склерозе:

!ядра черепных нервов

!+перивентрикулярное белое вещество

!передние рога спинного мозга

?Укажите, какие структуры головного и спинного мозга поражаются при рассеянном склерозе:

!+ножки мозжечка

!подкорковые ядра

!боковые рога спинного мозга

?Укажите, какие структуры головного и спинного мозга поражаются при рассеянном склерозе:

!+боковые канатики спинного мозга

!задние рога спинного мозга

!центр Вернике

?Укажите, какие структуры головного и спинного мозга поражаются при рассеянном склерозе:

!+задние канатики спинного мозга

!черная субстанция

!мотонейроны коры прецентральной извилины

?Укажите, какие структуры головного и спинного мозга поражаются при рассеянном склерозе:

!+мозолистое тело

!центр речи Брока

!передние корешки

?Укажите основные методы патогенетического лечения неврологических проявлений СПИДа:

!+азидотимидин

!линкомицин

!аутогемотерапия

?Укажите основные методы патогенетического лечения неврологических проявлений СПИДа:

!+плазмаферез

!амитриптилин

!аугментин

?Укажите основные методы патогенетического лечения неврологических проявлений СПИДа:

!+ацикловир

!анаприлин

!амантадин

?Методы, позволяющие подтвердить клиническое предположение о наличии у пациента рассеянного склероза:

!+исследование ликвора на уровень иммуноглобулинов класса G

!ЭЭГ

!КТ головного мозга

?Методы, позволяющие подтвердить клиническое предположение о наличии у пациента рассеянного склероза:

!+МРТ головного и спинного мозга

!Эхо-ЭГ

!РЭГ

?Методы, позволяющие подтвердить клиническое предположение о наличии у пациента рассеянного склероза:

!исследование лейкоцитарной формулы

!+зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)

!исследование уровня белка в ликворе

?Какие особенности течения и прогноза рассеянного склероза наблюдаются при: ремиттирующей форме заболевания: а) неуклонное прогрессирование без ремиссий, б) короткая первая ремиссия, в) длительная ремиссия, г) неблагоприятный прогноз, д)

начало заболевания с ретробульбарного неврита, е) быстрое неуклонное нарастание нижнего парапареза:

!+б, в, д

!б, г, д

!а, г, е

!а, в, е

!а, б, г

?Какие особенности течения и прогноза рассеянного склероза наблюдаются при первично-прогрессирующей форме заболевания: а) неуклонное прогрессирование без ремиссий, б) короткая первая ремиссия, в) длительная ремиссия, г) неблагоприятный прогноз, д) начало заболевания с ретробульбарного неврита, е) быстрое неуклонное нарастание нижнего парапареза:

!б, в, д

!б, г, д

!+а, г, е

!а, в, е

!а, б, г

?Какие критерии достаточны для постановки достоверного диагноза рассеянного склероза: а) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникших одновременно; б) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникновение которых разделено интервалом в месяц, в) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникновение которых разделено интервалом в год, г) наличие клинических симптомов одного очага в ЦНС, вызвавшего два обострения заболевания с интервалом в год, д) наличие клинических симптомов одного очага в ЦНС, вызвавшего два обострения заболевания с интервалом в месяц, и нескольких субклинических очагов в белом веществе головного мозга, выявленных дополнительными методами (МРТ или вызванные потенциалы):

!+б, в, д

!а, г

!а, в, г

!б, д

!а, б, г

?Какие критерии достаточны для постановки возможного (вероятного) диагноза рассеянного склероза: а) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникших одновременно; б) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникновение которых разделено интервалом в месяц, в) наличие клинических симптомов двух отдельно-расположенных очагов в белом веществе ЦНС, возникновение которых разделено интервалом в год, г) наличие клинических симптомов одного очага в ЦНС, вызвавшего два обострения заболевания с интервалом в год, д) наличие клинических симптомов одного очага в ЦНС, вызвавшего два обострения заболевания с интервалом в месяц, и нескольких субклинических очагов в белом веществе головного мозга, выявленных дополнительными методами (МРТ или вызванные потенциалы):

!б, в, д

!+а, г

!а, в, г

!б, д

!а, б, г

?Больной 27 лет обратился к врачу с жалобами на нарастающую слабость в левой ноге. Пять лет назад был ретробульбарный неврит слева с частичным восстановлением зрения. Около года назад было кратковременное онемение левых конечностей. К врачам не обращался и через неделю все симптомы прошли бесследно. При неврологическом осмотре выявляется горизонтальный мелкокоразмашистый нистагм, снижение мышечной силы в левой ноге до 4 баллов, сухожильные рефлексы повышены с двух сторон, но выше слева. Двусторонний симптом Бабинского и Россоломо. Брюшные рефлексы не вызываются. Офтальмолог: побледнение височной половины диска зрительного нерва слева. Поставьте клинический диагноз.

!острый рассеянный энцефаломиелит

!+рассеянный склероз

!СПИД с поражением нервной системы

!менингококковый менингит

!ревматический энцефалит

?Больной 27 лет обратился к врачу с жалобами на нарастающую слабость в левой ноге. Пять лет назад был ретробульбарный неврит слева с частичным восстановлением зрения. Около года назад было кратковременное онемение левых конечностей. К врачам не обращался и через неделю все симптомы прошли бесследно. При неврологическом осмотре выявляется горизонтальный мелкокоразмашистый нистагм, снижение мышечной силы в левой ноге до 4 баллов, сухожильные рефлексы повышены с двух сторон, но выше слева. Двусторонний симптом Бабинского и Россоломо. Брюшные рефлексы не вызываются. Офтальмолог: побледнение височной половины диска зрительного нерва слева. Какое дополнительное обследование может подтвердить диагноз

!КТ головного мозга

!ЭЭГ

!+МРТ головного мозга

!Эхо-ЭГ

!серологические реакции на ВИЧ

?Больной 27 лет обратился к врачу с жалобами на нарастающую слабость в левой ноге. Пять лет назад был ретробульбарный неврит слева с частичным восстановлением зрения. Около года назад было кратковременное онемение левых конечностей. К врачам не обращался и через неделю все симптомы прошли бесследно. При неврологическом осмотре выявляется горизонтальный мелкокоразмашистый нистагм, снижение мышечной силы в левой ноге до 4 баллов, сухожильные рефлексы повышены с двух сторон, но выше слева. Двусторонний симптом Бабинского и Россоломо. Брюшные рефлексы не вызываются. Офтальмолог: побледнение височной половины диска зрительного нерва слева. Какой основной метод лечения больного на данный момент

!кортикостероиды внутрь с 80 мг постепенно снижая дозу

!+кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах

!нестероидные противовоспалительные препараты

!антиретровирусные препараты

!ПИТРС

?У больного, 15 лет, через несколько дней после вакцинации внезапно ослабели нижние конечности, возникла задержка мочеиспускания, при ходьбе стало пошатываться влево. При осмотре; горизонтальный нистагм, снижение силы в ногах с двух сторон, двусторонние патологические стопные рефлекссы, отсутствие брюшных рефлекссов, интенционный тремор и миомпопадание при выполнении координаторных проб слева. На МРТ головного мозга: справа большой неомогенный очаг и несколько мелких перивентрикулярной очагов с двух сторон, небольшой очаг в белом веществе левого полушария мозжечка. На глазном дне: побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Какой диагноз наиболее вероятен?

- !+острый рассеянный энцефаломиелит
- !рассеянный склероз
- !СПИД с поражением нервной системы
- !менингококковый менингит
- !ревматический энцефалит

?У больного, 15 лет, через несколько дней после вакцинации внезапно ослабели нижние конечности, возникла задержка мочеиспускания, при ходьбе стало пошатываться влево. При осмотре; горизонтальный нистагм, снижение силы в ногах с двух сторон, двусторонние патологические стопные рефлекссы, отсутствие брюшных рефлекссов, интенционный тремор и миомпопадание при выполнении координаторных проб слева. На МРТ головного мозга: справа большой неомогенный очаг и несколько мелких перивентрикулярной очагов с двух сторон, небольшой очаг в белом веществе левого полушария мозжечка. На глазном дне: побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Для дифференциальной диагностики предполагаемого диагноза с каким заболеванием следует продолжить наблюдение пациента

- !острый рассеянный энцефаломиелит
- !+рассеянный склероз
- !СПИД с поражением нервной системы
- !менингококковый менингит
- !ревматический энцефалит

?У больного, 15 лет, через несколько дней после вакцинации внезапно ослабели нижние конечности, возникла задержка мочеиспускания, при ходьбе стало пошатываться влево. При осмотре; горизонтальный нистагм, снижение силы в ногах с двух сторон, двусторонние патологические стопные рефлекссы, отсутствие брюшных рефлекссов, интенционный тремор и миомпопадание при выполнении координаторных проб слева. На МРТ головного мозга: справа большой неомогенный очаг и несколько мелких перивентрикулярной очагов с двух сторон, небольшой очаг в белом веществе левого полушария мозжечка. На глазном дне: побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Назначьте лечение.

- !кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах
- !+кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах в сочетании с метаболическими препаратами и симптоматическим лечением
- !нестероидные противовоспалительные препараты дозах в сочетании с метаболическими препаратами и симптоматическим лечением
- !антиретровирусные препараты
- !ПИТРС

?У больного, 15 лет, через несколько дней после вакцинации внезапно ослабели нижние конечности, возникла задержка мочеиспускания, при ходьбе стало пошатываться влево. При осмотре; горизонтальный нистагм, снижение силы в ногах с двух сторон, двусторонние патологические стопные рефлекссы, отсутствие брюшных рефлекссов,

интенционный тремор и мимоподражание при выполнении координаторных проб слева. На МРТ головного мозга: справа большой негетерогенный очаг и несколько мелких перивентрикулярных очагов с двух сторон, небольшой очаг в белом веществе левого полушария мозжечка. На глазном дне: побледнение височных половин сосков зрительных нервов. Какой метод исследования предпочтителен для пациента

!КТ головного мозга

!ЭЭГ

!+МРТ головного мозга с контрастированием

!Эхо-ЭГ

!серологические реакции на ВИЧ

?Молодой человек 25 лет эпизодически употребляет наркотики внутривенно. В последнее время у него участились герпетические и грибковые высыпания на коже, страдает хроническим бронхитом. Стал замечать повышенную утомляемость, раздражительность, неспособность концентрировать внимание, забывчивость, медлительность, затруднения при счете и чтении. Около недели назад возникла и стала нарастать слабость в дистальных отделах конечностей, похудели мышцы конечностей, снизилась болевая чувствительность на тыльных поверхностях кистей и стоп. В первые дни пребывания в стационаре у больного развилась нижнедолевая стафилококковая пневмония. Поставьте предварительный диагноз.

!острый рассеянный энцефаломиелит

!рассеянный склероз

!+СПИД с поражением нервной системы

!менингококковый менингит

!ревматический энцефалит

?Молодой человек 25 лет эпизодически употребляет наркотики внутривенно. В последнее время у него участились герпетические и грибковые высыпания на коже, страдает хроническим бронхитом. Стал замечать повышенную утомляемость, раздражительность, неспособность концентрировать внимание, забывчивость, медлительность, затруднения при счете и чтении. Около недели назад возникла и стала нарастать слабость в дистальных отделах конечностей, похудели мышцы конечностей, снизилась болевая чувствительность на тыльных поверхностях кистей и стоп. В первые дни пребывания в стационаре у больного развилась нижнедолевая стафилококковая пневмония. Какое обследование необходимо для уточнения диагноза

!КТ головного мозга

!ЭЭГ

!МРТ головного мозга с контрастированием

!Эхо-ЭГ

!+серологические реакции на ВИЧ

?Молодой человек 25 лет эпизодически употребляет наркотики внутривенно. В последнее время у него участились герпетические и грибковые высыпания на коже, страдает хроническим бронхитом. Стал замечать повышенную утомляемость, раздражительность, неспособность концентрировать внимание, забывчивость, медлительность, затруднения при счете и чтении. Около недели назад возникла и стала нарастать слабость в дистальных отделах конечностей, похудели мышцы конечностей, снизилась болевая чувствительность на тыльных поверхностях кистей и стоп. В первые дни пребывания в стационаре у больного развилась нижнедолевая стафилококковая пневмония. Что обуславливает симптомы деменции у пациента

!ВИЧ-ассоциированная миопатия

!ВИЧ-ассоциированная дистальная сенсорная полинейропатия

!+ВИЧ-ассоциированный познавательно-двигательный комплекс
!интоксикация ввиду наличия стафилококковой пневмонии
!ВИЧ-ассоциированный менингит

?Молодой человек 25 лет эпизодически употребляет наркотики внутривенно. В последнее время у него участились герпетические и грибковые высыпания на коже, страдает хроническим бронхитом. Стал замечать повышенную утомляемость, раздражительность, неспособность концентрировать внимание, забывчивость, медлительность, затруднения при счете и чтении. Около недели назад возникла и стала нарастать слабость в дистальных отделах конечностей, похудели мышцы конечностей, снизилась болевая чувствительность на тыльных поверхностях кистей и стоп. В первые дни пребывания в стационаре у больного развилась нижнедолевая стафилококковая пневмония. Назначение каких препаратов обязательно должен включать план лечения

!кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах

!кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах в сочетании с метаболическими препаратами и симптоматическим лечением

!нестероидные противовоспалительные препараты дозах в сочетании с метаболическими препаратами и симптоматическим лечением

!+антиретровирусные препараты

!ПИТРС

?Играет ли роль переохлаждение в развитии радикулопатий

!+да

!нет

?Имеет ли в патогенезе радикулопатий значение дегенеративное поражение межпозвонковых дисков?

!+да

!нет

?Характерны ли воспалительные изменения в периферической крови для радикулопатии

!да

!+нет

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатий пояснично-крестцовой локализации:

!+анталгическая поза

!положительный рефлекс Бабинского

!нарушение глубокой чувствительности по проводниковому типу

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатий пояснично-крестцовой локализации:

!симптом Россолимо

!+боли в поясничной области

!нижний спастический парапарез.

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатий пояснично-крестцовой локализации:

!симптом Брудзинского

!+симптом Нери

!нарушение поверхностной чувствительности по полиневритическому типу

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатий пояснично-крестцовой локализации:

!повышение подошвенного рефлекса

!+отсутствие ахиллова рефлекса

!Симптом Кернига

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатий пояснично-крестцовой локализации:

!отсутствие брюшных рефлексов

!+симптом Ласега

!нижний центральный монопарез

?Отметьте признаки поражения лицевого нерва:

!боль в половине лица

!снижение поверхностной чувствительности на половине лица

!+парез мимической мускулатуры

?Отметьте признаки поражения лицевого нерва:

!+слезотечение или сухость глаза

!расходящееся косоглазие

!двоение при взгляде в сторону поражения

?Отметьте признаки поражения лицевого нерва:

!+снижение вкуса на передних двух третях языка

!снижение вкуса на задней трети языка

!сходящееся косоглазие

?Отметьте признаки поражения лицевого нерва:

!+гиперакузия

!гипергевзия

!гиперосмия

?Отметьте признаки поражения лицевого нерва:

!снижение надбровного рефлекса

!снижение нижнечелюстного рефлекса

!повышение нижнечелюстного рефлекса

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!гемипарез

!проводниковые нарушения глубокой чувствительности

!+боли по ходу нервных стволов

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!+вялые парезы кистей и стоп

!центральные монопарезы

!нарушение поверхностной чувствительности по проводниковому типу

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!+мышечная гипотония

!отсутствие брюшных рефлексов

!появление рефлексов орального автоматизма

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!+снижение чувствительности в дистальных отделах конечностей

!повышение сухожильных рефлексов

!гемипарезы

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!+симптомы натяжения нервных стволов

!положительный менингеальный синдром

!«залповая активность» на ЭМГ

?Укажите характерные для полинейропатий симптомы:

!+вегетативно-трофические расстройства в дистальных отделах конечностей

!патологические стопные рефлексы

!повышение сухожильных и периостальных рефлексов

?Какие из перечисленных симптомов характерны для радикулопатии: а) боли в проксимальном отделе конечности; б) боли в дистальных отделах конечностей в) расстройства чувствительности по корешковому типу; г) расстройства чувствительности по невритическому типу; д) менингеальный синдром; е) белково-клеточная диссоциация в ликворе; ж) симптомы сочетанного поражения периферических нервов, входящих в состав определенного сплетения; з) сколиоз выпуклостью в сторону поражения; и) сглаженность поясничного лордоза; к) напряжение длинных мышц спины:

!+а, в, д, е, з, к

!а, б, в, д, з, к

!а, в, г, д, е, к

!а, б, д, е, ж, и

!а, в, д, е, ж, и

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нейропатии:

!боли в проксимальном отделе конечности

!+боли в дистальных отделах конечностей

!расстройства чувствительности по корешковому типу

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нейропатии:

!+расстройства чувствительности по невритическому типу

!расстройства чувствительности по корешковому типу

!симптомы сочетанного поражения периферических нервов, входящих в состав определенного сплетения

?Какие из перечисленных симптомов характерны для плексита:

!+симптомы сочетанного поражения периферических нервов, входящих в состав определенного сплетения

!боли в проксимальном отделе конечности

!расстройства чувствительности по корешковому типу

?Характерен ли сколиоз в поясничном отделе при радикулопатии пояснично-крестцовой локализации

!+да

!нет

?Возможна ли сенситивная атаксия при алкогольной полинейропатии

!+да

!нет

?Характерно ли сочетание двигательных, чувствительных и вегетативно-трофических расстройств в дистальных отделах конечностей при нейропатии

!+да

!нет

?Укажите симптомы, характерные для нейропатии бедренного нерва:

!парез подвздошно-поясничной, четырёхглавой и портняжной мышц

!паралич икроножной мышцы

!+отсутствие коленного рефлекса

?Укажите симптомы, характерные для нейропатии бедренного нерва:

!патологические стопные знаки

!отсутствие подошвенного рефлекса

!+гипестезия по передней поверхности бедра и передневноутренней поверхности голени

?Укажите симптомы, характерные для нейропатии бедренного нерва:

!+гипестезия по задней поверхности бедра

!симптом Бабинского

!чувствительные нарушения в дистальном отделе нижней конечности

?Укажите симптомы, характерные для нейропатии бедренного нерва:

!паралич четырёхглавой мышцы бедра

!+симптомы Вассермана и Мацкевича

!симптом Ласега

?Укажите симптомы, характерные для алкогольной полинейропатии:

!проксимальные парезы конечностей

!проводниковые расстройства чувствительности

!+дистальные парезы конечностей

?Укажите симптомы, характерные для алкогольной полинейропатии:

!+парестезии и боли в конечностях

!поражение ядер черепных нервов

!афатические расстройства

?Укажите симптомы, характерные для алкогольной полинейропатии:

!+болезненность при пальпации по ходу нервных стволов

!нарушение глубокой чувствительности по проводниковому типу

!центральные парезы

?Укажите симптомы, характерные для алкогольной полинейропатии:

!+нарушение функции блуждающего и диафрагмального нервов

!центральный парез лицевого нерва

!вестибулярная атаксия

?Укажите симптомы, характерные для алкогольной полинейропатии:

!+снижение поверхностной и глубокой чувствительности в дистальных отделах конечностей

!поражение кортико-нуклеарного пути

!появление патологических рефлексов

?Укажите лекарственные средства, применяемые при радикулопатии: а) Диклофенак. б) Новокаиновая блокада. в) Карбамазепин. г) Прозерин. д) Витамины группы В. е) Мидокалм. ж) Румалон. з) Аминазин. и) Индометацин. к) Ганглиозиды. л) Супрастин:

!+а, б, г, д, е, ж, и

!а, в, д, з

!г, д, ж, к, л

!г, е, ж, и, к

!а, б, в, е, з, к

?Укажите лекарственные средства, применяемые при невралгии: а) Диклофенак. б) Новокаиновая блокада. в) Карбамазепин. г) Прозерин. д) Витамины группы В. е) Мидокалм. ж) Румалон. з) Аминазин. и) Индометацин. к) Ганглиозиды. л) Супрастин:

!а, б, г, д, е, ж, и

!+а, в, д, з

!г, д, ж, к, л

!г, е, ж, и, к

!а, б, в, е, з, к

?Укажите лекарственные средства, применяемые при нейропатии: а) Диклофенак. б) Новокаиновая блокада. в) Карбамазепин. г) Прозерин. д) Витамины группы В. е) Мидокалм. ж) Румалон. з) Аминазин. и) Индометацин. к) Ганглиозиды. л) Супрастин:

!а, б, г, д, е, ж, и

!а, в, д, з

!+г, д, ж, к, л

!г, е, ж, и, к

!а, б, в, е, з, к

?Может ли развиваться бульбарный паралич при дифтерийном полиневрите

!+да

!нет

?Характерны ли симптомы выпадения двигательных функций при нейропатии

!+да

!нет

?Возможно ли поражение глазодвигательных нервов при диабетической полинейропатии

!+да

!нет

?Какие из перечисленных симптомов характерны для ганглионитов?

!+корешковые боли

!тетрапарез

!расстройства чувствительности по проводниковому типу

?Какие из перечисленных симптомов характерны для ганглионитов?

!+экссудативные высыпания
!ограниченные периферические парезы мускулатуры
!гемипарез

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нижнего плечевого плексита
!+боли в кисти, в надключичной области и по ходу нервных стволов
!корешковые боли
!экссудативные высыпания

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нижнего плечевого плексита
!+гипестезия по внутренней поверхности предплечья и кисти
!повышение карпорадиального рефлекса
!цервикалгия

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нижнего плечевого плексита
!+атрофия мелких мышц предплечья
!боли в области шеи
!повышение бицепсального и трицепсального рефлексов

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нижнего плечевого плексита
!+парез дистального отдела верхней конечности
!появление патологических рефлексов
!центральный верхний монопарез

?Какие из перечисленных симптомов характерны для нижнего плечевого плексита
!+снижение карпорадиального рефлекса
!расстройства чувствительности по проводниковому типу
!симптом Аргайла Робертсона

?Укажите, какие из перечисленных синдромов могут возникать при остеохондрозе шейного отдела позвоночника:
!+корешковый
!общемозговой
!центрального пареза

?Какие методы исследования более всего значимы для диагностики радикулопатии: а) Клинический анализ крови, б) Определение уровня глюкозы крови и мочи, в) Исследование ликвора. г) Спондилография. д) Миелография. е) МРТ, ж) Электромиография, з) Рентгенография позвоночника:
!+а, в, г, д, е, з
!а, б, в, ж
!а, б, в, ж, з
!а, в, г, ж
!а, в, г, е, з

?Какие методы исследования более всего значимы для диагностики нейропатии: а) Клинический анализ крови, б) Определение уровня глюкозы крови и мочи, в) Исследование ликвора. г) Спондилография. д) Миелография. е) МРТ, ж) Электромиография, з) Рентгенография позвоночника.
!а, в, г, д, е, з
!+а, б, в, ж
!а, б, в, ж, з

!а, в, г, ж

!а, в, г, е, з

?Больной, страдающий хроническим алкоголизмом, жалуется на боли и онемение в стопах, слабость в них. Объективно: вялый парез мышц стоп, мышечные гипотрофии и гипотония. Отсутствие карпорадиальных, ахилловых и подошвенных рефлексов с обеих сторон. Гипестезия в области кистей и стоп. Каков характер патологического процесса

!мононейропатия

!+полинейропатия

!радикулопатия

!вялый квадрипарез

!центральный тетрапарез

?Больная 38 лет после подъёма груза почувствовала резкую боль в поясничной области. Боль усиливалась при движении. Объективно: напряжение длинных мышц спины, сглажен поясничный лордоз. Правосторонний сколиоз в поясничном отделе позвоночника. Ограничение движений в поясничном отделе во все стороны. Боль при пальпации в паравертебральных точках в поясничном отделе. Симптом Ласега справа. Снижены ахиллов и подошвенный рефлексы справа. Гипестезия по наружной поверхности правой голени. На рентгенографии признаки остеохондроза позвоночника. При МРТ обнаружена парамедианная грыжа L4. Показана ли мануальная терапия в остром периоде заболевания

!+нет

!да

?Больная 38 лет после подъёма груза почувствовала резкую боль в поясничной области. Боль усиливалась при движении. Объективно: напряжение длинных мышц спины, сглажен поясничный лордоз. Правосторонний сколиоз в поясничном отделе позвоночника. Ограничение движений в поясничном отделе во все стороны. Боль при пальпации в паравертебральных точках в поясничном отделе. Симптом Ласега справа. Снижены ахиллов и подошвенный рефлексы справа. Гипестезия по наружной поверхности правой голени. На рентгенографии признаки остеохондроза позвоночника. При МРТ обнаружена парамедианная грыжа L4. Какой метод лечения предпочтителен?

!хирургическое лечение

!+консервативная терапия

?У больного 52 лет после переохлаждения появились ноющие боли в поясничной области справа с иррадиацией по передней поверхности бедра и внутренней поверхности голени справа. Объективно: напряжение мышц в поясничной области, сглаженность поясничного лордоза, ограничение движений в поясничном отделе в переднезаднем направлении из-за болей. Симптомы Мацкевича и Вассермана справа. Снижен коленный рефлекс справа. Гипалгезия по внутреннему краю правой голени. На рентгенограмме поясничного отдела позвоночника: признаки остеохондроза со снижением высоты диска L3-L4. Уплотнение поясничного лордоза. С назначения препаратов какой группы следует начать лечение

!кортикостероиды внутрь с 80 мг постепенно снижая дозу

!кортикостероиды внутривенно в пульс - дозах

!+нестероидные противовоспалительные препараты

!антиретровирусные препараты

!ПИТРС

?Возможно ли экстрацеребральное расположение астроцитомы

!+нет

!да

?Может ли гомонимная гемианопсия быть признаком опухоли височной доли

!нет

!+да

?Может ли снижаться зрение при опухоли IV желудочка

!нет

!+да

?Может ли при внутричерепном новообразовании развиваться синдром Форстера-Кеннеди

!нет

!+да

?Характерна ли атрофия языка при фалкс-менингиоме

!+нет

!да

?Возможно ли преждевременное половое созревание при опухоли эпифиза

!нет

!+да

?Возможно ли выпадение роговичного рефлекса при невриноме VIII нерва

!нет

!+да

?Экспансивный характер роста характерен:

!для астроцитом

!+для менингиом

!для олигодендроглиом

?Белково-клеточная диссоциация в ликворе характерна для:

!интрамедуллярных опухолей

!+экстрамедуллярных опухолей

?Адипозо-гипоталамический синдром характерен для:

!лобных опухолей

!+краниофарингиомы

!опухолей мозжечка

?Нарушение чувствительности по диссоциированному типу характерны:

!+ для интрамедуллярных опухолей

!для экстрамедуллярных опухолей

?Нарушение чувствительности по диссоциированному типу характерны:

!+ для сирингомиелии

!для экстрамедуллярных опухолей

?Какие из перечисленных опухолей относятся к злокачественным по характеру роста:

!астроцитомы
!олигодендроглиомы
!+глиобластома

?Какие из перечисленных опухолей относятся к злокачественным по характеру роста:

!астроцитомы
!невринома
!+медуллобластома

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка

!+адиадохокинез
!моторная афазия
!симптом Белла

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка

!дисфония
!+дизартрия
!агения

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка

!гемипарез
!+нистагм
!атрофия мышц

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка

!+атаксия
!астереогноз
!акинетико-ригидный синдром

?Какие из перечисленных операций производятся при удалении конвекситальной менингиомы:

!+костнопластическая трепанация
!субокципитальная кранотомия
!ляминэктомия

?Какие из перечисленных операций производятся при удалении астроцитомы полушария мозжечка:

!костнопластическая трепанация
!+субокципитальная кранотомия
!ляминэктомия

?Какие из перечисленных операций производятся при удалении опухоли, расположенной экстремодулярно:

!костнопластическая трепанация
!субокципитальная кранотомия
!+ляминэктомия

?Какие из перечисленных синдромов характерны для больных с оксифильной аденомой гипофиза: а) акромегалия, б) синдром Иценко-Кушинга; в) синдром Вебера г) битемпоральная гемианопсия; д) акалькулия; е) нарушения половых функций:

!+а, г, е
!в, г, е

!б, г, е
!а, б, г, е
!г, д, е

?Какие из перечисленных синдромов характерны для больных с базофильной аденомой гипофиза: а) акромегалия, б) синдром Иценко-Кушинга; в) синдром Вебера г) битемпоральная гемианопсия; д) акалькулия; е) нарушения половых функций:

!а, г, е
!в, г, е
!+б, г, е
!а, б, г, е
!г, д, е

?Какие из перечисленных симптомов характерны для дислокационных синдромов при височной локализации опухоли: а) глазодвигательные расстройства, б) угнетение сознания, в) нарушения дыхания и сердечной деятельности, г) тонические судороги:

!+а, б
!б, в, г
!в, г
!а, в, г
!б, в

?Какие из перечисленных симптомов характерны для дислокационных синдромов при субтенториальной опухоли: а) глазодвигательные расстройства, б) угнетение сознания, в) нарушения дыхания и сердечной деятельности, г) тонические судороги:

!а, б
!+б, в, г
!в, г
!а, в, г
!б, в

?Возможна ли эпендимомы интрамелулярной локализации

!нет
!+да

?Возможна ли эпендимомы конечной нити

!нет
!+да

?Характерны ли застойные диски зрительных нервов при глиальной опухоли ствола мозга.

!+нет
!да

?Характерны ли боли при сирингомиелии

!нет
!+да

?Возможны ли корешковые боли при внутрипозвоночных новообразованиях

!нет
!+да

?Какая форма гидроцефалии характерна для субтенториальных опухолей
!заместительная
!гиперсекреторная
!+окклюзионная

?Какие признаки характерны для внутричерепной гипертензии
!+диффузная распирающая головная боль
!моторная афазия
!атрофия дисков зрительных нервов

?Какие признаки характерны для внутричерепной гипертензии
!+мозговая рвота
!дизартрия
!джексоновские эпилептические припадки

?Какие признаки характерны для внутричерепной гипертензии
!первичная атрофия дисков зрительных нервов
!+загруженность
!анозогнозия

?Какие из перечисленных опухолей относятся к супратенториальным
!+опухоль лобной доли
!опухоль левой гемисферы мозжечка
!опухоль моста

?Какие из перечисленных опухолей относятся к супратенториальным
!опухоль среднего мозга
!+опухоль задней центральной извилины
!опухоль червя мозжечка

?Какие из перечисленных опухолей относятся к супратенториальным
!опухоль слухового нерва
!опухоль гипофиза
!+опухоль височной доли

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка
!сенсорная афазия
!+скандированная речь
!гемипарез

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка
!чувствительные нарушения
!+интенционный тремор
!апатия

?Какие признаки характерны для опухоли мозжечка
!тремор покоя
!моторная афазия
!+адиадохокинез

?Какие из перечисленных симптомов характерны для экстрамедуллярных опухолей
!+корешковые боли

!синдром Бриссо-Секара
!тремор покоя

?Какие из перечисленных симптомов характерны для экстрамедуллярных опухолей
!интенционный тремор
!+синдром Броун-Секара
!атрофия языка

?Какие из перечисленных симптомов характерны для экстрамедуллярных опухолей
!диссоциированные сегментарные нарушения чувствительности
!+симптом ликворного толчка
!симптом Стюарта-Холмса

?Какие из перечисленных синдромов характерны для интрамедуллярных опухолей: а) синдром Броун - Секара; б) императивные позывы на мочеиспускание; в) расстройства чувствительности по проводниковому типу нарастающие снизу вверх; г) расстройства чувствительности по проводниковому типу, проявляющиеся на уровне пораженных сегментов спинного мозга и постепенно спускающиеся сверху вниз:

!а, б
!+а, б, г
!а, б, в
!б, в
!а, в

?Какие из перечисленных синдромов характерны для экстрамедуллярных опухолей: а) синдром Броун - Секара; б) императивные позывы на мочеиспускание; в) расстройства чувствительности по проводниковому типу нарастающие снизу вверх; г) расстройства чувствительности по проводниковому типу, проявляющиеся на уровне пораженных сегментов спинного мозга и постепенно спускающиеся сверху вниз:

!а, б
!а, б, г
!а, б, в
!б, в
!+а, в

?Какие дополнительные методы диагностики применяются для распознавания опухоли спинного мозга:

!ангиография
!электроэнцефалография
!+миелография

?Какие дополнительные методы диагностики применяются для распознавания опухоли спинного мозга:

!ангиография
!эхоэнцефалография
!+определение уровня белка в спинномозговой жидкости

?Характерна ли асимметрия боковых желудочков при субтенториальных опухолях

!+нет
!да

?Характерна ли внутренняя гидроцефалия при субтенториальных опухолях

!нет

!+да

?Может ли быть опасен поясничный прокол у больного с признаками внутричерепной гипертензии

!нет

!+да

?Возможна ли при опухолях мозга вторичная атрофия дисков зрительных нервов?

!нет

!+да

?Характерна ли для менингеом клеточно-белковая диссоциация

!+нет

!да

?Показано ли оперативное удаление метастазов интрацеребральной локализации

!+нет

!да

?Показано ли оперативное лечение экстрамедуллярной опухоли

!нет

!+да

?В каком направлении происходит преимущественный рост эпендимомы

!в полость турецкого седла

!в полости бокового желудочка

!+интрацеребрально

?Какие из перечисленных симптомов относятся к общемозговым

!+головная боль

!гемипарез

!атаксия

? Какие из перечисленных симптомов относятся к общемозговым

!фасцикуляции

!+застойный диск зрительного нерва

!акромегалия

?Какие из перечисленных симптомов относятся к общемозговым

!моторная афазия

!+головокружение

!апраксия

?Какие из перечисленных симптомов относятся к общемозговым

!+тошнота

!онемение пальцев рук

!центральные парезы лицевого и подъязычного нервов

?Какие из перечисленных симптомов относятся к общемозговым

!астереогнозия

!+нарушения сознания

!миоклонии

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях передней центральной извилины

!+джексоновские судорожные припадки

!аносмия

!анозогнозия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях передней центральной извилины

!гемианопсия

!+монопарез

!джексоновские чувствительные припадки

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях передней центральной извилины

!аутоагнозия

!+центральные парезы лицевого и подъязычного нервов

!слуховые галлюцинации

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях передней центральной извилины

!зрительные галлюцинации

!+оперкулярные припадки

!моноанестезия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!расстройства чувствительности

!гемипарез

!+вкусовые, обонятельные и слуховые галлюцинации

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+эпилептические припадки

!моторная афазия

!центральный монопарез верхней конечности

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+сенсорная афазия

!дизартрия

!астереогноз

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+амнестическая афазия

!аутоагнозия

!анозогнозия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+слуховая агнозия

!акалькулия

!атаксия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+нарушение идентификации запахов
!апраксия
!алексия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+гомонимная квадрантная гемианопсия
!альтернирующие синдромы
!аграфия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+расстройство памяти
!амавроз
!гетеронимная квадрантная гемианопсия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов возникают при опухолях височной доли

!+своеобразные состояния сознания в виде ощущения чего-то близкого, родного, пережитого, ранее виденного
!расстройство схемы тела
!вялый гемипарез

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли лобной доли:

!+грубые нарушения психических и поведенческих реакций
!сенсорная афазия
!эпилептические припадки с аурой в форме зрительных фотопсий

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли лобной доли:

!+односторонняя аносмия
!обонятельные галлюцинации
!гомонимная гемианопсия

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли височной доли:

!грубые нарушения психических и поведенческих реакций
!моторная афазия
!+обонятельные галлюцинации

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли височной доли:

!+гомонимная гемианопсия
!гетеронимная гемианопсия
!разноименная гемианопсия

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли височной доли:

!+сенсорная афазия
!эпилептические припадки с аурой в форме зрительных фотопсий
!односторонняя аносмия

?Какие из перечисленных признаков характерны для опухоли затылочной доли:

!обонятельные галлюцинации
!гомонимная гемианопсия
!+эпилептические припадки с аурой в форме зрительных фотопсий

?Больной Н., 47 лет, поступил в клинику с жалобами на пошатывание при ходьбе. Из анамнеза известно, что 8 месяцев назад стал постепенно снижаться слух на левое ухо,

затем развилась асимметрия лица и онемела левая щека, появились головные боли, тошнота, головокружение. Объективно: нарушение слуха слева по типу поражения звуковоспринимающего аппарата, периферической парез левого лицевого нерва, гипестезия левой половины лица, гипотония мышц, атаксия в левых конечностях. Глазное дно - застойные диски зрительных нервов. Рентгенограмма височной кости по Стенверсу - расширение левого слухового прохода. В ликворе - белково-клеточная диссоциация. Поставьте диагноз.

!+невринома левого слухового нерва

!синдром Меньера

!невринома правого слухового нерва

!опухоль правой лобной доли

!опухоль левой лобной доли

?Больной Н., 47 лет, поступил в клинику с жалобами на пошатывание при ходьбе. Из анамнеза известно, что 8 месяцев назад стал постепенно снижаться слух на левое ухо, затем развилась асимметрия лица и онемела левая щека, появились головные боли, тошнота, головокружение. Объективно: нарушение слуха слева по типу поражения звуковоспринимающего аппарата, периферической парез левого лицевого нерва, гипестезия левой половины лица, гипотония мышц, атаксия в левых конечностях. Глазное дно - застойные диски зрительных нервов. Рентгенограмма височной кости по Стенверсу - расширение левого слухового прохода. В ликворе - белково-клеточная диссоциация. Предпочтительный метод лечения

!+хирургическое лечение

!рентгенотерапия

!консервативная медикаментозная терапия

?Больной Н., 47 лет, поступил в клинику с жалобами на пошатывание при ходьбе. Из анамнеза известно, что 8 месяцев назад стал постепенно снижаться слух на левое ухо, затем развилась асимметрия лица и онемела левая щека, появились головные боли, тошнота, головокружение. Объективно: нарушение слуха слева по типу поражения звуковоспринимающего аппарата, периферической парез левого лицевого нерва, гипестезия левой половины лица, гипотония мышц, атаксия в левых конечностях. Глазное дно - застойные диски зрительных нервов. Рентгенограмма височной кости по Стенверсу - расширение левого слухового прохода. В ликворе - белково-клеточная диссоциация. Какова локализация опухоли

!супратенториальная

!+субтенториальная

?Больной Н., 45 лет, кочегар, обратился к врачу с жалобами на длительно незаживающие ожоги, боли от которых не чувствовал. Впервые имел безболевого ожог 10 лет назад. При осмотре больного отмечены вялый парез верхних конечностей и сегментарное нарушение чувствительности на уровне C₁-Th₂ с обеих сторон. Поставьте диагноз.

!невринома левого слухового нерва

!+синдром Меньера

!невринома правого слухового нерва

!опухоль правой лобной доли

!опухоль левой лобной доли

?Больной Н., 45 лет, кочегар, обратился к врачу с жалобами на длительно незаживающие ожоги, боли от которых не чувствовал. Впервые имел безболевого ожог 10 лет назад. При осмотре больного отмечены вялый парез верхних конечностей и

сегментарное нарушение чувствительности на уровне C₁-Th₂ с обеих сторон.

Предпочтительный метод лечения

!+хирургическое лечение

!рентгенотерапия

!консервативная медикаментозная терапия

?Больной Н., 56 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головные боли, тошноту. Родственники больного в течение полугода отмечают изменения в поведении больного: стал неряшлив, эйфоричен, неадекватно ведет себя на работе и дома. При осмотре: центральный парез VII нерва слева, рефлекс Бабинского и хватательный рефлекс слева. Окулистом отмечена атрофия диска зрительного нерва справа и застойные явления на глазном дне слева. Смещение срединных структур влево на 4 мм. Установите диагноз.

!невринома левого слухового нерва

!сирингомиелия

!невринома правого слухового нерва

!+опухоль правой лобной доли

!опухоль левой лобной доли

?Больной Н., 56 лет, поступил в клинику нервных болезней с жалобами на головные боли, тошноту. Родственники больного в течение полугода отмечают изменения в поведении больного: стал неряшлив, эйфоричен, неадекватно ведет себя на работе и дома. При осмотре: центральный парез VII нерва слева, рефлекс Бабинского и хватательный рефлекс слева. Окулистом отмечена атрофия диска зрительного нерва справа и застойные явления на глазном дне слева. Смещение срединных структур влево на 4 мм. Предпочтительный метод лечения

!+хирургическое лечение

!рентгенотерапия

! консервативная медикаментозная терапия

?Наблюдаются ли очаговые симптомы при сотрясении головного мозга

!+нет

!да

?Может ли быть примесь крови в ликворе при субарахноидальном кровоизлиянии

!нет

!+да

?Наблюдаются ли парезы конечностей при контузии головного мозга

!нет

!+да

?Характерны ли менингеальные симптомы для субарахноидального кровоизлияния

!нет

!+да

?Характерны ли менингеальные симптомы для сотрясения головного мозга

!нет

!+да

?Наблюдается ли примесь крови в ликворе при сотрясении головного мозга

!+нет

!да

?Какие симптомы характерны для сотрясения головного мозга

!+утрата сознания

!парезы

!дизартрия

?Какие симптомы характерны для сотрясения головного мозга

!+рвота

!параличи

!афазии

?Какие симптомы характерны для сотрясения головного мозга

!атаксия

!нарушение ритма дыхания

!+гиподинамия

?Какие симптомы характерны для сотрясения головного мозга

!нарушение сердечного ритма

!галлюцинации

!+головокружение

?Какие изменения спинномозговой жидкости наблюдаются при острой субдуральной гематоме

!лимфоцитарный плеоцитоз

!+примесь крови

!нейтрофильный плеоцитоз

?Какие изменения спинномозговой жидкости наблюдаются при острой субдуральной гематоме

!неполная прозрачность

!+повышение давления

!понижение давления

?Какие симптомы характерны для гематомии поясничного отдела спинного мозга

!тетраплегия

!+нижний парапарез

!повышение глубоких рефлексов

?Какие симптомы характерны для гематомии поясничного отдела спинного мозга

!гипертонус мышц

!+мышечная гипотония

!патологические стопные рефлексы

?Какие симптомы характерны для гематомии поясничного отдела спинного мозга

!общемозговые симптомы

!+нарушение функции тазовых органов

!менингеальные симптомы

?Какие симптомы характерны для гематомии поясничного отдела спинного мозга

!гипертрофия мышц конечностей

!расстройства чувствительности по невральному типу

!+проводниковый тип расстройств чувствительности

?Какие симптомы характерны для гематомии поясничного отдела спинного мозга

!полиневритический тип расстройства чувствительности

! вялый гемипарез

!+сегментарный тип расстройств чувствительности

?Укажите, какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии

!+дегидратационные средства

!папаверин

!ацетилсалициловая кислота

?Укажите, какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии

!антикоагулянты

!+оперативное вмешательство

!рутин

?Укажите, какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии

!варфарин

!+нифедипин

!гепарин

?Укажите, какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии

!антибактериальные препараты

!гипотермия головы

!+транексамовая кислота

?Укажите, какие из лекарственных препаратов и лечебных мероприятий применяются при субарахноидальном кровоизлиянии

!антиагреганты

!рентгенотерапия

!+дицинон

?Какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга

!+головная боль

!менингеальные симптомы

!психомоторное возбуждение

?Какие из перечисленных симптомов характерны для контузии головного мозга

!+головная боль

!наличие «светлого промежутка»

!психомоторное возбуждение

?Какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния:

!парезы конечностей

!нарушение чувствительности по полиневритическому типу

!+психомоторное возбуждение

?Могут ли выявляться менингеальные симптомы при контузии головного мозга

!нет

!+да

?Характерна ли примесь крови в ликворе при эпидуральной гематоме

!+нет

!да

?Бывают ли очаговые симптомы поражения головного мозга при эпидуральной гематоме

!нет

!+да

?Возможны ли парезы конечностей при контузии спинного мозга

!нет

!+да

?Характерен ли для субарахноидального кровоизлияния "светлый" промежуток

!+нет

!да

?При каких из перечисленных видов черепно-мозговой травмы может наблюдаться примесь крови в ликворе: 1) Эпидуральная гематома. 2) Субарахноидальное кровоизлияние. 3) Сотрясение головного мозга. 4) Субдуральная гематома. 5) Контузия головного мозга

!+2, 4, 5

!2, 3, 4

!1, 2, 4

!1, 2, 5

!1, 3, 5

?При каких видах черепно-мозговой травмы наблюдаются очаговые симптомы поражения головного мозга: 1) Эпидуральная гематома. 2) Субдуральная гематома. 3) Внутримозговая гематома 4) Субарахноидальное кровоизлияние. 5) Сотрясение головного мозга. 6) Контузия головного мозга. 7) Вдавленный перелом свода черепа

!+1, 2, 3, 6, 7

!1, 2, 3, 4, 5

!1, 3, 5, 6, 7

!1, 2, 4, 6, 7

!1, 2, 4, 6, 7

?При каких видах черепно-мозговой травмы наблюдается "светлый" промежуток

!сотрясение головного мозга

!контузия головного мозга

!+эпидуральная гематома

?При каких видах черепно-мозговой травмы наблюдается "светлый" промежуток

!субарахноидальное кровоизлияние

!ушиб головного мозга

!+субдуральная гематома

?Какие из перечисленных дополнительных методов обследования больных могут быть использованы для уточнения диагноза сотрясения головного мозга: а) ангиография, б) радиоизотопное сканирование, в) эхоэнцефалография, г) исследование спинномозговой жидкости, д) рентгенограмма черепа, е) компьютерная томография:

!+в, г, д

!а, б, в, г, д, е

!в, г, д, е

!а, б, в

!а, б, в, г

?Какие из перечисленных дополнительных методов обследования больных могут быть использованы для уточнения диагноза субарахноидального кровоизлияния: а) ангиография, б) радиоизотопное сканирование, в) эхоэнцефалография, г) исследование спинномозговой жидкости, д) рентгенограмма черепа, е) компьютерная томография:

!в, г, д

!а, б, в, г, д, е

!+в, г, д, е

!а, б, в

!а, б, в, г

?Какие из перечисленных дополнительных методов обследования больных могут быть использованы для уточнения диагноза эпидуральной гематомы: а) ангиография, б) радиоизотопное сканирование, в) эхоэнцефалография, г) исследование спинномозговой жидкости, д) рентгенограмма черепа, е) компьютерная томография:

!в, г, д

!+а, б, в, г, д, е

!в, г, д, е

!а, б, в

!а, б, в, г

?Какие из перечисленных симптомов характерны для эпидуральной гематомы: а) "светлый" промежуток, б) кровь в ликворе, в) парезы конечностей, г) менингеальные симптомы, д) дислокационные симптомы:

!+а, в, г

!б, г

!б, в, г

!а, в

!а, б, в, г

?Какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния: а) "светлый" промежуток, б) кровь в ликворе, в) парезы конечностей, г) менингеальные симптомы, д) дислокационные симптомы:

!а, в, г

!+б, г

!б, в, г

!а, в

!а, б, в, г

?Наблюдаются ли очаговые симптомы поражения головного мозга при эпидуральной гематоме

!нет

!+да

?Может ли наблюдаться отек диска зрительного нерва при внутричерепных гематомах

!нет

!+да

?Возможны ли менингеальные симптомы при контузии головного мозга

!нет

!+да

?Имеется ли примесь крови в ликворе при сотрясении головного мозга

!нет

!+да

?Возможны ли очаговые симптомы при сотрясении головного мозга

!+нет

!да

?Имеется ли примесь крови в ликворе при субарахноидальном кровоизлиянии

!нет

!+да

?Укажите, при каких видах травмы спинного мозга возможны стойкие парезы конечностей

!+контузии спинного мозга

!сотрясение спинного мозга

!субарахноидальное кровоизлияние

?Укажите, при каких видах травмы спинного мозга возможны стойкие парезы конечностей

!+гематомииелии

!субдуральные гематомы

!гематорахис

?Укажите, какие из перечисленных препаратов следует назначать больному с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием

!папаверин

!+дицинон

!гепарин

?Укажите, какие из перечисленных препаратов следует назначать больному с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием

!аспирин

!никотиновая кислота

!+глюконат кальция

?Укажите, какие из перечисленных препаратов следует назначать больному с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием

!ацетилсалициловая кислота

!+лазикс

!варфарин

?Укажите, какие из перечисленных препаратов следует назначать больному с травматическим субарахноидальным кровоизлиянием

!ривароксабан

!диклофенак натрий

!+транексамовая кислота

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга:

!+гиподинамия

!многократная рвота в течение трех суток

!менингеальные симптомы

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга:

!парезы конечностей

!+головокружение

!атаксия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга:

!+головная боль

!нарушение чувствительности по проводниковому типу

!афазии

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для сотрясения головного мозга:

!+вегетативные расстройства

!дыхательные нарушения

!расстройства сердечной деятельности

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния

!+психомоторное возбуждение

!чувствительные нарушения

!дизартрия

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния

!афазии

!+эпилептические припадки

!парезы конечностей

?Укажите, какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния

!«светлый промежуток»

!+менингеальные симптомы

!координаторные расстройства

?Укажите, какие из перечисленных симптомов могут наблюдаться при субдуральной гематоме: 1) Анизокория. 2) Менингеальные симптомы. 3) Вялые парезы. 4) Патологические пирамидные рефлексы. 5) "Светлый" промежуток. 6) Сегментарный тип расстройств чувствительности. 7) Гипертензионный синдром:

!+1, 2, 4, 5, 7

!1, 2, 3, 5, 7

!1, 2, 7

!1, 2, 6, 7

!1, 2, 5, 6, 7

?Какие из перечисленных симптомов характерны для субарахноидального кровоизлияния: а) общемозговые, б) менингеальные, в) очагового поражения головного мозга:

!+а, б

!а, в

!а

!а, б, в

?Какие из перечисленных симптомов характерны для контузии головного мозга: а) общемозговые, б) менингеальные, в) очагового поражения головного мозга:

!а, б

!а, в

!а

!+а, б, в

?Какие из перечисленных дополнительных методов обследования больных могут быть использованы для уточнения диагноза сотрясения головного мозга: а) рентгенография черепа, б) ангиография, в) ультразвуковая энцефалография, г) компьютерная томография, д) магнитно-резонансная томография:

!а, б, г, д

!+а, в, г, д

!а, б, в, г, д

!а, в, д

!а, б, д

?Какие из перечисленных дополнительных методов обследования больных могут быть использованы для уточнения диагноза внутричерепной гематомы: а) рентгенография черепа, б) ангиография, в) ультразвуковая энцефалография, г) компьютерная томография, д) магнитно-резонансная томография:

!а, б, г, д

!а, в, г, д

!+а, б, в, г, д

!а, в, д

!а, б, д

?После автомобильной аварии больной поступил в приемное отделение больницы в коматозном состоянии. При осмотре: кома, дыхание шумное, зрачки расширены с вялой реакцией на свет, расходящееся косоглазие, кровотечение и ликворея из левого уха. Симптомы периферического пареза лицевого нерва слева. Рефлекс Бабинского с обеих сторон. Повреждение какой части черепа имеет место?

!передней черепной ямки

!задней черепной ямки

!+средней черепной ямки

?После автомобильной аварии больной поступил в приемное отделение больницы в коматозном состоянии. При осмотре: кома, дыхание шумное, зрачки расширены с

вялой реакцией на свет, расходящееся косоглазие, кровотечение и ликворея из левого уха. Симптомы периферического пареза лицевого нерва слева. Рефлекс Бабинского с обеих сторон. Какое лечение показано пациенту?

!+хирургическое лечение

!рентгенотерапия

! консервативная медикаментозная терапия

?Больной, 45 лет, предъявляет жалобы на резкую головную боль, светобоязнь, тошноту, рвоту. Доставлен в приемное отделение больницы с улицы, где он упал, ударился головой, терял сознание. Объективно: больной беспокоен, многоречив, не ориентируется во времени. Легкая ригидность мышц затылка, скуловой симптом Бехтерева. Симптом Кернига с обеих сторон. Глазное дно - изменений нет. Рентгенограмма черепа: кости черепа не повреждены. Поясничная пункция: спинномозговая жидкость кровянистая, вытекает под повышенным давлением. Установите диагноз.

!субдуральное кровоизлияние

!+субарахноидальное кровоизлияние

!ушиб головного мозга

!сотрясение головного мозга

!эпидуральная гематома

?Больной, 45 лет, предъявляет жалобы на резкую головную боль, светобоязнь, тошноту, рвоту. Доставлен в приемное отделение больницы с улицы, где он упал, ударился головой, терял сознание. Объективно: больной беспокоен, многоречив, не ориентируется во времени. Легкая ригидность мышц затылка, скуловой симптом Бехтерева. Симптом Кернига с обеих сторон. Глазное дно - изменений нет. Рентгенограмма черепа: кости черепа не повреждены. Поясничная пункция: спинномозговая жидкость кровянистая, вытекает под повышенным давлением. Какое лечение показано пациенту?

!хирургическое лечение

!рентгенотерапия

!+ консервативная медикаментозная терапия

?Больной, 20 лет, поступил в приемное отделение больницы через 2 часа после падения на улице, в момент чего он получил травму головы. Была кратковременная потеря сознания. При осмотре жалуется на головную боль, головокружение, рвоту. Объективно: менингеальных и очаговых симптомов нет. Нистагм. Бледность кожных покровов, акрогипергидроз. Установите диагноз.

!субдуральное кровоизлияние

!субарахноидальное кровоизлияние

!ушиб головного мозга

!+сотрясение головного мозга

!эпидуральная гематома

?Больной, 20 лет, поступил в приемное отделение больницы через 2 часа после падения на улице, в момент чего он получил травму головы. Была кратковременная потеря сознания. При осмотре жалуется на головную боль, головокружение, рвоту. Объективно: менингеальных и очаговых симптомов нет. Нистагм. Бледность кожных покровов, акрогипергидроз. Какое лечение показано пациенту?

!хирургическое лечение

!рентгенотерапия

!+ консервативная медикаментозная терапия

?Характерны ли нарушения чувствительности при прогрессирующих мышечных дистрофиях (миопатиях)?

!+нет

!да

?Возникают ли чувствительные нарушения при невральной амиотрофии

!нет

!+да

?Могут ли поражаться передние рога спинного мозга при невральной амиотрофии

!нет

!+да

?Наследуется ли по аутосомно-рецессивному типу конечностно-поясная форма прогрессирующей мышечной дистрофии (миопатия Эрба-Рота)?

!нет

!+да

?Характерна ли атрофия мышц при прогрессирующих мышечных дистрофиях

!нет

!+да

?Отметьте, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!+пластическая ригидность

!тонические судороги

!расстройства глотания

?Отметьте, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!+гиперкинезы

!гемиплегия

!поражение черепных нервов

?Отметьте, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!+снижение интеллекта

!симптом Аргайла Робертсона

!парезы

?Отметьте, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!побледнение дисков зрительных нервов

!+кольцо Кайзера-Флейшера

!сегментарные расстройства чувствительности

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!+пластическая ригидность

!спастический тонус

!чувствительные нарушения по проводниковому типу

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!мозжечковая атаксия

!+амимия

!афазия

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!конструктивная апраксия

!+пропульсии

!галлюцинации

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!центральные парезы

!+тремор покоя

!интенционный тремор

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!спастический нижний парапарез

!+ахейрокинез

!тахипноэ

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!брадикардия

!+брадикинезия

!гемибаллизм

?Укажите, какие симптомы характерны для дрожательного паралича

!спастико-атактическая походка

!гемипаретическая походка

!+шаркающая походка

?Какие из перечисленных симптомов характерны для миопатии: а) «крыловидные лопатки», б) «осиная талия», в) атрофия мышц плечевого и тазового пояса, г) стопы Фридрейха, д) изменение формы ноги по типу «опрокинутой бутылки» е) снижение и исчезновение коленных и ахилловых рефлексов, ж) псевдогипертрофии, занижение амплитуды и регистрация полифазных мышечных потенциалов по данным электромиографического исследования, и) фибрилляции, уменьшение количества регистрируемых мышечных потенциалов и снижение скоростей проведения импульсов по чувствительным и двигательным волокнам периферических нервов по данным электромиографического исследования и электронейромиографического исследования фибриллярные подергивания:

!+а, б, в, е, ж, з

!г, д, е, и, к

!а, б, в, е, ж

!г, д, е, з, и, к

!а, в, д, е, и

?Какие из перечисленных симптомов характерны для невральной амиотрофии Шарко-Мари: а) «крыловидные лопатки», б) «осиная талия», в) атрофия мышц плечевого и тазового пояса, г) стопы Фридрейха, д) изменение формы ноги по типу «опрокинутой бутылки» е) снижение и исчезновение коленных и ахилловых рефлексов, ж) псевдогипертрофии, занижение амплитуды и регистрация полифазных мышечных потенциалов по данным электромиографического исследования, и) фибрилляции, уменьшение количества регистрируемых мышечных потенциалов и снижение скоростей проведения импульсов по чувствительным и двигательным волокнам периферических нервов по данным электромиографического исследования и электронейромиографического исследования фибриллярные подергивания:

!а, б, в, е, ж, з

!+г, д, е, и, к

!а, б, в, е, ж

!г, д, е, з, и, к

!а, в, д, е, и

?Характерны ли фасцикулярные подергивания для первичной прогрессирующей мышечной дистрофии (миопатии)?

!+нет

!да

?Бывают ли фасцикулярные подергивания при невральной амиотрофии

!нет

!+да

?Возникают ли нарушения чувствительности при болезни Паркинсона

!+нет

!да

?Характерны ли скованность и дрожание при болезни Паркинсона

!нет

!+да

?Отметьте, какие симптомы характерны для прогрессирующей мышечной дистрофии

!+снижение тонуса мышц

!шаркающая походка

!интеллект сохранен

?Отметьте, какие симптомы характерны для прогрессирующей мышечной дистрофии

!повышение сухожильных рефлексов

!+фасцикулярные подергивания

!«утиная походка»

?Отметьте, какие симптомы характерны для прогрессирующей мышечной дистрофии

!рефлексы орального автоматизма

!+снижение интеллекта

!повышение мышечного тонуса

?Отметьте, какие симптомы характерны для прогрессирующей мышечной дистрофии

!кольцо Кайзера-Флейшера

!+снижение сухожильных рефлексов

!креатинурия

?Укажите, какие симптомы характерны для невральной амиотрофии

!+атрофия мышц стоп и кистей рук

!боли по ходу нервов

!проводниковые расстройства чувствительности

?Укажите, какие симптомы характерны для невральной амиотрофии

!повышение глубоких рефлексов

!+синюшность, мраморная окраска конечностей

!шаркающая походка

?Укажите, какие симптомы характерны для невральной амиотрофии

!мозжечковая атаксия

!+гипергидроз

!кольцо Кайзера-Флейшера

?Укажите, какие симптомы характерны для невральной амиотрофии

!снижение интеллекта

!+фасцикулярные подергивания мышц

!повышение мышечного тонуса по спастическому типу

?Укажите, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!плавающие движения глазных яблок

!+снижение интеллекта

!тотальная афазия

?Укажите, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!амнестическая афазия

!положительные симптомы Брудзинского

!+гиперкинезы

?Укажите, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!сенсорная афазия

!+кольцо Кайзера-Флейшера

!расстройства чувствительности

?Укажите, какие симптомы характерны для гепатоцеребральной дистрофии

!моторная афазия

!менингеальный синдром

!+мышечная ригидность

?Какие из перечисленных симптомов характерны для дрожательного паралича: а) дрожание в руках и в других частях тела, б) повышение мышечного тонуса по типу экстрапирамидной ригидности, в) ахейрокинез, г) брадикинезия, д) олигокинезия, е) микрография, ж) походка мелкими шажками, «шаркающая», з) изменения психики, и) гиперкинезы, к) кольцо Кайзера-Флейшера:

!+а, в, г, д, е, ж

!б, в, г, д, ж, з, и, к

!б, д, ж, з, и, к

!а, б, в, д, е, ж

!б, в, г, д, е, ж, и, к

?Какие из перечисленных симптомов характерны для гепатоцеребральной дистрофии: а) дрожание в руках и в других частях тела, б) повышение мышечного тонуса по типу экстрапирамидной ригидности, в) ахейрокинез, г) брадикинезия, д) олигокинезия, е) микрография, ж) походка мелкими шажками, «шаркающая», з) изменения психики, и) гиперкинезы, к) кольцо Кайзера-Флейшера:

!а, в, г, д, е, ж

!+б, в, г, д, ж, з, и, к

!б, д, ж, з, и, к

!а, б, в, д, е, ж

!б, в, г, д, е, ж, и, к

?Характерен ли амиостатический синдром для болезни Паркинсона

!нет

!+да

?Нарушается ли походка при болезни Паркинсона

!нет

!+да

?Характерны ли стопы Фридрейха для невральной амиотрофии

!нет

!+да

?Могут ли возникать боли у больных с невральной амиотрофией

!+нет

!да

?Возникают ли изменения походки у больных с прогрессирующими мышечными дистрофиями

!нет

!+да

?Укажите, какие симптомы характерны для первичных прогрессирующих мышечных дистрофий

!+утомляемость ног при ходьбе

!повышение глубоких рефлексов

!нарушения чувствительности по проводниковому типу

?Укажите, какие симптомы характерны для первичных прогрессирующих мышечных дистрофий

!нарушение функции тазовых органов

!+«утиная походка»

!поражение ядер лицевого и подъязычного нервов

?Укажите, какие симптомы характерны для первичных прогрессирующих мышечных дистрофий

!гемигипестезия

!+«крыловидные лопатки»

!повышенные сухожильные рефлексy

?Укажите, какие симптомы характерны для первичных прогрессирующих мышечных дистрофий

!корешковый тип расстройства чувствительности

!+«поперечная улыбка»

!гиперкинезы

?Укажите, какие симптомы характерны для первичных прогрессирующих мышечных дистрофий

!+«осиная талия»

!шаркающая походка

!расстройства мочеиспускания

?Укажите, какие симптомы возникают при гепатоцеребральной дистрофии 1) Бедность и замедленность движений. 2) Расстройства чувствительности по сегментарному типу. 3) Амимия. 4) Насильственный смех или плач. 5) Параплегия. 6) Дисфагия. 7) Дизартрия. 8) Афазия. 9) Ритмичные размахистые насильственные движения. 10) Кольцо Кайзера-Флейшера.

!+1, 3, 4, 6, 7, 9, 10

!1, 2, 4, 5, 7, 9, 10

!1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

?Какие из перечисленных симптомов характерны для миопатий: а) «крыловидные лопатки», б) «осиная талия», в) атрофия мышц плечевого и тазового пояса, г) стопа Фридрейха, д) изменение формы ног по типу «опрокинутой бутылки», е) снижение и исчезновение коленных и ахилловых рефлексов, ж) псевдогипертрофии, з) снижение амплитуды и регистрация, полифазных мышечных потенциалов по данным электромиографического исследования, и) фибрилляции, уменьшение количества регистрируемых мышечных потенциалов и снижение скорости проведения импульса по чувствительным и двигательным волокнам периферических нервов по данным электромиографического и электронейромиографического исследований, к) фасцикулярные подергивания:

!+а, б, в, е, ж, з

!г, д, е, и, к

!а, б, г, е, ж, з

!в, д, е, и, к

?Какие из перечисленных симптомов характерны для невральной амиотрофии Шарко-Мари: а) «крыловидные лопатки», б) «осиная талия», в) атрофия мышц плечевого и тазового пояса, г) стопа Фридрейха, д) изменение формы ног по типу «опрокинутой бутылки», е) снижение и исчезновение коленных и ахилловых рефлексов, ж) псевдогипертрофии, з) снижение амплитуды и регистрация, полифазных мышечных потенциалов по данным электромиографического исследования, и) фибрилляции, уменьшение количества регистрируемых мышечных потенциалов и снижение скорости проведения импульса по чувствительным и двигательным волокнам периферических нервов по данным электромиографического и электронейромиографического исследований, к) фасцикулярные подергивания:

!а, б, в, е, ж, з

!+г, д, е, и, к

!а, б, г, е, ж, з

!в, д, е, и, к

?Какие из перечисленных признаков характерны для невральной амиотрофии Шарко-Мари: а) атрофии дистальных отделов ног, б) наследование по аутосомно-доминантному типу, в) начало в возрасте 50- 60 лет, г) возникновение заболевания в 18-25 лет, д) стопа Фридрейха, е) снижение и исчезновение сухожильных рефлексов, ж) повышение мышечного тонуса по типу экстрапирамидной ригидности, з) «шаркающая» походка, и) походка типа «степпаж», к) брадикинезия, л) дрожание в руках, м) фибриллярные подергивания:

!+а, б, г, д, е, и, м

!в, ж, з, к, л

!а, б, г, е, и, к, м

!в, д, ж, з, л

?Какие из перечисленных признаков характерны для болезни Паркинсона: а) атрофии дистальных отделов ног, б) наследование по аутосомно-доминантному типу, в) начало в возрасте 50- 60 лет, г) возникновение заболевания в 18-25 лет, д) стопа Фридрейха, е) снижение и исчезновение сухожильных рефлексов, ж) повышение мышечного тонуса по типу экстрапирамидной ригидности, з) «шаркающая» походка, и) походка типа «степпаж», к) брадикинезия, л) дрожание в руках, м) фибриллярные подергивания:

!а, б, г, д, е, и, м

!+в, ж, з, к, л

!а, б, г, е, и, к, м

!в, д, ж, з, л

?Больной Б., 51 года. Окружающие заметили, что он стал медлительным, голос приобрел монотонный оттенок, на вопросы начал отвечать медленно, изменилась походка (стал ходить медленными шажками), появилось дрожание пальцев рук. Заболевание прогрессировало, нарастала скованность. Объективно: лицо амимично, тонус мышц в руках и ногах повышен по пластическому типу. Почти постоянный мелкокоразмашистый тремор рук при произвольных движениях. Сухожильные рефлексы равномерны, повышены. Патологических рефлексов и расстройств чувствительности не выявляется. На ЭМГ - «залповая активность». Наследственность: у деда больного появилось дрожание конечностей, скованность движений в возрасте 60 лет. Установите диагноз.

!+болезнь Паркинсона

!невральная амиотрофия Шарко-Мари

!прогрессирующая мышечная дистрофия Эрба-Рота

!прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина

!болезнь двигательного нейрона

?Больной Б., 51 года. Окружающие заметили, что он стал медлительным, голос приобрел монотонный оттенок, на вопросы начал отвечать медленно, изменилась походка (стал ходить медленными шажками), появилось дрожание пальцев рук. Заболевание прогрессировало, нарастала скованность. Объективно: лицо амимично, тонус мышц в руках и ногах повышен по пластическому типу. Почти постоянный мелкокоразмашистый тремор рук при произвольных движениях. Сухожильные рефлексы равномерны, повышены. Патологических рефлексов и расстройств чувствительности не выявляется. На ЭМГ - «залповая активность». Наследственность: у деда больного появилось дрожание конечностей, скованность движений в возрасте 60 лет. Какое лечение предпочтительно проводить пациенту?

!+препараты левадопы

!препараты, улучшающие нервную проводимость

!кортикостероиды

?Больная, 25 лет. Стала замечать, что стопы «пришлѣпывают» при ходьбе. Появилась зябкость рук и ног. Затем обнаружила похудание мышц стоп, в дальнейшем мышц голеней. Через полгода присоединилось похудание мышц кистей рук и ограничение движений в пальцах. Объективно: кожа кистей рук и стоп мраморной окраски, холодная, на ощупь влажная, атрофия мышц стоп, голеней, дистальных отделов бедер и кистей рук. Рефлексы на руках снижены, на ногах: коленные рефлексы снижены, ахилловы рефлексы не вызываются. Гипестезия дистальных отделов конечностей. На ЭМГ - изменения, указывающие на поражение периферического двигательного нейрона. Установите диагноз.

!болезнь Паркинсона

!+невральная амиотрофия Шарко-Мари
!прогрессирующая мышечная дистрофия Эрба-Рота
!прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина
!болезнь двигательного нейрона

?Больная, 25 лет. Стала замечать, что стопы «пришлѣпывают» при ходьбе. Появилась зябкость рук и ног. Затем обнаружила похудание мышц стоп, в дальнейшем мышц голеней. Через полгода присоединилось похудание мышц кистей рук и ограничение движений в пальцах. Объективно: кожа кистей рук и стоп мраморной окраски, холодная, на ощупь влажная, атрофия мышц стоп, голеней, дистальных отделов бедер и кистей рук. Рефлексы на руках снижены, на ногах: коленные рефлексы снижены, ахилловы рефлексы не вызываются. Гипестезия дистальных отделов конечностей. На ЭМГ - изменения, указывающие на поражение периферического двигательного нейрона. Какое лечение предпочтительно проводить пациентке

!препараты левадопы

!+препараты, улучшающие нервную проводимость

!кортикостероиды

?Больная в возрасте 12-ти лет обратила внимание на то, что ей трудно бегать. Родители заметили, что походка у нее стала напоминать «утиную», что девочка ходит переваливаясь. Затем постепенно начала нарастать слабость в ногах, присоединилась слабость в мышцах рук и плечевого пояса (стало трудно запрокидывать руки за голову). Больная поступила в клинику в возрасте 22-х лет (в возрасте 12-ти и 14-ти была госпитализирована в детскую клинику) При осмотре: атрофия мышц лица (больная не может плотно закрыть глаза). С трудом, медленно встает со стула. Выявляется атрофия мышц плечевого пояса, рук, тазового пояса, спины, ног. Тонус мышц понижен. Сухожильные рефлексы на руках снижены, на ногах коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Расстройств чувствительности нет. На ЭМГ - снижение биопотенциалов мышц. Поставьте диагноз.

!болезнь Паркинсона

!невральная амиотрофия Шарко-Мари

!+прогрессирующая мышечная дистрофия Эрба-Рота

!прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина

!болезнь двигательного нейрона

?Больная в возрасте 12-ти лет обратила внимание на то, что ей трудно бегать. Родители заметили, что походка у нее стала напоминать «утиную», что девочка ходит переваливаясь. Затем постепенно начала нарастать слабость в ногах, присоединилась слабость в мышцах рук и плечевого пояса (стало трудно запрокидывать руки за голову). Больная поступила в клинику в возрасте 22-х лет (в возрасте 12-ти и 14-ти была госпитализирована в детскую клинику) При осмотре: атрофия мышц лица (больная не может плотно закрыть глаза). С трудом, медленно встает со стула. Выявляется атрофия мышц плечевого пояса, рук, тазового пояса, спины, ног. Тонус мышц понижен. Сухожильные рефлексы на руках снижены, на ногах коленные и ахилловы рефлексы отсутствуют. Расстройств чувствительности нет. На ЭМГ - снижение биопотенциалов мышц. Какое лечение предпочтительно проводить пациентке

!препараты левадопы

!+анаболические гормоны

!кортикостероиды

?Может ли быть непроизвольное мочеиспускание при простом парциальном припадке

!+нет

!да

?Имеется ли локальное начало у больных с первично-генерализованными припадками

!+нет

!да

?Может ли субарахноидальное кровоизлияние привести к возникновению эпилептических припадков?

!нет

!+да

?Может ли эпилептический припадок являться первым симптомом разрыва аневризмы головного мозга

!нет

!+да

?Может ли опухоль головного мозга явиться причиной развития эпилептических припадков?

!нет

!+да

?Какие типы парциальных припадков вы знаете

!+простой моторный припадок

!абсанс

!тонико-клонический припадок

?Какие типы парциальных припадков вы знаете

!+простой моторный припадок с вторичной генерализацией

!миоклонический припадок

!сложный абсанс

?При каких типах припадков не возникает утраты сознания

!тонико-клонические припадки

!+простые парциальные моторные

!клонические припадки

?Какими симптомами сопровождается простой моторный парциальный припадок

!утрата сознания

!+клонические судороги

!симметричные генерализованные судороги

?О поражении какой зоны головного мозга может свидетельствовать наличие у больного судорог в правой половине лица и руке

!+прецентральная извилина слева

!прецентральная извилина справа

!постцентральная извилина слева

!постцентральная извилина справа

?Какие из перечисленных феноменов на ЭЭГ характерны для абсансов?

!дизритмия

!+пик-волна с частотой 3 Гц/с

!острые волны

?Какие из перечисленных феноменов на ЭЭГ характерны для абсансов?

!дизритмия

!+пик-волна

!медленные волны

!фокус пароксизмальной активности

?При каких типах эпилептических припадков могут наблюдаться клонические односторонние судороги без утраты сознания

!+простые моторные парциальные припадки

!тонико-клонические припадки

!простые сенсорные парциальные припадки

!парциальные вторично-генерализованные припадки

?Какие из перечисленных симптомов характерны для простого моторного припадка:

!изменение сознания

!+односторонние судороги в конечностях без потери сознания

!наличие ауры

!феномен "дежа вю"

!наличие неприятного ощущения в эпигастрии в начале приступа

?Какие из перечисленных симптомов характерны для сложного парциального припадка:

!изменение сознания

!+феномен "дежа вю"

!паралич Тодда в начале припадка

?Какие из перечисленных симптомов характерны для эпилепсии лобной доли: а) приступы кратковременного головокружения б) судороги в одной половине лица и руке в) оперкулярные автоматизмы г) приступы измененного сознания д) адверсия глаз и головы е) обонятельные галлюцинации ж) искажение формы предметов з) слуховые галлюцинации и) кратковременность приступа:

!+б, д, е, и

!а, в, г, д, ж

!б, г, д, е, и

!а, в, д, ж

?Какие из перечисленных симптомов характерны для эпилепсии височной доли: а) приступы кратковременного головокружения б) судороги в одной половине лица и руке в) оперкулярные автоматизмы г) приступы измененного сознания д) адверсия глаз и головы е) обонятельные галлюцинации ж) искажение формы предметов з) слуховые галлюцинации и) кратковременность приступа:

!б, д, е, и

!+а, в, г, д, ж

!б, г, д, е, и

!а, в, д, ж

?Может ли быть аура при первично-генерализованных припадках

!+нет

!да

?Имеется ли локальное начало у больных с парциальными припадками

!нет

!+да

?Играет ли роль травматическое поражение головного мозга в генезе эпилепсии

!нет

!+да

?Характерно ли наличие судорог при абсансах

!+нет

!да

?Характерно ли наличие эпизодов измененного сознания для сложных парциальных припадков?

!нет

!+да

?Симптоматическая локально-обусловленная эпилепсия развивается в результате:

!+черепно-мозговой травмы

!рассеянного склероза

!прогрессирующей мышечной дистрофии Ландузи-Дежерина

?Симптоматическая локально-обусловленная эпилепсия развивается в результате:

!+нейроинфекции

!синдромомии

!болезни двигательного нейрона

?Симптоматическая локально-обусловленная эпилепсия развивается в результате:

!+сосудистых поражений головного мозга

!болезни Паркинсона

!невральной амиотрофии Шарко-Мари

?Чем характеризуются проявления абсансного припадка

!наличие ауры

!+внезапное начало

!длительность более 3 минут

?Чем характеризуются проявления абсансного припадка

!+незначительная продолжительность

!возникает чаще у взрослых

!происходит на фоне неизмененного сознания

?Чем характеризуются проявления абсансного припадка

!утрата сознания

!+быстрое восстановление сознания

!характеризуется двигательными автоматизмами

?Чем характеризуются проявления сложного парциального припадка

!+длительность более 3 минут

!чаще возникает в детском возрасте

!отсутствие ауры

?Чем характеризуются проявления сложного парциального припадка

!+наличие ауры

!внезапное начало

!незначительная продолжительность

?Чем характеризуются проявления сложного парциального припадка

!+утрата сознания

!быстрое восстановление сознания

!происходит на фоне неизмененного сознания

?Во время генерализованного припадка изменения со стороны зрачков характеризуется:

!анизокорией

!сужением

!+расширением

?Какие из перечисленных типов припадков относятся к парциальным припадкам:

!+простые моторные припадки

!тонико-клонические припадки

!абсансные припадки

?Какие из перечисленных типов припадков относятся к парциальным припадкам:

!атонические припадки

!+сложные парциальные припадки

!миоклонические припадки

?Какие из перечисленных типов припадков относятся к генерализованным припадкам:

!простые моторные припадки

!+тонико-клонические припадки

!сложные парциальные припадки

?Какие клинические особенности характерны для эпилепсии лобной доли: а) Кратковременность припадка, б) Сложные парциальные припадки, в) Вторичная генерализация, г) Различные сенсорные феномены, д) Двигательные проявления, е) Сложные автоматизмы с жестикуляцией, ж) Дерекализация, дезориентация, з) Различные психовегетативные феномены, и) Судороги в ноге. к) Судороги в половине лица, л) Оперкулярные автоматизмы, м) Слуховые галлюцинации:

!+а, в, д, е, и, к

!б, ж, з, л, м

!а, в, д, ж, и, л

!б, г, е, з, к, м

?Какие клинические особенности характерны для эпилепсии височной доли: а) Кратковременность припадка, б) Сложные парциальные припадки, в) Вторичная генерализация, г) Различные сенсорные феномены, д) Двигательные проявления, е) Сложные автоматизмы с жестикуляцией, ж) Дерекализация, дезориентация, з) Различные психовегетативные феномены, и) Судороги в ноге. к) Судороги в половине лица, л) Оперкулярные автоматизмы, м) Слуховые галлюцинации:

!а, в, д, е, и, к

!+б, ж, з, л, м

!а, в, д, ж, и, л

!б, г, е, з, к, м

?Могут ли быть вегетативные симптомы при вторично-генерализованном тонико-клоническом эпилептическом приступе

!нет

!+да

?Может ли субарахноидальное кровоизлияние дебютировать с эпилептического припадка

!нет

!+да

?Могут ли быть изменения психической сферы у больных эпилепсией

!нет

!+да

?Может ли быть сужение зрачков во время первично-генерализованного припадка

!+нет

!да

?Какие из перечисленных заболеваний могут осложняться эпилептическими припадками

!рассеянный склероз

!+ушиб головного мозга

!дрожательный паралич

?Какие из перечисленных заболеваний могут осложняться эпилептическими припадками

!+менингиты

!прогрессирующая мышечная дистрофия Ландузи-Дежерина

!невральная амиотрофия Шарко-Мари

?Какие из перечисленных заболеваний могут осложняться эпилептическими припадками

!+субарахноидальное кровоизлияние

!полиомиелит

!сирингомиелия

?Какие из перечисленных заболеваний могут осложняться эпилептическими припадками

!боковой амиотрофический склероз

!болезнь Паркинсона

!+ишемический инсульт

?Какие из перечисленных заболеваний могут осложняться эпилептическими припадками

!миелиты

!паралич Белла

!+энцефалиты

?В каком возрасте чаще всего впервые развивается идиопатическая эпилепсия

!+1-10 лет
!10-20 лет
!30-40 лет
!50-60 лет

?Сложные парциальные припадки отличаются от простых парциальных припадков:
!сочетанием моторной и сенсорной симптоматики
!сочетанием вегетативной и сенсорной симптоматики
!+изменением сознания

?Какой из перечисленных противоэpileптических препаратов является препаратом выбора для лечения первично-генерализованных припадков?
!финлепсин
!клоназепам
!+депакин
!фенобарбитал

?Какие припадки сопровождаются потерей сознания
!+тонико-клонические
!простые парциальные моторные
!сложные парциальные припадки

?Какие припадки сопровождаются потерей сознания
!простые парциальные сенсорные
!+атонические припадки
!миоклонические припадки

?Какие припадки не сопровождаются потерей сознания
!тонико-клонические
!+простые парциальные моторные
!абсансы

?Какие припадки не сопровождаются потерей сознания
!+сложные парциальные припадки
!атонические припадки
!парциальные с вторичной генерализацией

?Какие из перечисленных симптомов характерны для сложных парциальных припадков?
!+наличие ауры
!внезапное начало
!незначительная продолжительность

?Какие из перечисленных симптомов характерны для сложных парциальных припадков?
!отсутствие ауры
!быстрое восстановление сознания
!+состояние сонливости после припадка

?У больного начало припадка сопровождается ощущением покалывания, прохождения "электрического тока" по правым конечностям, затем происходит утрата сознания. Где находится очаг?

!+левая теменная доля
!правая теменная доля
!левая лобная доля
!правая лобная доля

?У больного начало припадка сопровождается ощущением покалывания, прохождения "электрического тока" по правым конечностям, затем происходит утрата сознания. Где находится очаг?

!прецентральная извилина
!+постцентральная извилина
!язычная извилина
!извилины морского конька
!поясная извилина

?У больного начало припадка сопровождается ощущением покалывания, прохождения "электрического тока" по правым конечностям, затем происходит утрата сознания. Тип припадка

!+парциальный припадок со вторичной генерализацией
!простой моторный парциальный припадок
!первично-генерализованный припадок
!простой сенсорный парциальный припадок

?У больного начало припадка сопровождается ощущением покалывания, прохождения "электрического тока" по правым конечностям, затем происходит утрата сознания. Какой препарат предпочтительнее применить

!вальпроаты
!фенобарбитал
!+финлепсин
!клоназепам

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Причина эпилептического синдрома

!причину определить невозможно
!субарахноидальное кровоизлияние
!острый геморрагический инсульт
!+перенесенный ишемический инсульт
!черепно-мозговая травма в анамнезе

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Тип эпилепсии

!+симптоматическая

!идиопатическая

!криптогенная

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. предположите локализацию очага.

!+лобная доля

!теменная доля

!затылочная доля

!височная доля

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Тип припадка

!парциальный припадок со вторичной генерализацией

!+простой моторный парциальный припадок

!первично-генерализованный припадок

!простой сенсорный парциальный припадок

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Локализация очага

!левая теменная доля

!правая теменная доля

!+левая лобная доля

!правая лобная доля

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Локализация очага

!+прецентральная извилина

!постцентральная извилина

!язычная извилина

!извилины морского конька

!поясная извилина

?Больной Л, 56 лет, отмечает периодические (1-2 раза в неделю) приступы судорог в правой ноге с распространением судорог на правую руку. Приступ длится 1-3 мин. Впервые приступы возникли 3 месяца назад. Примерно 6 месяцев назад больной перенес ишемический инсульт с легким правосторонним гемипарезом и последующим регрессом неврологической симптоматики. В неврологическом статусе отмечается поражение лицевого нерва справа по центральному типу, анизорефлексия D>S, рефлекс Бабинского справа. Какой противосудорожный препарат следует применять

!вальпроаты

!фенобарбитал

!+финлепсин

!клоназепам

?Больная 8 лет. Травму головы в анамнезе отрицает. В 3 летнем возрасте впервые появились приступы кратковременной потери сознания в виде застывания, без падения, с фиксацией взгляда и отсутствием реакции на внешние раздражители. Приступы кратковременные, длительность до 10 секунд. После приступа больная продолжает начатое действие. Приступы частые, до 5 раз в сутки. Тип эпилепсии

!симптоматическая

!+идиопатическая

!криптогенная

?Больная 8 лет. Травму головы в анамнезе отрицает. В 3 летнем возрасте впервые появились приступы кратковременной потери сознания в виде застывания, без падения, с фиксацией взгляда и отсутствием реакции на внешние раздражители. Приступы кратковременные, длительность до 10 секунд. После приступа больная продолжает начатое действие. Приступы частые, до 5 раз в сутки. Тип припадка

!парциальный припадок со вторичной генерализацией

!простой моторный парциальный припадок

!+первично-генерализованный припадок

!простой сенсорный парциальный припадок

?Больная 8 лет. Травму головы в анамнезе отрицает. В 3 летнем возрасте впервые появились приступы кратковременной потери сознания в виде застывания, без падения, с фиксацией взгляда и отсутствием реакции на внешние раздражители. Приступы кратковременные, длительность до 10 секунд. После приступа больная продолжает начатое действие. Приступы частые, до 5 раз в сутки. Тип припадка

!миоклонический припадок

!атонический припадок

!+абсанс

!простой сенсорный парциальный припадок

?Больная 8 лет. Травму головы в анамнезе отрицает. В 3 летнем возрасте впервые появились приступы кратковременной потери сознания в виде застывания, без падения, с фиксацией взгляда и отсутствием реакции на внешние раздражители. Приступы кратковременные, длительность до 10 секунд. После приступа больная продолжает начатое действие. Приступы частые, до 5 раз в сутки. Какой противосудорожный препарат следует применять

!+вальпроаты

!фенобарбитал

!финлепсин

!клоназепам

?Ребенок, 5 лет, во время игры внезапно замирает, взгляд останавливается на несколько секунд, в течение дня отмечается несколько аналогичных приступов. Тип эпилепсии

!симптоматическая

!+идиопатическая

!криптогенная

?Ребенок, 5 лет, во время игры внезапно замирает, взгляд останавливается на несколько секунд, в течение дня отмечается несколько аналогичных приступов. Тип припадков

!парциальный припадок со вторичной генерализацией

!простой моторный парциальный припадок

!+первично-генерализованный припадок

!простой сенсорный парциальный припадок

?Ребенок, 5 лет, во время игры внезапно замирает, взгляд останавливается на несколько секунд, в течение дня отмечается несколько аналогичных приступов. Тип припадков

!миоклонический припадок

!атонический припадок

!+абсанс

!простой сенсорный парциальный припадок

?Ребенок, 5 лет, во время игры внезапно замирает, взгляд останавливается на несколько секунд, в течение дня отмечается несколько аналогичных приступов. Какой противосудорожный препарат следует применять

!+вальпроаты

!фенобарбитал

!финлепсин

!клоназепам

?Ребенок, 5 лет, во время игры внезапно замирает, взгляд останавливается на несколько секунд, в течение дня отмечается несколько аналогичных приступов. Какой противосудорожный препарат следует применять

!+этосуксимид

!фенобарбитал

!карбамазепин

!клоназепам

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Причина эпилептического синдрома

!причину определить невозможно

!субарахноидальное кровоизлияние

!острый геморрагический инсульт

!перенесенный ишемический инсульт

!+черепно-мозговая травма в анамнезе

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Тип эпилепсии

!+симптоматическая

!идиопатическая

!криптогенная

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Тип припадков

!+парциальный припадок со вторичной генерализацией

!простой моторный парциальный припадок

!первично-генерализованный припадок

!простой сенсорный парциальный припадок

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Тип припадков

!миоклонический припадок

!атонический припадок

!+парциальный припадок со вторичной генерализацией

!простой парциальный припадок

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Какой противосудорожный препарат следует применять

!этосуксимид

!фенобарбитал

!+карбамазепин

!вльпроаты

?Больная 25 лет, через год после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (по данным КТ - ушиб головного мозга), днем на занятиях в институте

почувствовала, что голову потянуло влево, затем больная ничего не помнит. Со слов остальных студентов, больная потеряла сознание, отмечались судороги в конечностях, больше выраженные в левых конечностях, отмечалось непроизвольное мочеиспускание и прикус языка. В последующие 3 месяца наблюдался еще один подобный припадок. Какой противосудорожный препарат следует применять

!вальпроаты

!этосуксимид

!+финлепсин

!клоназепам